GUÍAS DE CRITERIOS DE REFERENCIA DEL I AL II NIVEL DE ATENCIÓN

GERENCIA MÉDICA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DIRECCIÓN REGIONAL SERVICIOS DE SALUD HUÉTAR ATLÁNTICA

Caja Costarricense de Seguro Social





Índice

Contenido

Acrónimos 4
Colaboradores 6
Prólogo 10
Antecedentes 10
Metodología 11
GUÍAS DE CRITERIOS DE REFERENCIA DEL I AL II NIVEL DE ATENCIÓN 14
ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA 15
ESPECIALIDAD DE CIRUGIA GENERAL 22
ESPECIALIDAD DE CIRUGIA PEDIATRICA 28
CLINICA DE MAMAS 36
ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA 40
EISAM 48
ESPECIALIDAD DE FISIATRIA 52
ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA 63
ESPECIALIDAD DE GERIATRIA 81
ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 105
ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA 116
ESPECIALIDAD DE MEDICINA PALIATIVA Y CONTROL DEL DOLOR 129
ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA 136
ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 141

ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA....162
ESPECIALIDAD DE ONCOLOGIA....174
ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA....183
ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA....192
ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA....199
ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA....212
SERVICIO DE RADIOLOGIA e IMÁGENES MÉDICAS....220
ESPECIALIDAD TRABAJO SOCIAL....240
ESPECIALIDAD DE UROLOGIA....253
ESPECIALIDAD DE VASCULAR PERIFERICO....262

Acrónimos

Siglas	*Significado*
HTA	Hipertensión arterial
DM	Diabetes mellitus
ICC	Insuficiencia cardiaca congestiva
BIRADS	*Breast Imaging Reporting and Data System*
EGO	Examen general de orina
PFT	Pruebas de función tiroidea
BUN	Nitrógeno ureico
PFR	Pruebas de función renal
PFH	Pruebas de función hepática
TGO	Transaminasa glutámico-oxalacetica
FA	Fosfatasa alcalina
GGT	Gamma glutamil transpeptidasa
TGP	Glutamato piruvato transaminasa
HIV	Virus de inmunodeficiencia humana
RH	Factor RH /proteína de membrana
BAAF	Biopsia por aguja fina
US	Ultrasonido
VDRL	*Venereal disease research laboratory*
TORCH	Toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes simples, HIV
ISRS	Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina
ATC	Antidepresivos tricíclicos
TCC	Terapia conductivo conductual
TIP	Psicoterapia interpersonal
OH	Alcohol
TDAH	Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
MhGAP	Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental
NYHA	*New York Heart Association*
SIDA	Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida
TP	Tiempo de protrombina
TPT	Tiempo parcial de tromboplastina
IBP	Inhibidores de bomba de protones
TAC	Tomografía axial computarizada
TSH	Hormona estimulante tiroidea

VES	Velocidad de eritrosedimentación
T3	Triyodotironina
T4	Tiroxina
FOBT	Sangre oculta en heces
FAN	Fluorescencia de anticuerpos antinucleares
EKG	Electrocardiograma
HCG	Gonadotropina coriónica humana
HB	Hemoglobina
SUA	Sangrado uterino anormal
INR	International Normalized Ratio
ACO	Anticonceptivos orales
AINES	Antiinflamatorios no esteroideos
PCO	Poliquistosis ovárica
PCR	Proteína c reactiva
APP	Amenaza de parto pretérmino
EPI	Enfermedad pélvica inflamatoria
DMG	Diabetes mellitus gestacional
FCF	Frecuencia cardiaca fetal
DHL	Deshidrogenasa láctica
IMC	Índice de masa corporal
CHO	Carbohidratos
ARO	Alto riesgo obstétrico
PTU	Propiltiuracilo
EAP	Edema agudo pulmón
EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
AEC	Aclaramiento endógeno creatinina
FSH	Hormona folículo estimulante
LH	Hormona luteinizante
CMV	Citomegalovirus
EBV	Virus Epstein Barr
RGE	Reflujo gastroesofágico
MGR	Morfología glóbulo rojo
APE	Antígeno prostático específico
PSA	*Prostate Specific Antigen*
TR	Tacto rectal
LUTS	*Lower Urinary Tract Symptoms*

Colaboradores

Grupo Conductor

Dra. María del Rocío Sánchez Montero, **Directora Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud**

Dr. Wilman Rojas Molina, **Director Regional, Red Integrada Servicios de Salud Huétar Atlántica**

Grupo Ejecutor

Dr. Alfred Graze Saborio, **Médico Asistente de Dirección, Red Integrada Servicios de Salud Huétar Atlántica**

Dr. Fredd Morales Picado, **Médico Asistente de Dirección, Red Integrada Servicios de Salud Huétar Atlántica**

Dra. Silene Aguilar Orias, **Médico Asistente de Dirección, Red Integrada Servicios de Salud Huétar Atlántica**

Grupo Facilitador

Dr. Randall Álvarez Juárez, **Director General, Hospital Monseñor Sanabria**

Dr. Mark Thomas García, **Jefatura de Consulta Externa, Hospital Monseñor Sanabria**

Dr. Carlos Algandona Castañeda, **Coordinador EDUS, Hospital Monseñor Sanabria**

Dr. David Monge Duran, **Enlace Regional EDUS-DRSS Pacifico Central**

Dr. Felipe Quesada, **Medico Asistente General, Área de Salud Monteverde**

Dra. Iliana Musa Mirabal, **Directora General, Hospital de Guápiles**

Dra. Cindy Núñez Milgram, **Jefatura de Consulta Externa, Hospital de Guápiles**

Dr. Daver Vidal Romero, **Director General, Hospital Dr. Tony Facio Castro**

Dra. Milesca Acon Chen, **Jefatura de Consulta Externa, Hospital Dr. Tony Facio Castro**

Lic. Teofanis Arceyut Hernández, **Jefatura de REDES, Hospital Dr. Tony Facio Castro**

Grupo de Expertos

CARDIOLOGÍA

Dr. Muñoz Caldas, HTFC

Dr. José Navarrete Pérez, HTFC

CIRUGIA GENERAL

Dr. Mario Rivera Castillo, HMS

Dr. Alejandro Alberto Magaña Aguilar, HG

Dr. Giovanni Herrera Mora, HTFC

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Julio Molina Arias, HTFC

CLINICA DE MAMAS

Dr. Mario Rivera Castillo, HMS

Dr. Marco Tulio Sánchez Rojas, HG

CLINICA DEL DOLOR

Dra. Hazel Rojas Jiménez, HG

Dra. Silvia Marcela Chavarría Díaz, HTFC

DERMATOLOGÍA

Dra. Daniela Ruiz Guzmán, HTFC

EISAM

Grupo multidisciplinario EISAM, HTFC

FISIATRIA

Dr. Luis Diego Rojas Araya, HTFC

GASTROENTEROLOGÍA

Dr. Mario Láscares, HG

Dr. Alexander Cordero, HTFC

Dra. Mónica Guillen, HMS

Dra. Daniela Hernández Castro, HG

GERIATRÍA

Dr. Aron Alonso Cornavaca Méndez, HG

Dra. Karla Araya Aguilar, HTFC

Dra. Laura Barrantes Zúñiga, HTFC

GINECOOBSTETRICIA

Dr. Manuel Adrián Murguía Ward, HG

Dra. Cindy Tashanni Earl Brown, HTFC

MEDICINA FAMILIAR

Dr. Guillermo Cubillo, AST

Dra. Susana Ávila Hernández, AST

Dra. Teresita Medrano Canales, HG

Dr. Francisco Ortiz Vargas, CASI Siquirres

MEDICINA INTERNA

Dr. Luis A. Espinoza Espinoza, HTFC

Dr. Lázaro De Armas, HG

NEUROLOGÍA

Dr. Eduardo Elizalde Agüero, HTFC

ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA

Dr. Carlomagno Santiesteban A, DRSSHA

Dr. Carlos Sequeira Campbell, CAIS Siquirres

Dr. Daniel Ramírez Acuña, HTFC

Dr. Roberto Beckford Taylor, HTFC

Dra. Ana Magaly Agüero García, HTFC

OFTALMOLOGÍA

Dr. Gabriel Rodríguez Vargas, HG

Dra. Teresa Ros Álvarez, HTFC

ORL

Dr. Jairo Gerardo Cordero Chen, HTFC

Dr. Pablo Agüero Rojas, HG

ORTOPEDIA

Dr. Roberto José Rivero Rogert, HG

Dra. Francis Arena Molina, HTFC

PEDIATRÍA

Dra. Adriana Rojas, HMS

Dr. Carlos Marín Monge, HG

Dra. Karol Susana Acevedo Viales, HTFC

PSIQUIATRIA

Dr. Hilberto Reid Satchwell, HTFC

Dr. Osvaldo Farías Garita, HTFC

TRABAJO SOCIAL

Licda. Dixia Rosales Ruiz. HTFC.

Licda. Katherine Cordero Martines. HG

Licda. Katherine Ordoñez Sanchez. ASL

Licda. Deyanira Quesada Ruiz. ASS

Licda. Johana Yep Duran. ASVE

Licda. Grettel Alvarado Agüero. ASM

Licda. Flora Sanchez Sáenz. AST

Licda. Carolina Dennis Rodolfo. ASG

Licda. Iliana Marín Vega. ASC

Licda. Yendry Marchena Vásquez. ASG.

Licda. Mayra Pérez Chaves. DRIPSSHA

UROLOGÍA

Dr. Héctor Robles Acosta, HTFC

VASCULAR PERIFERICO

Dr. Rubén Eduardo Zeledón Chin, HTFC

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Prólogo

El presente documento es una herramienta de apoyo para el primer y segundo nivel de atención y conlleva la recopilación de los criterios de referencia de los especialistas de los hospitales de la Región Huétar Atlántica con la colaboración de especialistas del Hospital Monseñor Sanabria. Las patologías detalladas en cada apartado son aquellas que los nosocomios de la red consideran estadísticamente de mayor relevancia en la Consulta Externa. Esta guía de criterios de referencia es un esfuerzo por parte de la Gerencia Médica, Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud, Dirección Regional Servicios de Salud Huétar Atlántica y especialistas de la Región y apoyo del H. Monseñor Sanabria

La presente guía deberá contar con una actualización cuatrienal para mantener una adecuada calidad de criterios médicos.

Antecedentes

En base a:

- Acuerdo de Junta Directiva, Acuerdo Primero, Artículo Cuarto, Sesión 8824, del 4 de febrero de 2016.
  " Aprobar los documentos Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud: Propuesta ajustada prueba de campo y Perfil de proyecto de validación de la propuesta de fortalecimiento de servicios de salud de la Caja. Estos documentos deberán ser el referente para las acciones desarrolladas por los diferentes grupos de trabajo relacionados con la prestación de servicio de salud…".

En donde se acuerda que la Región Huetar Atlántica sea el área demostrativa para la conformación de redes integradas dentro de los criterios y atributos de una red, el sistema de referencias y contrarreferencias es la columna vertebral de los mecanismos de coordinación asistencial y las guías de criterios de referencia del I al II nivel permiten la unificación u homologación del sistema de referencias.

- **Oficios de la Gerencia Médica y Dirección de Proyecto Fortalecimiento**

En seguimiento al oficio PFPSS-0240-2017, suscrito por la Dra. María del Rocío Sánchez Montero, directora PFPSS, con fecha del 18 de setiembre del 2017, la Gerencia Médica en el oficio GM-S-29385-2017, fechado del 21 de setiembre de 2017, se avala la implementación y utilización de las guías de criterios de referencia del I al II nivel de atención y se instruye además, la puesta en marcha de un plan piloto en la Red Integrada Servicios

de Salud Huetar Atlántica para el uso de las guías de criterios de referencia del I al II nivel de atención, como parte de la prueba de campo previo al proceso final de validación de las mismas.

En el oficio PFPSS-0250-2017, fechado del 25 de setiembre de 2018, la Dra. Sanchez Montero, solicita al Dr Wilman Rojas Molina, Director Regional, solicita que se realicen las acciones necesarias para la capacitación del personal médico de las áreas de la salud en cuanto a la utilización de las guías de criterios de referencia del I al II nivel.

Metodología

Este documento fue orientado para lograr la optimización y mejora de la calidad de las referencias del primer nivel al segundo nivel, mediante la homologación de criterios, ya establecidos por los especialistas para definir la aceptación o no de un caso en los nosocomios de la región. Esta herramienta fue creada como un apoyo al ejercicio del médico general y debe utilizarse como una guía para la correcta transferencia de pacientes entre estos niveles.

Actualmente, cuando un caso es referido a especialidad sufre un proceso complejo de espera para su atención y una vez superado el tiempo de espera, son atendidos en un nivel superior, pero son devueltos al primer nivel por falta de requisitos para su consulta. La finalidad de esta guía fue visualizada hacia la atención oportuna de los usuarios, con elementos concretos y completos para la atención en un segundo nivel, según la especialidad a la que es referido un usuario. De igual manera esta guía busca apoyar a los médicos, en el entendimiento de que la homologación de criterios en una red de servicios de salud facilita la comunicación técnica entre colegas y hace más eficiente el manejo en conjunto de las patologías.

Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto es un proceso de continua mejora. Las guías de criterios de referencia deben ser dinámicas y estar en continua revisión y actualización para que continúe siendo una herramienta útil y efectiva.

Las acciones tomadas para la elaboración de las presentes guías se detallan a continuación:

1. Coordinación de reunión gerencial con las jefaturas de los nosocomios de la región, para iniciar el proceso del proyecto de guías de criterios de referencia. Se les indica a la Jefatura de Consulta Externa y Jefatura de Registros y Estadísticas en Salud que deben traer información detallada sobre las patologías más frecuentemente referidas a la Consulta Externa, por especialidad.

2. Realización de dicha reunión gerencial donde se discutió la problemática en relación con las referencias por parte del primer nivel de atención y el impacto que esto genera a la lista de espera por especialidad a la consulta. Posteriormente se analizó la información estadística para detallar las patologías con las cuales se trabajaría por especialidad.

3. Elaboración de una matriz como herramienta de trabajo, para la homologación de los resultados en las mesas de trabajo a futuro, con los médicos especialistas.

4. Sesión de trabajo con el Hospital Monseñor Sanabria (HMS) con la ayuda de la Dirección General, Jefatura de Consulta Externa, Administrador Local del EDUS del nosocomio y los diversos especialistas del hospital. En dicha mesa de trabajo se analizaron las guías de referencia del hospital las cuales servirían de base para el proyecto. Posteriormente se recopilan las guías de referencia de los nosocomios de la región para unificarlas con las del HMS.

5. En aras de ser más eficientes, se decidió trabajar en base a la homologación de las guías existentes. En preparación a las reuniones con los médicos especialistas de los centros de salud de la región se prepararon documentos de guías de criterios de referencia por especialidad con la información recopilada anteriormente con lo cual facilitó la revisión de los mismos y su confección.

6. Se coordinó con antelación cada mesa de trabajo con los especialistas, realizándose a lo largo de los meses de agosto y setiembre del 2017. En cada reunión los especialistas ratificaban la homologación previamente realizada e intervenían brindando mayor detalle y expandiendo sobre la matriz de trabajo.

7. Revisión y confección final de las matrices realizados en las mesas de trabajo con los especialistas, por parte del grupo ejecutor.

8. Se solicita el aval para su implementación de las presentes Guías por parte de la Gerencia Médica y del Proyecto de Fortalecimiento

9. Se socializan las guías a todas las unidades programáticas, dando inicio al uso de las guías

10. Se realiza monitoreo de uso de las guías y su cumplimiento.

11. Se realiza nueva revisión de las guías con los filtradores de referencias de las unidades y con especialistas, se hacen nuevas observaciones que se realizan al documento y se concluye como versión final, el cual se remite a la Gerencia Médica para su respectivo análisis y oficialización posterior.

12. Se realizan actualizaciones de las guías conforme necesidades y disciplinas o especialidades que se incorporan a la Red.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUÍAS DE CRITERIOS DE REFERENCIA DEL I AL II NIVEL DE ATENCIÓN

Elaborado por:

- Hospital de Guápiles
- Hospital Dr. Tony Facio Castro
- CAIS de Siquirres
- Hospital Monseñor Sanabria
- Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica
- Especialidades y disciplinas existentes en el primer nivel

Simbología

Rojo: Requisito Obligatorio

Verde: Requisito Deseable

Morado: Pendiente Mayor Consenso entre Especialistas

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergias a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo

3. Se debe describir y **adjuntar EKG**
4. **Rx de Tórax** (NO es necesario el reporte).
5. **Se pueden gestionar por redes las copia de los reportes de laboratorio**
6. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente**. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.
7. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**
8. **Los considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.**

9. Historia de tratamiento crónico completo con dosis y frecuencia; y si ha tenido control previo con cardiología y su historial.

Patologías consideradas como Emergencias **<u>Deberán ser referidas al Servicio de Urgencias</u>**	➢ HTA- DM o pacientes sin estos trastornos con: • Angor • ICC descompensada – Edema Agudo de Pulmón • Infarto Agudo de Miocardio ➢ Trastorno del ritmo cardiaco con • FC > 100 latidos por minuto • FC < 40 latidos por minuto ➢ Sincope

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Criterios de Referencia a Consulta Externa

Patología	Criterio de referencia	Priorización	Exámenes previos	Observaciones
Arritmia Cardiaca	Todos los casos deben ser evaluados por la Consulta Externa de Cardiología cuando no exista una etiología tratable por el I nivel de atención. Pacientes con marcapasos	A cupo	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	Enviar a pacientes con EKG con sintomatología de Sd. de Brugrada o pre excitación

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Priorización	Exámenes previos	Observaciones
Disnea	Disnea de causa comprobada o probable de etiología cardiogénica Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía valvular, congénita o por tromboembolismo pulmonar	A cupo	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	Enviar a pacientes con disnea sin causa aparente para ser estudiados.
Dolor precordial	Dolor torácico no relacionado con patología osteomuscular. REFERIR AL SERVICIO DE URGENCIAS: Dolores precordiales agudos.	A cupo	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Priorización	Exámenes previos	Observaciones
Hipertensión Arterial	HTA de difícil control HTA Complicada HTA con Comorbilidades (ICC, Cardiopatía coronaria, alto riesgo coronario, trastornos del ritmo, cardiopatía congénita)	A cupo	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	
Miocardiopatías	Miocardiopatía dilatada Miocardiopatía hipertrófica Otras miocardiopatías Miocarditis Malformaciones congénitas Pacientes con cirugía cardiaca previa Pacientes con Enfermedad Pericárdica	A cupo Con prioridad miocardiopatías, pacientes con cx cardiacas previas y miocarditis	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Priorización	Exámenes previos	Observaciones
Enfermedad Arterial Coronaria	De primer diagnóstico Pacientes intervenidos Pacientes quirúrgicos Pacientes de Difícil Control	A la consulta externa con prioridad	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	
Síncope o Colapso	Sincope sin causa aparente Sincope de causa cardiogénica	A cupo	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Hb glicosilada (DM2)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **PF Hepática** **Electrolitos** **Ac Úrico** **P.F. Tiroidea** **EKG original (no el reporte)** **Rx PA Tórax**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE CIRUGIA GENERAL

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo
3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US).

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. **Los considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL CRITERIOS DE REFERENCIA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Vesícula y vías biliares	REFERIR A SERVICIO DE EMERGENCIAS: 1. dolor abdominal agudo 2. ictericia asociada 3. hidrops vesicular (dx por US) 4. lito enclavado (dx por US) Presencia de litiasis en la vesícula biliar con o sin síntomas, verificada por US (anotar el número de veces que ha reconsultado por la patología en el EBAIS). Los pólipos vesiculares se deben referir cuando su tamaño sea mayor a 10 mm (únicos) o cuando sean múltiples de cualquier tamaño. Si no cumplen con esta condición debe ser valorado por Medicina General con un ultrasonido anual.	Si se trata de un cuadro agudo el paciente se debe enviar a Servicio de Urgencias. Si el paciente se encuentra asintomático enviar a cupo Si se sospecha de neoplasia enviar como prioridad.	**Adjuntar reporte de ultrasonido (con fotos originales).** **Laboratorios: hemograma, pruebas de coagulación, grupo y RH, glicemia, PFR, PFH (bilirrubina total y fraccionada, TGO-TGP, FA, GGT) y amilasa.**	Toda referencia debe traer un reporte de ultrasonido de abdomen completo anexo (únicamente realizado por un radiólogo), no se aceptarán ultrasonidos pélvicos, ginecológicos o de vías urinarias que incidentalmente describan “hallazgo de colelitiasis” sin el detalle y descripción adecuados.
Dolor abdominal agudo	**REFERIR AL SERVICIO DE URGENCIAS**	Manejar como una emergencia	Estudio de laboratorio y gabinete con los que cuente.	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Patología	**Criterio de Referencia**	**Grado de prioridad**	**Requisitos y exámenes previos**	**Observaciones**
Dolor abdominal crónico	Paciente debería ser valorado por gastroenterología para su respectivo estudio.	Dependerá del diagnóstico.	Estudios pertinentes.	
Enfermedades de la glándula Tiroidea	Si hay sospecha de neoplasia o síntomas compresivos. Nódulo tiroideo mayor de 3cm (por mayor índice de malignidad). Bocio multinodular no compresivo debería verse por Medicina Interna.	Si hay malignidad demostrada se debe enviar como prioritario. Si es por compresión evidenciada por esofagograma debe ser priorizado.	**US Tiroideo** **Pruebas de Función tiroidea** **BAAF (Servicio de Radiología)**	Patología quirúrgica es manejada por ORL, Oncología o Cirugía General. **(HTFC solo Cirugía General)** Patologías malignas deberían ser referidas a Oncología. Nódulo de características sospechosas, mayor de 1 cm, realizar una BAAF.
Hernias	Enviar todo paciente cuyo diagnóstico sea evidente clínicamente.	REFERIR AL SERVICIO DE URGENCIAS: Encarcelamiento y/o estrangulamiento		El dolor inguinal (inguinodinia), no es una patología de resolución quirúrgica, por lo que no debe referirse, a menos que tenga un ultrasonido que demuestre una hernia. Diástasis de músculos rectos no es un diagnóstico de resolución quirúrgica por lo que no deben de referirse a este servicio. Los diagnósticos que incluyan afecciones de testículo deben ser

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
				referidos a Urología (varicocele, hidrocele, quiste de epidídimo, etc.); a menos que tenga un ultrasonido que demuestre una hernia.
Patología	**Criterio de Referencia**	**Grado de prioridad**	**Requisitos y exámenes previos**	**Observaciones**
Patología ano-rectal	Fisuras, fistulas ano rectal, hemorroides grado III y IV, deberían ser referidas al Servicio de Cirugía. Paciente sintomático o con patología ano-rectal refractaria a tratamiento convencional, debe ser referido a Gastroenterología. **(En HTFC a cirugía general)** Sospecha de neoplasia debería ser referidos concomitante a los Servicios de Cirugía y Gastroenterología (realización de endoscopia digestiva).	Prioridad en caso de sospecha de malignidad	**Tacto rectal** **Endoscopia digestiva baja es deseable**	Endoscopia digestiva baja es deseable, ésta no debería retrasar el abordaje del paciente si se palpa una masa con el tacto rectal.
Tumoraciones de Tejidos Blandos	Lesiones localizadas en lugares de difícil acceso o gran tamaño que no puedan ser resecadas en Cirugía Menor. Se debe referir al servicio todo lipoma mayor de 5 cm, adheridos a planos profundos en tórax y/o abdomen. Sospecha de tumoración que no impresiona lipoma para valoración	Prioridad en caso de alta sospecha de malignidad	**US tejidos blandos en lesiones sospechosas.**	Los lipomas mayores de 5 cm, adheridos a planos profundos, de extremidades se deben referir a Ortopedia. Se debe de referir todo lipoma de cuello independientemente del tamaño al Servicio de ORL.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Tumores de la Glándula Mamaria	Referir a Clínica de Mamas **(En HTFC Cirugía General)**	Prioridad en caso de sospecha de malignidad BIRADS 3 (a cupo) BIRADS 4 y 5 (prioridad)	**Mamografías** **US de mamas**	
Patología	**Criterio de Referencia**	**Grado de prioridad**	**Requisitos y exámenes previos**	**Observaciones**
Sospechas de Neoplasias del tubo Digestivo	Todo paciente con el diagnóstico comprobado debe de ser referido al Servicio de Cirugía y/u Oncología. **(En HTFC- servicio de cirugía o gastroenterología)**	Prioridad en caso de sospecha de malignidad	**Endoscopía** **Biopsia**	
Ginecomastia	Pacientes ≥ 16 años o que tengan más de 2 años con manifestaciones clínicamente significativas.	A cupo	**US de mamas**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE CIRUGIA PEDIATRICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.
2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US).

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. **Los considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.**

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	Grado de Prioridad	Exámenes previos	OBSERVACIONES
Hidrocele	Mejora solo. Referir para cirugía, si persiste sobre el año de edad.	A cupo	No requiere	No derivar antes del año de edad a no ser que sea sintomático (tenso, gigante) puede derivar a Hernia Inguinal. No hacer punción escrotal.
Quiste de Nuck	Referir para cirugía si persiste sobre el año de edad.	A cupo	No requiere	Se puede reabsorber espontáneamente, Hacer diagnóstico diferencial con hernia con ovario incluido.
Fimosis	Referir para cirugía si persiste sobre los dos años de edad.	A cupo	No requiere	Valorar circuncisión posterior y referir con prioridad si presenta membrana obliterante
Parafimosis	**Servicio de Urgencias**	**Urgente**	No requiere	No son necesarios masajes se puede utilizar esteroides tópicos solo aseo
Adherencias Bálano Prepuciales	Suelen mejorar solas	No referir	No requiere	Manejo del primer nivel

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	Grado de Prioridad	Exámenes previos	OBSERVACIONES
Hipospadias	Referir a urología al momento del diagnostico Se operan después de los 4 años	A cupo	No requiere	Valorar si presenta capuchón prepucial
Epispadias	Referir a urología al momento del diagnostico Se operan después de los 4 años	A cupo	No requiere	Valorar si presenta capuchón prepucial
Sinequia de Labios Menores	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	No requiere	Valorar tratamiento con estrógenos conjugados tópicos BID por 1 mes si se presenta falla terapéutica referir.
Himen Imperforado	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnostico	Con prioridad a consulta externa	No requiere	Debe contar con cita a un plazo no mayor 5 meses
Seno Urogenital Persistente	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnostico	Con prioridad a consulta externa	No requiere	Se habilitará dos cupos semanales para la inclusión de citas prioritarias, previamente coordinadas con médico especialista.
Absceso Perianal	Referir al momento del diagnostico	Con prioridad a la consulta externa	No requiere	Se habilitará dos cupos semanales para la inclusión de citas prioritarias, previamente coordinadas con médico especialista.
Fisura Anal	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnostico	Con prioridad a la consulta externa	No requiere	Se habilitará dos cupos semanales para la inclusión de citas prioritarias, previamente coordinadas con médico especialista.
Fístula Perianal	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnostico	Referir urgente a la consulta externa	No requiere	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	Grado de Prioridad	Exámenes previos	OBSERVACIONES
Pectus Escavatum	Referencia a cirugía pediátrica	Refiere a cupo consulta externa	No requiere	Se coordina cita al HNN cx tórax después de los 7 años por parte de cirugía pediátrica.
Pectus Carinatum	Referencia a cirugía pediátrica.	Referir a cupo a consulta externa	No requiere	Se coordina cita al HNN cx tórax después de los 7 años por parte de cirugía pediátrica.
Ginecomastia	Referir en periodo prepuberal con problemas psicológicos severos.	Cita a cupo	No requiere	Son operados posterior a los 12 años si son sintomáticos o por factores estéticos.
Quiste tirogloso	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnóstico	Cita con prioridad consulta externa	**US de cuello** **PFT**	Quirúrgico en el momento del diagnostico
Quistes fistulas senos arcos Branquiales	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnóstico	Con prioridad a consulta externa	No requiere	Pre auriculares se operan solamente si han presentado 1 o 2 episodios de sepsis
Adenopatías	Referir al Servicio de Pediatría	A cupo	No requiere	
Ránula	Referir a Cirugía Pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	No requiere	
Frenillo Sublingual Corto	Referir al momento del diagnostico	A cupo	No requiere	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	Grado de Prioridad	Exámenes previos	OBSERVACIONES
Frenillo Labio Superior	Referir al Servicio de Odontología	A cupo	No requiere	
Fistula Preauricular	Se refiere a Cirugía pediátrica únicamente si es sintomática la fistula; asintomática no se opera.	A cupo	No requiere	
Apéndice Preauricular	Referir a Cirugía pediátrica al momento del diagnóstico para cirugía cosmética	A cupo	No requiere	
Quiste Cola de la Ceja	Referir a Cirugía pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	No requiere	
Nevus	Referir al Servicio de Dermatología o cx pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	No requiere	Dar prioridad si son nevus en sitios de dorsiflexión
Hemangioma superficial	Referir al momento del diagnostico	Cupo	**US abdomen**	Se valorará en cita en clínica de malformaciones vasculares en HNN por parte de Cirugía Pediátrica. De ser rechazado la orden de ultrasonido por ser exclusivo de especialista, deberá el médico consignarlo en la referencia y adjuntar la boleta en donde le anotaron esto
Hemangioma Profundo	Referir a Cirugía pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	**US abdomen**	Se valorará en cita en clínica de malformaciones vasculares en HNN por parte de Cirugía Pediátrica. De ser rechazado la orden de ultrasonido por ser exclusivo de especialista, deberá el médico consignarlo en la referencia y adjuntar la boleta en donde le anotaron esto

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	Grado de Prioridad	Exámenes previos	OBSERVACIONES
Hemangioma Mixto	Referir a Cirugía pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	**US abdomen**	Se valorará en cita en clínica de malformaciones vasculares en HNN por parte de Cirugía Pediátrica. De ser rechazado la orden de ultrasonido por ser exclusivo de especialista, deberá el médico consignarlo en la referencia y adjuntar la boleta en donde le anotaron esto
Malformación Vascular	Referir a Cirugía pediátrica al momento del diagnostico	A cupo	**US abdomen**	Se valorará en cita en clínica de malformaciones vasculares en HNN por parte de Cirugía Pediátrica. De ser rechazado la orden de ultrasonido por ser exclusivo de especialista, deberá el médico consignarlo en la referencia y adjuntar la boleta en donde le anotaron esto
Craneosinostosis	Referir a Cirugía pediátrica o Neonatología al momento del parto.	Cita con prioridad		Se coordinará interconsulta con neurocirugía HNN. Previo a egreso del paciente, el médico especialista del II Nivel de atención coordina con el Médico especialista del III Nivel de atención.
Nódulos o masas subcutáneas	Referir a Cirugía pediátrica al momento del diagnóstico	Cita con prioridad consulta externa	No requiere	Debe recibir cita en un plazo no mayor a 3 meses.
Masa Abdominal	**Referir al Servicio de Urgencias**	Urgente	No requiere	
Constipación	Referir al Servicio de Pediatría	A cupo	No requiere	
Constipación del Lactante o mayor	Referir al Servicio de Pediatría	A cupo	No requiere	
Masa Torácica	**Referir al Servicio de Urgencias**	Urgente	No requiere	
Reflujo Gastroesofágico	Referir al Servicio de Pediatría	A cupo	No requiere	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	Grado de Prioridad	Exámenes previos	OBSERVACIONES
Dolor Abdominal Agudo	**Referir al Servicio de Urgencias**	Urgente	No requiere	
Dolor Abdominal Recurrente	Referir al Servicio de Pediatría	A cupo	No requiere	
Hemorragia Digestiva Baja	**Referir al Servicio de Urgencias**	Urgente	No requiere	
Hernia inguinal	Referir urgente al momento del diagnóstico	Cita a prioridad consulta externa	No requiere	Hernia inguinal diagnosticada = Hernia inguinal operada.
Criptorquidia	Referir antes de los 6 meses	Cita con prioridad antes de los 6 meses	**US de canal inguinal**	
Hernia umbilical	Referir después de los 5 años de edad	Cupo	No requiere	Recordar que son operados posterior a los 5 años de edad.
Varicocele	Referir a urología o cx pediátrica después de los 12 años	Cupo	No requiere	
Pilomatrixoma	Referir en el momento del diagnóstico	Prioridad consulta externa	No requiere	Se habilitará dos cupos semanales para la inclusión de citas prioritarias, previamente coordinadas con médico especialista.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

CLINICA DE MAMAS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Ginecológicos
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

4. MAMOGRAFIA Y US MAMAS documentos impresos como requisito adjuntados a referencia.

5. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

6. Incluir ginecomastia o masas en clínica de mamas

7. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Sospecha de CA de mama	Pacientes con Mamografía: • BIRADS 4 • BIRADS 5 • BIRADS 6	Con prioridad a la Consulta externa	**Mamografía** **US mamas**	Enviar reporte de ultrasonido, mamografía. Las placas debe traerlas la usuaria el día de la cita
Masas Mamarias: • **Fibroadenomas PALPABLES** • **Quistes mamarios mayores a 3 cm** • **Sospecha de papiloma intraductal**	Referir al momento de la sospecha diagnostica	Cupo	**Mamografías** **US MAMAS**	Enviar reporte de ultrasonido, mamografía. Las placas debe traerlas la usuaria el día de la cita

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Mastitis	Tratamiento del primer nivel, si presenta abscesos mamarios referir a urgencias	Urgente	US mamas	Anotar tratamiento ATB utilizados dosis y frecuencia. Referir con US a clínica de mamas para manejo definitivo
Secreciones anormales por pezón	Secreciones sanguinolentas Secreciones purulentas Galactorreas	Con prioridad	Mamografía **US mamas**	Realizar prolactina; si esta alterada referir a endocrinología Si es normal buscar causas secundarias, si además US o mamografía anormal referir a clínica de mamas.
Inversiones o retracciones del pezón	Congénita tamizar regularmente Adquirida: referir a clínica de mamas si presenta descamación, eccema, ulceración o cambios de coloración de las vías de carnificación sin otra explicación atribuible. Masa palpable	Con prioridad	Mamografía US mamas	Las agudas estudiar con prioridad
Cambios de la piel de la mama	Sospecha de CA inflamatorio	Prioridad 1	Mamografía	Tamizar y referir en caso necesario REALIZAR: Examen físico completo y mamografía a mayor de 40 años o US e menor de 40 años.
Mastalgias	Unilaterales no cíclicas que no responden a tratamiento analgésico		US mamas Mamografía	Si US o MAMOGRAFÍA con resultado BIRADS 1, 2 y 3. Tratar con aines y ante el fracaso referir a clínica de mamas.
Antecedente de CA de mama	Pacientes con seguimiento que supera los 10 años serán devueltas a EBAIS para vigilancia anual con mamografía.			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE DERMATOLOGIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.
2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
    - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
    - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
    - Antecedentes Heredofamiliares
    - Antecedentes Quirúrgicos
    - Examen físico completo enfatizando en exploración dermatológica de lesiones elementales y su descripción.

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. Topografía, morfología, evolución y síntomas asociados de las lesiones.

6. **Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.**

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE DERMATOLOGIA CRITERIOS DE REFERENCIA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
MELANOMA	Cualquier lesión pigmentada con dos o más criterios (ABCDE)	**Urgente**	No Requiere	Recordar el ABCDE DE LESIONES PIGMENTADAS anotar en referencia: Asimetría Bordes irregulares Color heterogéneo Diámetro mayor de punto 5 mm Evolución, elevación. AHF de melanoma en primer de consanguinidad

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
PSORIASIS	1. Porcentaje de extensión mayor la 10 %. 2. Mala respuesta al tratamiento tópico por 6 meses. 3. Piel cabelluda, pustulosa, palmo plantar, genital e inversa.	Criterio 1 y 2 a cupo Criterio 3 a prioridad	Ninguno	La referencia debe incluir los criterios expresados para justificar su envío. Así como el tratamiento utilizado y tiempo de duración.
CANCER NO MELANOMA (BASOCELULAR, EPIDERMOIDE)	Referir toda lesión nueva o antigua que se modifique: - Crecimiento - Sangrado - Cambio de color - Ulcerada en áreas foto-expuestas	Con prioridad Sospecha por clínica o biopsia	**Biopsia** (si se tiene enviar, pero que no retrase el envío del paciente)	Recordar el ABCDE DE LESIONES PIGMENTADAS anotar en referencia: Asimetría Bordes irregulares Color heterogéneo Diámetro mayor de punto 5 mm Evolución, elevación.
ÚLCERAS DE PIERNAS	Problema terapéutico, extensión, mala respuesta a tratamientos y úlceras grado 3 o 4, úlceras no venosas. **(En HTFC, las úlceras venosas, referir a vascular periférico)**	A cupo		Cada área debe tener recursos para curación y la debridación es de medico atención primaria
ONICOMICOSIS	Ante la sospecha clínica referir	A cupo	**Frotis y cultivo por hongos** **PFH**	
DERMATITIS SEBORREICA	Casos severos o sin respuesta al tratamiento después de 6 meses.	A cupo	VIH	Es un padecimiento crónico y recurrente de manejo por medicina general con champú de brea e hidrocortisona.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
DERMATITIS ATÓPICA	Casos severos con compromiso mayor al 10% superficie corporal total (SCT) o mala respuesta al tratamiento de al menos 3 meses	A Cupo		Es un padecimiento crónico, sólo se compensa, amerita seguimiento y tratamiento por largos periodos de tiempo y pacientes pediátricos deben ser valorados por pediatría previamente No utilizar esteroides sistémicos.
ERUPCIÓN CUTÁNEA AGUDA SEVERA	Menos de 4 semanas de evolución Muy sintomática Rápidamente progresiva Con erosión de piel y mucosas Sospecha de reacción medicamentosa.	Referir urgente a consulta externa.	Adjuntar laboratorios realizados	(tipo de tratamiento y duración)
ERUPCIÓN CUTÁNEA SUB AGUDA O CRÓNICA	Más de 4 semanas de evolución Rebelde a tratamiento Reagudización o muy sintomática	Prioridad	Adjuntar laboratorios realizados	(tipo de tratamiento y duración)
ERITRODERMIA	**REFERIR A SERVICIO DE URGENCIAS: eritema con mayor del 80 % de SCT**	Urgente	No requiere	Interconsulta a dermatología.
VERRUGAS VULGARES	NO referir excepto falla terapéutico o las muy severas de más de seis meses que ya se le haya realizado otros tratamientos	A cupo	**VDRL y HIV** (En casos de verrugas genitales)	Brindar otras opciones terapéuticas (ácido salicílico 25%) con previo curetaje y más de seis meses de evolución Previa educación y recomendaciones
HERPES ZOSTER	NO REFERIR			Patología de manejo en Medicina General, en todos casos si no pueden recetar Aciclovir enviar al servicio de emergencias en las primeras 72 hrs

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
LEISHMANIASIS	En caso de falla terapéutica.	A cupo	**Frotis por Leishmania** Reacción de Montenegro	Patología de manejo en Medicina General con al menos 40 ampollas de Glucantime
ALOPECIA	Únicamente con alopecia cicatrizal o con alopecia areata	A cupo	**Hemograma** **TSH**	NO Referir alopecia androgénica, ni efluvio telógeno post parto, ni efluvio anágeno post quimio terapia.
NEVOS	Cambios en el ABCDE Sospecha de neoplasia	A cupo		Evaluar según ABCDE de lesiones pigmentadas. No referir nevus para eliminación por razones estéticas.
CLOASMA O MELASMA	No referir por razones estéticas			Indagar sobre factores contribuyentes para eliminarlos (gestágenos orales) Recomendar la protección contra el sol.
ACNÉ	Referir casos de acné severo Inflamatorio Acné conglobata Acné fulminans Acné en mujer mayor de 24 años	A cupo	**Perfil lipídico** HCG sub B	Debe haber recibido al menos dos meses continuos de Doxiciclina 100mg BID y Peróxido de Benzoilo.
DERMATITIS POR ESTASIS	NO referir a Dermatología Referir a Vascular Periférico			Manejar en Medicina General, valorar los medicamentos fotosensibles bien documentados (IECA, diuréticos, ABT glibenclamida, etc.) ver grado insuficiencia venosa y hongos que potencialicen cuadro, previa educación de uso de medias elásticas o vendas elásticas bien colocadas

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
VITILIGO	Compromiso mayor al 5% de SCT, afectación en cara, tiempo menor de 2 años,	A cupo	Hemograma TSH	Lesiones pequeñas usar esteroides tópicos
TINEAS CORPORIS, PEDIS, INGUINAL	No referir Excepto falla terapéutica	A cupo	**Frotis y cultivo por hongos** **PFH**	Dar tratamiento con azolados tópicos y queratolíticos PRN.
PITIRIASIS VERSICOLOR	No referir Excepto falla terapéutica	A cupo	**Frotis y cultivo por hongos** **PFH**	Dar tratamiento con azolados tópicos y queratolíticos PRN.
PITIRIASIS ROSADA	Referir con falla terapéutica	A cupo		Dar tratamiento con antivirales, durante primeros brotes. Esteroides pueden prolongar cuadro.
PITIRIASIS ALBA (DA)	**No referir**			Foto protección y humectación: esteroides tópicos solo lesión. Educación

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
DERMATITIS DE CONTACTO	No referir excepto falla terapéutico o las muy severas que aun con la educación y recomendaciones de retirar posibles agentes	Cupo excepto que sea enfermedad laboral la cual se debe referir al INS	Examen directo y cultivo para descartar infección por hongos asociada	Lo más importante es la educación y recomendaciones sobre la patología, uso de esteroides tópicos por oclusión, jabón neutro, emolientes crema rosas y óxido de zinc
LENTIGOS SOLARES O PECAS SOLARES	No referir por razones estéticas solo referir los de sospecha de Léntigo maligno	Con prioridad		Su tratamiento es con foto-protección, educación y recomendaciones
QUERATOSIS ACTÍNICAS	Referir todos los casos	A cupo		Hacer diagnóstico diferencial con queratosis seborreicas
DIAGNOSTICOS IMPRECISOS	**NO referir pacientes sin una clara sospecha diagnóstica**			Todo paciente debe ser referido con una lógica impresión diagnostica. No referir con diagnósticos de LESIONES EN ESTUDIO o DERMATOSIS EN ESTUDIO
PATOLOGIAS DE RESOLUCION EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	Molusco contagioso Acrocordones Quistes epidérmicos Lipomas Angiomas Rubí Queratosis seborreicas Lentigo solar Melasma o cloasma Varicela no complicada Herpes simple o zoster Onicocriptosis Infección de piel y tejidos blandos no complicadas	**No referir**		Estas patologías pueden ser manejadas y resueltas en el primer nivel de atención.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
	Pediculosis y escabiasis Hiperplasias sebáceas Xantelasma			

CRITERIOS DE REFERENCIA

EISAM

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE EISAM

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso)

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. Enfatizar en buena historia clínica, medidas terapéuticas empleadas, medicamentos con frecuencia y dosis recibidos.

6. En casos de violencia, abuso o agresión realizar VE-01 y denuncia judicial.

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE EISAM CRITERIOS DE REFERENCIA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
• F.33.1 Trastorno depresivo recurrente episodio actual moderado • F.33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente remisión • F.33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes • F.34.1 Distimia • F.40 Trastornos de ansiedad fóbica • F. 40.0 Agorafobia • F.40.1 Fobias sociales • F.40.2 Fobias específicas (aisladas) • F.40.8 Otros trastornos de ansiedad fóbica • F. 41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) • F.41.1 Trastorno de Ansiedad Generalizada • F.41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo • F.41.3 Otros Trastornos mixtos de ansiedad • F.41.8 Otros Trastornos de ansiedad especificados		A cupo	**Orientados según patologías individualizadas de cada paciente**	Adjuntar historial de tratamientos con dosis y frecuencia utilizados Historia de medidas terapéuticas utilizadas En casos de violencia, abuso y agresión imprimir VE01, y anotar si se iniciaron las denuncias a los organismos correspondientes. Las personas usuarias con trastornos mentales y del

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
• F.43 Trastorno de Reacciones de estrés grave y adaptación • F.43.0 Reacción a estrés agudo • F.43.1 Trastorno de estrés post-traumático • F.43.2 Trastorno de adaptación • F.90 Trastorno hipercinéticos • F.90.0 Trastorno de la actividad y de la atención • F.90.8 Otros trastornos hipercinéticos • F1x.1 Consumo Perjudicial • F1x.2 Síndrome de Dependencia				comportamiento, así como patología dual requieren valoración previa de Psiquiatría según criterio profesional.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE FISIATRIA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE FISIATRIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

- Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
- Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
- Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
- Antecedentes Heredofamiliares
- Antecedentes Quirúrgicos
- Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US). Rayos X indispensable para valoración en la consulta. Paciente debe llevar placas.

4. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

5. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

6. La especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, comúnmente conocida como Fisiatría, es una especialidad médica que brinda apoyo a muchas otras especialidades. En su quehacer comprende: la atención y manejo de las personas con discapacidad, ya sea la discapacidad temporal o permanente y para cumplir con los artículos 33 y 34 de la ley 7600 debe ser oportuna y prioritaria para dicha población.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE FISIATRIA

Criterios de Referencia

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Parálisis Cerebral Infantil **Mielo meningocele** **AVC**	Referir pacientes • En fase aguda (primeros tres meses) • Subaguda (tres a seis meses) del evento Que puedan beneficiarse de un programa de rehabilitación. • Paciente en cualquier fase de evolución que necesite prescripción de ayudas técnicas y valoración de silla de ruedas.	A cupo pacientes crónicos Con prioridad pacientes con eventos agudos (Lo ideal es que el paciente con evento aguda salga del hospital con la cita coordinada	**Estudios realizados y tratamiento médico actual**	Se debe indicar en la referencia el tipo de AVC que sufrió el paciente, y su evolución.
Mal alineación de columna vertebral	Referir pacientes con sospecha diagnostica de mal alineación de CV	A cupo	Referir con radiografías	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Parálisis facial	Referir Parálisis facial si persisten luego de 12 semanas enviar a ORL o Fisiatría para valoración.	A cupo	No requiere	Considere iniciar manejo con esteroides; prednisolona 50mg por día por 10 días, parche ocular, lágrimas artificiales y ejercicios de mímica facial en casa, estas resuelven en un 95 % solas al cabo de tres meses
Artritis Reumatoide	• Referir aquellos pacientes con AR ya diagnosticados y con control por reumatología que presentan una limitación funcional que no existía previamente o que empeoró la actual. • Referir al paciente cuando requiera una valoración y mejoría de su capacidad funcional o independencia, si presenta contracturas articulares o estructuradas, si presentan algún defecto postural, si requieren algún aditamento especial (silla de ruedas, andadera, férulas, etc.)	Con prioridad: problemas de funcionalidad A cupo: necesidad de aditamentos	No requiere	La referencia debe incluir muy claramente la evolución de la enfermedad, la sintomatología, hallazgos en el examen físico, el tratamiento que usa y sobre todo el motivo de referencia.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Defecto postural	Niño con 3 años cumplidos. • Pies planos • Retropies supinados o pronados • Genum valgo • Genum varo • Intrarotación o extrarotación de caderas, • Hallux valgus • Acortamiento de miembros inferiores	A cupo	**Para acortamientos de miembros inferiores enviar RX de medición de miembros inferiores.** **En caso de dolor óseo enviar RX**	Se estará observando semestralmente con los zapatos, plantillas o aparatos enviados previamente. Manejo anual.
Dolor articular	Referir cualquier dolor articular que se presente en cualquiera de las siguientes articulaciones codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo que a pesar de tratamiento persiste con dolor, pero sobre todo con limitación funcional y repercusión en las actividades que realiza el paciente. Es muy importante que previo a la referencia la causa del dolor articular este claramente diagnosticada por el médico correspondiente. A todo dolor articular agudo postraumático debe ser valorado primero por Ortopedia.	A cupo	**Radiografía AP y lateral de la articulación afectada.** **US según corresponda**	Se debe tener muy claro que cuando se refiere un dolor articular al Servicio de Fisiatría no se debe hacer buscado que se diagnostique la causa del dolor sino con el objetivo de mejorar la capacidad funcional de esa articulación dañada, de ahí la importancia de conocer la causa pues de esta o una sospecha diagnostica. La referencia debe incluir los días de evolución, la sintomatología, hallazgos en el EF, el diagnóstico o sospecha diagnostica, el tratamiento recibido y el motivo de referencia. Debe traer las radiografías a la cita. Y/O ultrasonido o estudio complementario pertinente.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Dolor cervical	Referir a todo paciente con dolor cervical que no responde al tratamiento dado y que a la vez asocie limitación importante en la movilidad del cuello y con repercusión en las actividades de la vida diaria.	A cupo	Radiografías AP y lateral de columna cervical y oblicua.	La referencia debe describir claramente la sintomatología del paciente, hallazgos en el examen físico y neurológico, días de evolución, probable causa, tratamiento dado y motivo de la referencia. Debe traer las radiografías a la cita
Dolor lumbar con compromiso radicular o de tipo mecánico	El paciente debe ser referido si presenta un dolor lumbar con irradiación a uno o ambos miembros inferiores que no responde al tratamiento y que asocia dificultad para la marcha, alteración de la fuerza, la sensibilidad y/o los reflejos. Se recomienda tratamiento con analgésicos fijos por al menos 15 días y otros 15 días PRN, se debe asociar antidepresivo tricíclico tipo amitriptilina si no hay contraindicación dosis inicial 10 mg HS al menos 1 mes. No se valoran lumbalgias agudas solo de 3 a 6 meses de evolución	A cupo Si hay compromiso neurológico cita con prioridad Lumbalgias de más de 6 meses de evolución y paciente estudiado referir a escuela de espalda o servicio homólogo.	**A todo paciente se le debe realizar previamente radiografías AP y lateral de columna lumbosacra que incluyan la articulación coxo-femoral, incluir radiografías oblicuas si se sospecha estenosis de canal o espondilolistesis.**	La referencia debe escribir claramente: 1. Días de evolución sintomatología del paciente, hallazgos en el examen físico, probable etiología del proceso, el tratamiento recibido y las limitaciones que presenta el paciente para realizar sus actividades de la vida diaria. 2. Días de incapacidad. 3. El día de la cita el paciente debe traer las radiografías. Incluir en la referencia la valoración de la radiografía. 4. Incluir Examen neurológico completo y pruebas específicas. Revaloración del paciente en el 1er nivel. 5. Paciente masculino mayor de 60 años o banderas rojas a cualquier edad incluir marcadores inflamatorios y APE.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Enfermedades neurológicas	Referir en caso de que se necesite valorar y mejorar su capacidad funcional o independencia, si tiene contracturas articulares, si presenta algún defecto postural, si requiere algún aditamento especial (silla de ruedas, andadera, férulas, etc.). • AVC • Esclerosis Múltiple • Esclerosis Lateral Amiotrófica • Guillan Barre • traumas de cráneo • Parkinson • Distrofia muscular • Polineuropatías	Prioridad Si la evolución de la enfermedad es < 1 año A cupo Si la evolución de la enfermedad es > 1 año	No requiere	La referencia debe incluir la historia clínica del paciente, los hallazgos en el examen físico y explicar claramente el motivo de la referencia.
Escoliosis **De 0 a 18 años**	Niños con: 1. Algún grado de alteración en la simetría de la espalda. 2. Que tengan giba 3. Que se quejen de dolor de espalda.	A cupo	**RX AP y lateral de columna: desde C7 a crestas iliacas, si el paciente mide más de 1.60m realizar radiografías AP de caderas**	Manejo usual será entre una y dos veces al año. Traer RX con la Referencia. Curvas vertebrales mayores a 10 grados y con torsión vertebral Curvas mayores a 45 grados referir a Ortopedia.
Híper Cifosis **De 0 a 18 años**	Referir pacientes adolescentes con mediciones en RX lateral desde T5 a T12 de más de 40 grados en columna dorsal.	A cupo	**Radiografías AP y lateral que incluyan toda la columna toraco-lumbosacra para escoliosis y lateral de toda la columna torácica con**	La referencia debe incluir la historia clínica, debe describir claramente los grados de las curvas, los lados de la desviación y si hay o no rotación vertebral con base a la radiografía

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
			los brazos extendidos a 90° para cifosis.	Deben traer radiografía el día de la cita.
Hombro doloroso	Referir todo paciente que presente dolor en el hombro que no responde al tratamiento dado y que a la vez presente limitación importante de la movilidad del mismo con repercusión en las actividades de la vida diaria. Si el dolor es agudo descartar trauma con ortopedia. NO SE VALORAN OMALGIAS AGUDAS.	A cupo	**Radiografía AP y axial del hombro afectado.** **US si tiene**	La referencia debe describir claramente la sintomatología del paciente, hallazgos en el examen físico, días de evolución, probable causa, tratamiento dado y motivo de la referencia. Debe traer las radiografías el día de la cita. Dolor crónico y limitación importante de los arcos de movilidad del hombro. Rupturas completas de maguito rotador se refieren a ortopedia.
Retraso en el Desarrollo Psico-Motor (menores de 12 años)	Referir en caso de que se necesite valorar y mejorar su capacidad funcional o independencia. Referir si presenta contracturas articulares, si tiene escoliosis, si hay sospecha de broncoaspiración, si presenta algún defecto postural, si requiere algún aditamento	Prioridad	RX en caso de escoliosis	La referencia debe incluir la historia clínica del paciente, los hallazgos en el examen físico y explicar claramente el motivo de la referencia. El día de la cita el acompañante del paciente debe traer el libro azul del niño y de ser posible toda epicrisis ya sea de su nacimiento, de sus patologías de fondo, de

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
	especial (silla de ruedas, férulas, etc.)			procedimientos quirúrgicos y de internamientos.
Síndromes de atrapamiento de miembros superiores: nervio mediano, ulnar o radial. **Síndromes de atrapamiento de miembros inferiores: nervio peroneo, tibial, plantar interno, plantar externo y cutáneo femoral lateral.**	Sospecha clínica del atrapamiento de alguno de estos nervios.	A cupo	No requiere	Incluir examen físico, evolución, pruebas específicas para el nervio, ejemplo mediano, tinnell y phalen y flick.
Síndromes dolorosos de tejido blandos: tendinitis, bursitis, dolores musculares inespecíficos, síndromes miofasciales o fibromialgia.	Referir estas patologías solo si después del tratamiento no hay resolución del cuadro y asocian un deterioro funcional tal que limita las actividades diarias del paciente	A cupo	El paciente con fibromialgia debe tener FR, VES y PCR	La referencia debe incluir días de evolución, sintomatología, hallazgos en el examen físico, diagnóstico, tratamiento dado y motivo de la consulta. Localización anatómica o musculo afectado.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Amputados	Referir pacientes para terapia pre protésica cuando sea posible, educación en higiene del muñón y valoración de prótesis. Todo paciente amputado trans-femoral trans-tibial o amputaciones menores	A cupo	**Muñón doloroso traer Rx correspondiente**	Incluir historia Clínica, tiempo de evolución, historia quirúrgica y examen físico de miembro preferencial.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe estar orientada hacia una patología relacionada con el tubo digestivo y debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo.

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US).

4. Preparación para estudios endoscópicos. (según indicación del médico especialista una vez asignada la fecha del o los procedimientos a realizar).

- Gastroscopia: Debe presentarse con 8 horas de ayuno, debe presentarse a las 8:00am con acompañante
- Colonoscopia: Debe presentarse según protocolo adjunto en la especialidad.
- Rectoscopia: Debe presentarse según protocolo adjunto en la especialidad.

5. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Impresión diagnóstica clara por la cual se refiere a la persona, o diagnóstico cuando ya está establecido, la cual deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

6. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

7. Las siguientes patologías no corresponden a la especialidad de Gastroenterología, por lo que en caso de referencia serán rechazadas y devueltas al primer nivel:

    - Hernia Hiatal. Su manejo es del primer nivel. Si la hernia es mayor de 5 cm debe referirse a Cirugía General.
    - Ingesta de cáusticos. Su manejo es de Medicina Interna. Se refiere a emergencias, quienes solicitan gastroscopia.
    - Masa epigástrica según US o TAC. Debe referirse a Emergencias. No es de manejo de Gastroenterología.
    - Pérdida de peso en estudio. Normalmente no es de esta especialidad. Medicina Interna o Geriatría piden gastrocopia según necesidad.
    - Hemorroides. Corresponden a Cirugía general, cuando las medidas tradicionales para contrarrestar estreñimiento, cambios de dietas y tratamiento del primer nivel fallan.
    - Pancreatitis no biliar.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE REFERENCIA GASTROSCOPIAS DE RUTINA				
Pirosis / Reflujo	Ardor, quemadura retro esternal (*) Esofagitis grado C Y D - IBP doble dosis por Medicina Interna / Medicina Familiar/ Geriatría durante 8 semanas. Esofagitis A y B no amerita control endoscópico sólo manejo médico. (*) Casos refractarios al tratamiento indicado en el primer nivel de atención por espacio de 3 meses. (*) Deben tomar tratamiento en el 1er nivel de atención por 6 meses con Famotidina, Hidróxido de Aluminio y Simeticona/ Ciclos mensuales con metoclopramida. Modificación de estilo de vida y suspensión de alimentos irritantes de la mucosa gástrica. Si persiste con síntomas referir a gastroscopia.	Cita a cupo gastroenterología	No amerita	Adjuntar reporte y/o copia de Gastroscopia y Biopsia * Tratamiento indicado debe incluir uso de Anti-H2, antiácidos, y medidas no farmacológicas, como el cese del fumado, el licor y una dieta adecuada.
Disfagia ilógica	Referir ante la sintomatología, describir claramente Disfagia intermitente o disfagia a líquidos no a sólidos	Cupo a gastroscopia rutinaria	Esofagograma	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Síndrome Dispéptico	1. Referir para valoración ante la sospecha diagnostica y sintomatología de disconfort abdominal alto inespecífico, gastralgia, distensión. (*) 2. Personas menores de 40 años sin signos de alarma (anemia, masa palpable y/o pérdida de peso) considerar tratamiento. (*) 3. Si no hay respuesta al tratamiento médico solicitar Gastroscopia. (*) Deben tomar tratamiento en el 1er nivel de atención por 6 meses con Famotidina, Hidróxido de Aluminio y Simeticona/ Ciclos mensuales con metoclopramida. Modificación de estilo de vida y suspensión de alimentos irritantes de la mucosa gástrica. Si persiste con síntomas referir a gastroscopia.	Cupo a gastroscopia rutinaria (En relación al punto 3)	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas Incluir dentro del examen físico: Tacto rectal	1. Adjuntar reporte y/o copia de Gastroscopia y/o biopsia. 2. El tratamiento debe incluir el uso de Anti-H2, antiácidos, y medidas no farmacológicas, como el cese del fumado, el licor y una dieta adecuada. 3. La esofagitis grado A y B no amerita control endoscópico, sólo tratamiento médico.
Síndrome ulceroso Gástrico/duodenal	Dolor epigástrico tipo urente, que alivia o no al comer. Deben tomar tratamiento en el 1er nivel de atención por 6 meses con Famotidina, Hidróxido de Aluminio y Simeticona/ Ciclos mensuales con metoclopramida. Modificación de estilo de vida y suspensión de alimentos irritantes de la mucosa gástrica. Si persiste con síntomas referir a gastroscopia.	Cupo a gastroscopia rutinaria	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas. Incluir dentro del examen físico: Tacto rectal	Para ambas realizar endoscopia: Si el diagnóstico es úlcera gástrica: tratamiento y control endoscópico de 3 a 6 meses Si el diagnóstico es úlcera duodenal tratamiento médico con IBP. No amerita control endoscópico Si se confirma H. Pylori debe erradicarse
Perdidas de peso E/E	Pérdida de peso +10% y/o corroborada en dos visitas con un intervalo entre una y otra de 2 meses	Referir caso a Medicina Interna y/o Geriatría, quienes según la necesidad y evidencia clínica solicitarán estudio a gastroenterología. A menos que la pérdida de peso está asociada a tubo digestivo	-	-

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Síndrome anémico crónico o megaloblástico	Anemia microcítica - hipocrómica o megaloblástico en ausencia de sangrado visible	Cupo a gastroscopia rutinaria	Hemograma Completo, sangre oculta en heces	Control de acuerdo a hallazgo endoscópico.
Control de Displasia leve	Displasia leve	Cupo a gastroscopia rutinaria	Reporte de biopsia y reporte endoscópico	Tratamiento médico y control endoscópico al año
Gastritis crónica con metaplasia intestinal	Enviar con biopsia previa y con reporte endoscópico previo	Cupo a gastroenterología	Reporte de biopsia y reporte endoscópico	1. Sin Displasia: Control cada 3 años 2. Con Displasia leve: Control al año 3. Con Displasia severa: Control inmediato 4. Con metaplasia intestinal incompleta: Control cada 3 años 5. Con metaplasia intestinal completa: Control a los 3 años. Adjuntar reporte de biopsia y/o gastroscopia
Gastritis crónica sin metaplasia intestinal	Paciente con diagnóstico previo de gastritis crónica	Cupo a gastroenterología	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas	No amerita control endoscópico en pacientes menores de 40años. Pacientes mayores de 40años control cada 3años. Adjuntar reporte de biopsia y/o gastroscopia
Sangre Oculta (+)	Detección de sangre Oculta (+) en heces. En el caso de Guayaco +, se debe descartar falsos positivos, al menos dos positivos.	gastroscopia con prioridad	Hemograma completo, reporte sangre oculta positiva inmunológico o guayaco	Debe enviarse con prioridad. Si Gastroscopia es negativa completar estudio por sangrado digestivo bajo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Antecedente heredofamiliar Ca Gástrico 1er grado (padres y hermanos)	Historia clínica familiar (+) Mayor de 40 años	Cupo a gastroscopia rutinaria	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas	Si Gastroscopia es negativa control cada 3 años Si Gastroscopia es positiva control de acuerdo a hallazgos
Paciente con Hernia Hiatal	Diagnóstico por endoscopia o esofagograma. No amerita referencia para valoración en gastroenterología, sólo las hernias hiatales > 5 cm, deben referirse a cirugía general	-	-	Con Esofagitis (A y B) no amerita control endoscópico sólo Tx médico. Deben tomar tratamiento en el 1er nivel de atención por 6 meses con Famotidina, Hidróxido de Aluminio y Simeticona/ Ciclos mensuales con metoclopramida. Modificación de estilo de vida y suspensión de alimentos irritantes de la mucosa gástrica. Si persiste con síntomas referir a gastroscopia. Con Esofagitis (C y D) amerita tratamiento médico con IBP a doble dosis por 8 semanas.
CRITERIOS DE REFERENCIA GASTROSCOPIAS URGENTES/PRIORIDAD				
Disfagia lógica	Historia clínica de disfagia progresiva de sólidos a líquidos	Urgente a Gastroscopia/Prioridad	Esofagograma si se dispone	Referir con prioridad

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Ingesta de cáusticos dentro de primeras 24horas	Ingesta accidental por álcalis o ácidos fuertes	Referir a urgencias para Gastroscopia urgente. Su manejo es de Medicina Interna	Estudio debe realizarse en las PRIMERAS 24 HORAS	Debe de enviarse en ayunas Estudio contraindicado posterior a 24horas Debe de ser canalizado al Servicio de Emergencias
Masa epigástrica en estudio o evidenciada por US/TAC	Masa epigástrica a la exploración física, palpable o Diagnosticada por US/TAC.	Urgente a Emergencias	No amerita	Adjuntar reporte de TAC/ US.
Hematemesis	Vómito de sangre roja rutilante por historia clínica o presencial	Referir a servicio de EMERGENCIAS para valoración con Gastroscopia	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas	Enviar al servicio de emergencias
Síndrome Pilórico	Vómito postprandial tardío de contenido alimentario + pérdida de peso Historia clínica y exploración física adecuadas	Referir a servicio de EMERGENCIAS para valoración con Gastroscopia	No amerita	Debe enviarse con prioridad al Servicio de Emergencias
Melena	Deposiciones negras Tacto rectal (+) con heces de color negro-carbón y olor característico	Referir a servicio de EMERGENCIAS para valoración con Gastroscopia	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas	Debe enviarse al Servicio de emergencias
Síndrome anémico agudo	historia clínica más Caída brusca de hemoglobina, hematocrito acompañada de hematemesis y/o melena, hematoquexia	Referir a servicio de EMERGENCIAS para valoración con Gastroscopia	Hemograma completo, TP-TPT y plaquetas	Debe enviarse al Servicio de emergencias
Control Displasia severa	Antecedente. de displasia severa Biopsia previa diagnosticada con displasia de alto grado	Consulta externa con prioridad	Reporte de biopsia y reporte endoscópico	Se definirá conducta a seguir por parte de especialista.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Cuerpo extraño en esófago	Ingesta accidental o voluntaria de cuerpo extraño Ingesta de cuerpo extraño con sialorrea y disfagia	Referir a servicio de EMERGENCIAS para valoración con Gastroscopia	Estudio RX si se dispone	Debe enviarse en ayunas y debe canalizarse al Servicio de Emergencias
CRITERIOS DE REFERENCIA COLONOSCOPIA				
Sospecha de CA colorectal	1. Todo paciente con sospecha de Cáncer colorrectal. 2. Indispensable el Examen Físico y Tacto rectal. 3. Adjuntar en la referencia sobre los signos y síntomas que hagan sospechar la patología	Consulta externa con prioridad	Hemograma Sangre oculta (+)	EF y tacto rectal indispensable Adjuntar en referencia información veraz sobre signos y síntomas que hagan sospechar la patología.
AHF de CA de colon	Referir pacientes con AHF de primer grado de consanguinidad	Referir con prioridad para Colonoscopia	Hemograma Completo Sangre oculta positiva Colon/Enema si se dispone.	Inicio de estudio 10años previos a la edad de presentación de la enfermedad en el familiar O partir de los 40años
Adultos con rectorragia masiva	Referir de carácter urgente rectorragia masiva	Referir al Servicio de Emergencias	Hemograma Completo TP-TPT-plaquetas	Referir al Servicio de Emergencias para valoración por cirugía general, si se descarta patología quirúrgica aguda, se debe realizar interconsulta a Gastroenterología.
Alteración de estudio de Colon / Enema	Reporte radiológico de pólipos, estrechez o masa (adjuntar reporte)	Referir con prioridad para Colonoscopia	Reporte radiológico de colon por enema Hemograma Completo TP-TPT-plaquetas	Referir con prioridad.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Adenoma colorectal o pólipos resecados	Diagnostico endoscópico previo (adjuntar a la referencia el estudio, su interpretación y reporte de biopsia).	Consulta externa con prioridad	Adjuntar en la referencia el estudio anterior que lo diagnostica y biopsia Hemograma Completo TP-TPT-plaquetas	Referir con prioridad.
Poliposis familiar y pólipos adenomatosos	AHF de poliposis o diagnóstico de pólipos (adjuntar a la referencia el estudio, su interpretación y reporte de biopsia).	Consulta externa con prioridad	Historia familiar y se debe aportar estudios previos y biopsia Hemograma Completo TP-TPT-plaquetas	Referir con prioridad.
AHF Síndrome de Lynch	Antecedentes familiares positivos	Consulta externa con prioridad	Pacientes mayores de 25 años Hemograma Completo TP-TPT-plaquetas	Referir con prioridad.
Portadores de Anemia crónica	Anemia microcítica - hipocrómica	Referir con prioridad a Medicina Interna.	-	Referir con prioridad.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Pólipos Adenomatosos de colon	Diagnostico endoscópico previo con biopsias	Referir para control con colonoscopia según observaciones.	Reporte de estudios previos y biopsia	Resección completa con biopsia sin atipia Control a los 3 años Resección completa con biopsia con atipia control en 1 año en gastroenterología para seguimiento
Antecedente de Colon Operado	Paciente con antecedente de cirugía de CA de Colon	Referir para control con colonoscopia según guías de manejo de CA de colon	Epicrisis completa	Paciente debe tener control en servicio correspondiente de especialidad de cirugía u oncología.
No debe enviarse a colonoscopia a pacientes con:		Colon por enema sin lesiones Colon por enema con hallazgos de: Colon espasmódico Diverticulosis Dolicolon Colón redundante		
CRITERIOS DE REFERENCIA A CONSULTA EXTERNA				

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Diarrea Crónica	1. Disminución de consistencia fecal con ↑ o no de la frecuencia de las deposiciones de más de 4 semanas 2. Realizar buena Historia Clínica y Examen Físico 3. Descripción clara de las características de las deposiciones, frecuencia, relacionada o no con alimentación	Referir con prioridad a la consulta externa	**Hemograma completo** **glicemia** **PFH** **HIV** **VES** **PFT** **electrolitos séricos** **proteína total** **sangre oculta** **Frotis y cultivo en heces.** **Serología Virus E y A** **Descripción clara del tacto rectal**	Realizar buena historia clínica y examen físico
Constipación con o sin dolor abdominal	No es una enfermedad es un síntoma. Se define como Disminución de la frecuencia de las deposiciones. Presentación de estreñimiento en el último año por 12 semanas intermitentes o continuas. Debe tomar en conjunto Psyllium, aceite mineral y Bisacodilo vía rectal por al menos 3 meses. Se refiere de acuerdo criterios de ROMA 4 y si han fallado las medidas de cambio en la alimentación, recomendaciones de ejercicios para estimular movimiento intestinal	Cita cupo a Consulta Externa	**Hemograma completo PFT** **Sangre oculta** **Colon por enema si se dispone** **Ultrasonido**	Anotar si hay antecedente de fármacos que produzcan Estreñimiento y condiciones neurológicas

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
SD Digestivo Irritable	Grupo de desórdenes de origen funcional secundarios a factores psicosociales, motilidad intestinal y alteración de la sensibilidad intestinal. Referir según criterios de ROMA 4	Debe ser manejado en I nivel en pacientes con estudios normal. Los que presentan criterios referir a la consulta externa con prioridad.	Hemograma completo PFR Proteínas séricas, electrolitos glucosa T3, T4, TSH sangre oculta en heces VES PCR Estudio por parásitos. En mayores de 40 años enviar colon por enema	Patología que puede ser manejada en el primer nivel de atención. En caso de estreñimiento o diarrea crónica referencia debe cumplir con los criterios indicados para estas patologías. En caso de dolor abdominal recurrente referir si hay presencia de signos de alarma: anemia, guayaco +, pérdida de peso, cambio abrupto en el hábito intestinal Diagnóstico de Síndrome de Intestino Irritable no es indicación para Colonoscopia.
Pérdida de peso E/E	Pérdida de peso no intencional de 5% a 10% del peso inicial en los últimos 6 a 12 meses, con sintomatología digestiva.	Referir con prioridad a la consulta externa	Hemograma completo glicemia PF HIV VES T3, T4, TSH electrolitos séricos sangre oculta RX Tórax, US abdomen Gastroscopia	Documentar bien la pérdida de peso por examen físico y por historia clínica.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Reflujo gastroesofágico con o sin esófago de Barret	Presencia de pirosis u otro síntoma de reflujo Debe tener Gastroscopia previa con o sin biopsia	Referir a consulta externa de gastroenterología Cita cupo	Gastroscopia	
H. Pylori	Presencia de H. Pylori demostrada por: test de ureasa, biopsia, test aliento o test en heces Indicaciones de erradicación: Ulcera gástrica/duodenal Linfoma Malt Displasia gástrica Ca gástrico operado Helicobacter +, pacientes con parientes de 1er grado con Ca gástrico Anemia ferropriva no explicable y uso crónico de AINES. Ante falla terapéutica.	Referir a consulta externa de gastroenterología Cita cupo	Test de ureasa biopsia test de aliento test de Heces Enviar con reporte de gastroscopia.	Se dará tratamiento para erradicación, siempre y cuando el usuario firme consentimiento informado, dadas las reacciones posibles adversas del tratamiento.
Sangrado Digestivo Alto / Bajo documentado	Historia de sangrado por historia clínica; Hematemesis, melena, Hematoquecia o por examen físico; lavado gástrico, tacto rectal.	Referir urgente a Emergencias	Hemograma completo, TP, TPT, INR	
Úlcera Gástrica-Duodenal	Endoscopia alta con diagnostico reciente de Ulcera (Lesión ulcerativa de la Mucosa gástrica o Duodenal)	Referir a consulta externa de Gastroenterología	Reporte de Endoscopia Alta	
Displasia Gástrica	Referir casos de displasia gástrica que sean diagnosticados por biopsia	1. Displasia de alto Grado referir a Consulta Externa 2. Displasia de bajo grado enviar gastroscopia al año.	Reporte de Gastroscopia y Biopsia	Displasia Alto Grado Prioridad Bajo grado Control a cupo en la consulta externa

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Tumor abdominal	Masa en Abdomen E/E del aparato digestivo. Hallazgo de tumoración en US y exploración física. En caso de hallazgos físico debe anotarse claramente lo encontrado y que fundamente que la masa pertenece a tubo digestivo.	Prioridad Consulta Externa de Gastroenterología o al servicio de emergencias para internamiento	Adjuntar reporte de US o TAC que demuestre la presencia de la masa. Tacto rectal Laboratorios generales	
Serología (+) por virus B o C	Hallazgo de laboratorio Serología positiva por hepatitis B o C HBs ag (+) o por HCV (+).	Referir a consulta externa de gastroenterología a cupo	Serología Viral (+) PFH, Hemograma completo, HIV, VDRL, TP; TPT; INR; Proteínas Totales y fraccionadas	
Hígado graso	Hallazgo por US y por laboratorio alteración de transaminasas. Depósito de lípidos en hígado. (Añadir en la referencia peso, talla, índice de masa corporal).	Referir a consulta externa de gastroenterología a cupo	Perfil de lípidos, TSH, serología virus B y virus C, PFH, TP, TPT Y plaquetas. Si se cuenta enviar ceruloplasmina, FAN	Añadir peso, talla, índice de masa corporal Transaminasas normales, manejo en I nivel. Transaminasas alteradas referir a cupo a Consulta Externa de Gastroenterología
Hepatitis agudas	Cuadro clínico sugestivo más tinte ictérico y coluria.	Referir con prioridad a la consulta externa Sospecha de hepatitis grave o fulminante (coagulopatía /o encefalopatía) deben ser referidas al servicio de Emergencias	Hemograma completo, serología viral A, B, C, TP, TPT, plaquetas **Ultrasonido**	1-Ptes con vómito, compromiso estado general, TP en menos del 60%, referir urgente al Servicio de Emergencias. 2-Si no cumple criterios referir prioridad Consulta Externa de Gastroenterología
Hepatopatías crónicas	Historia clínica y exploración orientada a hepatopatía crónica con algún hallazgo de laboratorio y/o gabinete. Referir todos los casos de origen viral y con clasificación de Child Pugh B y C	Cita cupo a la consulta Externa de Gastroenterología	Hemograma completo, TP, TPT, Plaquetas, HIV, VDRL,, PSH, PFT, INR, serología viral por virus B o C.	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
			proteínas totales y fraccionadas. US, Gastroscopia con que se diagnóstica la lesión.	
Colocación de PEG	Todos los casos. Usuario con un impedimento neurológico irreversible para deglutir o patología obstructiva de esófago. No se colocará un PEG a pacientes con el propósito de mejorar su estado nutricional de no presentar las condiciones ya mencionadas.		Hemograma, TP, TPT, INR	En caso de obstrucción de sonda o desprendimiento del PEG usuario debe referirse a servicio de Emergencias.
Tamizaje CA colorectal	En mayores de 50 años para tamizaje de Cáncer colorectal.	Cita a cupo o prioridad según caso	Examen físico completo con tacto rectal. Hemoglobina/Hematocrito, 2. Guayacos No.3 seriados o estudio por FOBT. **gastroscopia**	
Colonoscopia de carácter prioritario	Referir con carácter de prioridad los siguientes casos: CUCI, Crohn colónico, AHF primer grado cáncer colorectal, poliposis adenomatosa familiar, Sd. Peutz Jehgers, otros Sd. Polipósicos, antecedente personal patológico de cáncer colorectal.	Prioridad según caso	Adjuntar reporte o copia de estudio endoscópico y/o biopsia previa.	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Diverticulosis	1. Debe ser manejada en el Primer Nivel de Atención. 2. Sospecha de diverticulitis o hemorragia diverticular debe ser referido a servicio de Emergencias. 3. Referir casos de diverticulosis complicada con diverticulitis a repetición y hemorragia diverticular a repetición. Patología no corresponde de control en Gastroenterología	Cita a cupo en Cirugía General		Estudio diagnóstico de elección para Diverticulosis es colon por enema Diagnóstico de enfermedad Diverticular NO es indicación para realizar colonoscopia
Enfermedad hemorroidal	Hemorroides grado III-IV o grandes. Patología no corresponde de control en Gastroenterología	Cita a cupo en Cirugía General		
Enfermedad inflamatoria intestinal (CUCI, CROHN)	Todos los casos	Prioridad	Hemograma, VES, Frotis de Heces. Adjuntar reporte de estudio endoscópico diagnóstico y reporte de biopsia.	
Gastroscopia en pacientes mayores de 40 años	Referir para tamizaje Ca Gástrico cada 2 años	Cita cupo		
Pancreatitis no biliar	Casos agudos deberán ser valorados en servicio de Emergencias. Casos crónicos o a repetición deberán ser referidos a consulta externa	Cita a cupo	Hemograma, pruebas de función hepática, glicemia, amilasa, perfil lipídico. Adjuntar reporte o copia de ultrasonido de abdomen y/o TAC.	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Quiste hepático simple	Esta patología puede seguir su control en el primer nivel de atención, si el estudio diagnóstico indica que el quiste mide menos o igual a 3 cm. Se le debe dar seguimiento cada 2 años con ultrasonido de abdomen. Si se evidencia algún cambio respecto a estudios previos referir a la consulta de Gastroenterología.	Cita a cupo	Adjuntar reportes o/ copias de ultrasonidos o TAC que demuestren el cambio en el tamaño o condiciones del quiste .	
Rectoscopia	Rectorragia, proctalgia o prurito anal.	Prioridad según caso o al servicio de Emergencias	Hemoglobina/Hematocrito, Frotis de heces, Guayaco	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE GERIATRIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE GERIATRIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes que se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral, alfabetismo, y telefono
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos, como también de internamientos previos
   - Examen físico completo

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US).

4. Se solicita que laboratorios, EKG y Rx tórax sean de los últimos 3 meses.

5. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente**. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

6. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**

7. Solo la edad NO es criterio para referir a la especialidad. Tampoco se atenderán casos únicamente de problemas sociales.

8. Casos con carácter de urgencia deben ser referidos al servicio de Emergencias

9. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

10. Los usuarios al acudir a las citas en esta especialidad deben ingresar en compañía de cuidador o persona que conozca al detalle aspecto del adulto mayor.

11. Referir usuarios mayores de 65 años con alguna de las siguientes condiciones:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Enfermedad cerebrovascular	Secuelas agudas referir al servicio de urgencias.	Referir al servicio de urgencias		
Incontinencia Urinaria	Valoración ginecológica previa o por urología	Cita a cupo	Examen general de orina Hemograma PFT PFR glicemia	
Pacientes con múltiples medicamentos 7 o MÁS	Esquema de tratamiento complejo, que requiere readecuación farmacológica y coordinación con otras especialidades	Con prioridad	**Laboratorios dirigidos a sus patologías de fondo** **EKG**	**Debe traer lista de medicamentos, dosis y frecuencia anotada.**
Múltiples comorbilidades descompensadas	Una o más enfermedades crónicas complicadas con repercusiones funcionales	Cita con prioridad	**Laboratorios generales según patología; agregar PFT** **EKG**	**Debe traer lista de medicamentos, dosis y frecuencia anotada.**
Malnutrición	Estados de malnutrición con factores de riesgo múltiple y con repercusión funcional	Cita a cupo	**PFR** **PFH** **Hemograma** **Proteínas totales y fraccionadas** **Electrolitos** **Glicemia** **PFT** **Perfil lipídico**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Depresión	Depresión o deterioro cognitivo con repercusión funcional	Cita a cupo	**Indicar tratamiento recibido y duración**	Estados depresivos sin ideación suicida o estados psicóticos se valoran por consulta externa, de lo contrario referir a urgencias para valoración por psiquiatría.
Osteoporosis	Osteopenia documentada con DENSITOMETRIA, o con fractura osteoporótica.	Cita a cupo	**Adjuntar reporte o copia de densitometría. Laboratorios: calcio, fósforo, función renal y función tiroidea.**	
Trastorno de Memoria	Pacientes con queja de problema cognitivo, objetivo, no subjetivo. Trastorno de memoria que afectan sus actividades de la vida diaria instrumentales.	Cita a cupo	**Hemograma, función hepática y renal, electrolitos, función tiroidea, VDRL, VIH** **Glicemia** **Perfil lipídico** **EKG** **Niveles de vitamina b12 y ácido fólico**	El día de la cita debe venir acompañada de un familiar. Test de Minimental
Síndrome de Caídas	Más de 2 caídas en un año, o con problemas de la marcha, o caída reciente clínicamente significativa ambas sin causa evidente y que NO tenga ya control en Fisiatría o Geriatría	Cita a cupo	**EKG** **Hemograma** **PFR** **Glicemia** **Electrolitos**	Caídas recientes con deterioro funcional agudo referir al servicio de urgencias AD fractura.
Fractura de Cadera	Pacientes OPERADOS en el (HG y HTFC) Ortopedia de fractura o remplazo de cadera. Referir a Clínica de Fractura de Cadera	Cita con prioridad		ANOTAR TIPO DE CIRUGIA REALIZADA.
Dolor crónico no controlado	Paciente no oncológico Dolor de más de 6 meses de evolución. Que no tenga control en clínica del dolor	Cita a cupo	**Lista de medicamentos utilizados y dosis.** **PFR** **Hemograma** **Electrolitos**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	REQUISITOS Y EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
			Glicemia	
Pérdida de peso	Pacientes con pérdida de peso significativa mayor al 5 % en 3 meses o mayor al 10 % en los últimos 6 meses.	Cita con prioridad	**Hemograma, PFR, PFT, TSH, DHL, APE, Electrolitos, Proteínas, Albumina, EGO/Urocultivo, Glicemia, Guayaco, PFH, VES, Rx tórax,**	
Trastornos del sueño	Más de 6 meses de evolución con fracaso de tratamiento en atención primaria. Descartar trastorno depresivo.	Cupo	**Hemograma** **PFR** **PFH** **Glicemia** **Electrolitos** **PFT**	Adjuntar esquema de tratamiento utilizado.
Enfermedad renal crónica	Referir pacientes para control por geriatría con múltiples patologías y polifarmacia, en caso contrario referir a medicina interna o nefrología		**Evolución de PFR** **Índice albuminuria y creatinuria**	Geriatría valorara pacientes con deterioro de parámetros de función renal.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Indicaciones generales

1- Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes que se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.
2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral, alfabetismo, y telefono
    - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
    - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.

- Antecedentes Heredofamiliares
- Antecedentes ginecoobstétriicos
- Antecedentes Quirúrgicos, como también de internamientos previos
- Examen físico completo

4. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US).

5. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente.** Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

6. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**

7. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Sangrado uterino anormal	Sangrados uterinos anormales con patología orgánica identificada referir a la consulta externa	SUA con HB menores de 7 g/dl referir a urgencias SUA con HB mayores de 7 y menor de 10 g/dl hemodinámicamente estables referir con	1.HCG: descartar embarazo 2. Hemograma: en caso de anemia haber iniciado de inmediato tratamiento respectivo	Siempre que se considere necesario iniciar tratamiento hormonal adecuada y/o con AINES según corresponda, anotar claramente en la referencia los tratamientos utilizados y el tiempo de uso

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
		prioridad a la consulta externa SUA con HB Mayores de 10 referir a cupo Paciente con síntomas secundarios a tamaño de las lesiones o refractarios al tratamiento empleado por el primer nivel enviar con prioridad	3. TSH: En caso de alteración tratar respectivamente previa referencia a ginecología, excepto que por historia y/o examen físico se sospeche de malignidad o concomitancia con patología orgánica ginecológica causal se deberá iniciar tratamiento y referir 4. TP, TPT, INR Si cumple los criterios para tamizar por coagulopatías y en caso de encontrarse alteradas referir a servicio correspondiente. 5. Ultrasonido pélvico adjuntar una copia en caso de ya tener uno realizado y si no se cuenta con uno referir indicando su ausencia. 6. Papanicolaou al día y adjuntar la copia del resultado 7. En mujeres mayores a 45 años con Mamografía al día	❖ NO TRATAR A LAS PACIENTES CON VITAMINA K y DEPOPROVERA para el manejo de SUA ❖ En caso de encontrarse a paciente inestable hemodinámicamente o con sangrado uterino anormal activo profuso que comprometa la vida de la paciente debe REFERIRSE al SERVICIO DE EMERGENCIAS con las mismas especificaciones de historia clínica y examen físico ya indicados, así como los tratamientos utilizados para el control del SUA. Manejar Según Guía de Sangrando Uterino Anormal. Referir casos: PALM COEIN (Nemotecnia) ▪ POLIPOS ▪ ADENOMIOSIS ▪ LEIOMIOMAS ▪ MALIGNIDAD ▪ COAGULOPATIA ▪ OVULATORIAS ▪ ENDOMETRIALES ▪ IATROGENICAS ▪ NO CLASIFICABLES

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Amenorrea	Amenorreas que persiste por más de 6 meses, previamente estudiadas	Cupo	**HCG** **Hemograma** **PF Tiroideas** **TSH /PRL / Insulina / DHEAS** **FSH/LH/Estradiol/ Progesterona** **US ginecológico**	Descartar Embarazo, Menopausia y Síndrome de ovario poliquístico. (PCO)
Dismenorrea	Dismenorrea primaria Fracaso terapéutico por 6meses Con US ginecológico normal. Dismenorrea secundaria Referir para valoración, también referir a US ginecológico al mismo tiempo.	A cupo	**CA -125** **US ginecológico**	Si es primaria, tratar y completar estudios antes de referir, el tratamiento es ACO y AINES x 6 meses. Referir para US ginecológico a la consulta externa
Dolor pélvico Crónico	Dolor pélvico de 3 a 6 meses de evolución cíclico o continúo que sea incapacitante y se ha descartado causas comunes de dolor pélvico. Síndrome colon irritable Litiasis renal Causas Oseas o musculares Síndrome adherenciales	Cupo	Hemograma **Referir con Ultrasonido Abdomino-pélvico o al menos cita gestionada**.	Valorar historia de CX abdomino-pélvicas, y de enfermedades pélvicas inflamatorias.
Condilomatosis	Pacientes que no se puedan tratar con cauterización en primer nivel de atención por CX menor Condilomatosis extensas que requieran cirugía	Cupo a cita de procedimientos	**HIV** **VDRL** **Hepatitis B**	A toda paciente con este diagnóstico se le debe iniciar la aplicación de Podofilina o cauterización según tamaño y cantidad de lesiones.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Miomatosis	Debe de ser valorada en casos que sean sintomáticas o de crecimiento rápido. De gran tamaño mayor a 5 cm, en estos casos referir a la consulta externa a cupo. Si no cumplen estos criterios vigilancia en EBAIS con US anuales.	Cupo	HCG para descartar embarazo SI CORRESPONDE **Ultrasonido pélvico original para visualizar fotografías**	
Masas anexiales	Si no son abdómenes agudos ginecológicos referir a consulta externa con prioridad.	A Prioridad masas complejas O de gran tamaño. Que produzcan síntomas compresivos.	1. HCG para descartar embarazo 2. Hemograma 3. Marcadores Tumorales: ACE, Ca 19-9, CA 125 4. Ultrasonido pélvico (adjuntar su copia)	
EPI	Según presentación clínica, cuadros agudos se refieren al Servicio de Emergencias.	Urgencias		Debe existir siempre dolor a la movilización del cérvix, palpación de útero y anexos, más datos sugestivos de infección; fiebre, flujo vaginal fétido, PCR, VES y leucocitosis Si existe afección severa del estado general, SRIS, si la paciente está embarazada o existe alguna sospecha o dificultad para que la paciente cumpla el esquema de tratamiento oral; referir para tratamiento IV.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Prolapso Urogenital	Las pacientes que requieren ser valoradas son las sintomáticas. Los grados se evalúan mediante el POPQ y si son sintomáticos (o refieren problema estético) deben de referirse a consulta a cupo para manejo QX	Cupo	**EGO** **Urocultivo** **Papanicolau** **US pélvico**	A cupo para manejo QX si son sintomáticos

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Patología cérvix	Seguir normativa nacional de tamizaje de CA CERVIX	Según normativa Nacional	❖ Último reporte de la Citología Cervical ❖ Reporte de Biopsia de cérvix previa en caso de que paciente tenga alguna realizada Fecha de realización o solicitud. Copia de citología cervicouterina de menos de 2 años.	Alteraciones benignas de la citología como inflamatorio leve, metaplasia epidermoide, hiperplasia de células glandulares no ameritan colposcopía. -Citología inflamatoria severa: dar tratamiento específico si se aísla agente causal o empírico si no hay causa específica. Repetir citología en 3 meses. Si persiste alteración severa referir a colposcopía (no urgente). -ASCUS postmenopáusico: indicar estrógenos conjugados vaginales dos veces por semana al referir la paciente. Siempre que no exista contraindicación para el uso de los mismos (hipersensibilidad al fármaco, cáncer de mama o endometrio). -Ectropión y Quistes de Naboth con citología normal no ameritan colposcopía. -Pólipos endocervicales que no es posible resecarlos y biopsiarlos en primer nivel, referir a consulta de ginecología general, con reporte de citología.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Infertilidad	1 año relaciones sexuales y sin método anticonceptivo, sin éxito de embarazo	Cupo	Espermograma de la pareja. Perfil Hormonal completo: US pélvico Hemograma PFR VDRL HIV HEP B	
Menopausia	Sintomatología severa de Climaterio		FSH/LH/Estradiol/Progesterona Hemograma Perfil lipídico US ginecológico Mamografía	Debe abordarse de forma biopsicosocial Estado de animo Resequedad vaginal (estrógenos vaginales) Osteoporosis (bifosfonatos) Libido (estrógenos vaginales y atención estado animo) Síntomas vasoactivos; bochornos (terapia de reemplazo hormonal) Si decide iniciar TRH idealmente debe de iniciar en el primer año postmenopausia. Sin: Antecedentes heredo familiares o propios de cáncer de mama Enfermedad hepática Dislipidemia controlada Sin riesgo cardiovascular Si cumple estos criterios se puede dar tratamiento en pacientes con útero y ovarios en combinación con progesterona, si no tiene útero utilizar solo estrógenos.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Incontinencia Urinaria	Referir al Servicio de Urología para valoración.		Urocultivo reciente	Incontinencia post parto esperar al menos 6 meses para referir si se mantiene. Incontinencia de esfuerzo recomendar ejercicios de Kegel habito e higiene urinario por 6 meses, referir si se mantiene
Referencias a emergencias de pacientes ginecologías	▪ Amenaza de aborto ▪ Sospecha de embarazo ectópico ▪ Sospecha de masas anexiales torsionadas ▪ SUA con severidad de la sintomatología ▪ EPI que no se le pueda dar manejo ambulatorio. ▪ Sangrados del segundo y tercer trimestre embarazo ▪ Ruptura prematura de membranas ovulares ▪ APP ▪ Infecciones severas de sitio QX ▪ Sospecha de cáncer			
ALTO RIESGO OBSTETRICO				
Patología	**Criterio de referencia**	**Grado de prioridad**	**Exámenes previos**	**Observaciones**
Diabetes Mellitus Gestacional	En Diabetes Pre gestacional referir inmediatamente En Diabetes Gestacional referir al momento del diagnóstico.	Referir a urgencias diabetes pre gestacional y glicemias en ayunas mayores a 110 Con otros criterios a prioridad a consulta externa	DM Pre gestacional Hemoglobina glicosilada. (HBA1C). Perfil glicémico Orina de 24h PFR DMG	Realizar glicemia en ayunas y post carga en todas las pacientes con factores de riesgo Si presenta valores alterados realizar CTG.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
			Adjuntar resultados de glicemia post-carga con 50 gramos y resultados de Curva de Tolerancia a la Glucosa	A todas las pacientes se les realiza tamizaje post carga entre la semana 24 y la 28.
Trastornos hipertensivos **HTA Crónica**	En Hipertensión crónica: referir a primera consulta para evaluación de riesgo y manejo conjunto. Si la paciente se capta en forma tardía iniciar aspirina 200 mg HS VO cada día a partir de la semana 12 y hasta la 37.		Hemograma PFR EGO US obstétrico Proteinuria 24h	Descripción de las características relacionadas a la gestación actual como altura uterina, FCF, o en el caso de gestaciones muy tempranas hacer la aclaración respectiva. Incluir historia de trombosis anteriores en la paciente y/o historia de sangrado postparto, Preeclampsia o eclampsia en embarazos previos. ❖ Si tiene US obstétrico previo anotar y/o adjuntar copia del reporte de los ultrasonidos que se haya realizado

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Trastornos hipertensivos **HTA propia del embarazo**	Referir al momento del diagnóstico.	Emergencias	Hemograma PFR EGO US obstétrico Proteinuria 24h Ácido Úrico Transaminasas DHL Relación Albúmina/ Proteinuría.	Si las cifras tensionales son de severidad (mayores o iguales a 160/110mmhg) o la paciente presenta síntomas neuro-hipertensivos, alteraciones bioquímicas y de hemograma se debe trasladar al servicio de urgencias acompañada por medico con prioridad. Colocar sulfato de Mg para neuro-protección materna Utilizar hidralazina para control de la PA
Obesidad	Referir obesas mórbidas con IMC de 40 o mas	Prioridad	IMC mayor o igual a 40	En todos los casos de obesidad suplementar con ácido fólico 4mg por día un mes pre embarazo y todo el primer trimestre. Iniciar aspirina 200mg HS VO desde la semana 12 a la **36** para prevención de preeclampsia Tamizar x diabetes gestacional en la primera cita a todas. Glicemia en ayunas y test de Sullivan.
Tamizaje de Diabetes	Debe realizarse de forma universal Si la paciente presenta los siguientes factores de riesgo debe de tamizarse en la primera		Test de Sullivan Glicemia en ayunas	Si el tamizaje es positivo y se diagnostica **diabetes Pre gestacional** Se debe enviar a emergencias para internarse. Si el tamizaje es negativo o la paciente no tiene factores de alto

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
	consulta con test de Sullivan y glicemia en ayunas: • DMG en embarazos anteriores • Antecedentes de productos macrosómicos previos • Obesidad • Intolerancia a los CHO • AHF directos de DM		Curva de tolerancia a la glucosa	riesgo se tamiza entre la semana 24 a 28 de gestación con prueba de tolerancia a la glucosa con 50 g que debe ser inferior a 130mg/dl. Si es superior a 130mg/Dl se debe enviar CTG a menos que la glicemia en ayunas sea superior a 126 mg/dl o la glicemia post carga sea superior a 200mg/dL en donde se debe enviar a la paciente a urgencias para internamiento Si el valor es positivo, pero no alcanza los niveles antes descritos enviar la CTG, con dos valores alterados se diagnostica DMG, si cumple los criterios de la OMS para diabetes referir a urgencias, si no los cumple referir a la consulta externa con los datos de la CTG. NO realizar ajustes a la insulina ni iniciar insulina de forma ambulatoria, eso se ajusta con perfiles en el tercer nivel o internada. TODA diabética pre gestacional con tx en el EBAIS que debuta con embarazo debe de referirse a emergencias de su hospital más cercano.
Edad	Se deben referir a ARO pacientes mayores de 35 años y menores de 16 años para valoración. Siempre y cuando sea el primer embarazo			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Rh Negativo	Realizar Coombs indirecto por trimestre		Coombs positivo referir con prioridad	
US obstétrico	Se realizarán diferentes tipos de ultrasonido, con diferentes intenciones. TODAS LAS PACIENTES EMBARAZADAS TIENEN DERECHO A UN ULTRASONIDO US I trimestre y tamizaje deben realizarse siempre en: • Pacientes mayores de 40 años • Diabéticas pre gestacionales • Antecedentes de malformaciones en otros fetos • Antecedentes de malformaciones maternas • Epilepsia en tratamiento o uso de fármacos. • Antecedentes de partos prematuros • FUR desconocido US II trimestre • Realizar entre las 20 y 24 semanas, morfológico. US III trimestre Referir PRN si se tienen dudas de crecimiento o bienestar			Todos los US privados que reporten anormalidades fetales referirlos a la consulta externa con prioridad.
Discordancia clínica	4 semanas fuera de la edad gestacional requiere valoración o si se encuentra cerca del final del embarazo o se sospecha compromiso fetal	**Prioridad**		Se debe de medir cuidadosamente la altura uterina de la sínfisis púbica a fondo uterino sin incluir el panículo adiposo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Abortos a Repetición	Referir solamente en caso de que se capten de forma temprana y si cumplen los criterios de perdida gestacional recurrente, de lo contrario referir para su control de US morfológico	**Prioridad**		
Monitoreo fetal	Se realiza únicamente en pacientes de alto riesgo en el contexto de control de bienestar. • Hipoquinesia fetal. • Sospecha de compromiso fetal.	**Urgencias o Casa de la Mujer**		En las pacientes de bajo riesgo **NO** se realiza de rutina.
Embarazos de término tardío	Las pacientes se internan para inducción a las 41 semanas si no tienen factores de riesgo asociados.	**Urgencias**	**EG 41 semanas**	No referir antes de esa edad gestacional.
Uso de aspirina en la mujer embarazada	• Mayores de 35 años • Hipertensión crónica • Diabetes pre gestacional • Obesidad • Hipotiroidismo • Antecedentes de preeclampsia • Lupus / síndrome anti fosfolípidos • Embarazo múltiple			
Uso de ácido Fólico 4 mg; idealmente un mes antes del embarazo y todo el primer trimestre	• Obesas • Epilepsia • Defectos de tubo neural previo • Antecedente de cardiopatía • Diabetes pre gestacional			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Embarazos múltiples	Referir de forma temprana	Prioridad	US	
TORCHS	Si la infección es temprana se le seguirá control, si es tardía referir para valoración de riesgo			El perfil de tratamiento de estas pacientes depende de la valoración fetal por lo que se sugiere que se refieran a obstetricia e infectología
VPH o Verrugas Vaginales	No contraindican parto vaginal, no requieren valoración especial			
PAP alterado en embarazo	Referir a colposcopia según guía nacional			
Epilepsia y enfermedad Psiquiátricas	Referir conjunto con neurología y psiquiatría	No suspender tratamientos y referir de forma prioritaria a la consulta externa.		
Hipotiroidismo e hipertiroidismo	La levotiroxina es segura en el embarazo, el PTU se utiliza en el primer trimestre y después se pasa a metimazol o se da control cuidadoso.	**Prioridad**	**PFT**	Debe de valorarse de forma temprana.
Alcohol, Drogas, Farmacodependencia	Referir urgencias, y concomitante a trabajo social	Requieren valoraciones según criterio urgente e internadas		
		Cupo	Hemograma	Anemias leves y fisiológicas tratar con suplemento de hierro

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Requisitos y Exámenes previos	Observaciones
Patologías hematológicas	Anemias: referir cuando son severas con HB menores de 9 mg/dl. Trombocitopenias aisladas: Valores inferiores a 150 mil referir para valoración.			
Indicaciones clásicas de cesáreas electivas	• Macrosomía fetal en semana 39 • Productos pélvicos en semana 39 • Placentas previas en semana 37 • Antecedentes de miomectomías • Todas las demás patologías requieren valoración riesgo beneficio.			
Pacientes con una Cesárea anterior	La paciente con una cesárea anterior puede tener un parto vaginal seguro, aunque existe un aumento muy discreto del riesgo en este grupo de pacientes, es por esto que, si la paciente no desea correr ningún riesgo en el contexto de una cesárea anterior para prueba de parto vaginal, esta se puede programar a la semana 39. Se recomienda promover la seguridad del parto vaginal después de una cesárea anterior.			
Paridad Satisfecha	Todo paciente que desea esterilización quirúrgica debe haber llevado Charla de Esterilización quirúrgica , ser mayor de 18 años, Tener Papanicolau con mínimo 2 años de vigencia (Debe traerlo a su cita médica) Pacientes con Deterioro cognitivo Moderado o severo debe presentar autorización por parte de un Juez de Familia.			
Paciente con dos cesáreas anteriores.	Deben de referirse para cesárea electiva			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR

La Medicina Familiar y Comunitaria es una especialidad dedicada a brindar cuidados, centrados en la persona en su contexto familiar y comunitario de forma continua, independientemente de su edad, sexo, condición socioeconómica o de salud, integrando en el proceso de atención los factores físicos, psicológicos, sociales, culturales y asistenciales que contribuyen al proceso salud-enfermedad en pro de los sistemas de salud.

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo
3. Adjuntar copia de reportes de exámenes de laboratorio y gabinete efectuados (según sea el caso y los recursos que se tengan disponibles). Se debe **adjuntar EKG y RX de Tórax** (NO es necesario el reporte).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

4. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente**. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**

6. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

7. Dado que la Especialidad de Medicina Familiar puede formar parte o coordinar diferentes tipos de Servicios (ej. Clínica de Cesación de Fumado, Clínica de Rehabilitación Cardiaca, etc.), en estos casos los requisitos para referir a dichos Servicios tienen sus propias normas de referencia, las cuales deben ser consultadas.

8. En todos los casos es deseable que la persona al ser referida, sea acompañada de un familiar, encargado(a) o cuidador(a). En especial si es adulto mayor.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR CRITERIOS DE REFERENCIA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
MEDICINA INTERNA				
DIABETES MELLITUS	Usuarios con HBA1C mayores 9 % en 2 tomas persistentes, pese a tratamiento óptimo o con intolerancia al tratamiento convencional. Personas portadoras de Diabetes Mellitus con problema social presente y sin adecuada red de apoyo. Presencia de complicaciones derivadas de la Diabetes que no hayan sido valoradas por Medicina Interna. Según guías institucionales (insulinización)	Cupo	**Glicemia en ayunas** **Glicemias 2 HPP** **Hba1c** **Perfil lipídico** **PFR** **Ego** **Índice albuminuria y creatinina.**	Deseable el abordaje integral en familia, se recomienda consultar junto con familiares para crear red de apoyo. Referir concomitante a Nutrición y Atención Farmacéutica, cuando se dispone de dichos Servicios.
HIPERTENSIÓN ARTERIAL	Usuarios quienes se presentan con descompensación frecuente a pesar de tratamiento antihipertensivo adecuado, con presiones mayores a 160/90 persistentes en dos o más atenciones con dosis máximas de 3 antihipertensivas. También del servicio de urgencia con historias de emergencia/urgencias	Prioridad a la consulta externa	**EKG** **RX tórax** **Glicemia** **Electrolitos** **PFR** **Perfil lipídico** **Ego**	Deseable el abordaje integral en familia, se recomienda consultar junto con familiares para crear red de apoyo. Asegurar que los pacientes presenten buena adherencia al tratamiento (atención farmacéutica) antes de referir

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
	hipertensivas (190/100) o daño a órgano blanco documentado.		**Índice albuminuria creatinina.**	Referir concomitante a Nutrición y Atención Farmacéutica, cuando se dispone de dichos Servicios.
DISLIPIDEMIA	Pacientes con alteraciones lipídicas Triglicéridos mayores 500 por riesgo de pancreatitis aguda LDL mayores a 190 persistentemente elevados por más de dos tomas en al menos 6meses con riesgo cardiovascular alto. (más de 10%) 40 mg de lovastatina y estilos de vida saludable	Cupo	**Perfil lipídico** **Glicemia ayuna y dos horas postprandiales** **PFH** **TSH**	Tomar en cuenta tablas para cálculo de riesgo cardiovascular Framingham/ATPIII
OBESIDAD	Referir pacientes con obesidad mórbida con IMC mayor a 40, a pesar de medidas de atención adecuadas por parte del primer nivel	Cupo	**Glicemia ayuna** **Perfil lipídico** **EGO** **PFR** **PFT** **HBA1C** **PFH** **Glicemia 2 h pp**	Referir concomitantemente al servicio de nutrición.
Nefropatías	1. Personas con riesgo para enfermedad renal crónica con aclaramiento endógeno de creatinina calculado (utilizar formula CKD-EPI) en dos tomas, con afección moderada o severa (Todos aquellos con AEC ≤ 65 mm/min). 2. Personas con alteración de índice albuminuria creatinina mayor a 300.	1. Cupo. 2. Prioridad a las personas con AEC < 15 ml/min o Índice albuminuria creatinuria mayor a 2000.	**PFR** **Índice albuminuria creatinuria** **Ego** **Hemograma** **Consultar acompañado con un familiar para red de apoyo.**	Factores de riesgo Obesidad, HTA, edad, DM, uso crónico de aines. Manejar formula CKD-EPI Utilizar como screening índice albuminuria/ creatinina Contemplar también orina de 24 h para cumplir compromiso de gestión.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Insuficiencias Cardiaca	1. Personas con sospecha o Insuficiencia cardiaca ya diagnosticada con escala funcional NYHA III o IV. 2. Personas con sospecha de Insuficiencia cardiaca para diagnosticar	Referir con prioridad NYHA III Y IV	**Hemograma** **PFR** **RX tórax** **EKG**	NYHA IV o ICC enviar con prioridad sin requisitos
Arritmias	1. Personas con ACFA de alta respuesta ventricular o aquellas que presenten escala CHAT 2 S2 – VASC 2, ya diagnosticadas para anticoagulación 2. Arritmias estudiadas por cardiología, para continuar antiarrítmicos y anticoagulación	Cupo	**TP** **TPT** **INR** **EKG**	Implementar utilización de escala CHAT2
Neumopatías	1. Personas con sospecha de Neumopatía crónica (definición de caso). 2. Personas tabaquistas de más de 40 paquetes/año. EPOC Descompensado 3. Asma Bronquial con exacerbaciones frecuentes (más de 2 en los últimos 3 meses). 4. Síndrome post- COVID	Cupo	**RX tórax** **Esputos por BK**	Aquel paciente con disnea y tos por más de 3 meses de evolución.
Hepatopatías	Toda sospecha de hepatopatías, o hepatopatías ya diagnosticadas.	Cupo	**PFH** **Hemograma** **Proteínas totales y fraccionadas** **Tiempos de coagulación.** **PFR** **Albúmina** **Serología por hepatitis** **Perfil lipídico**	Toda sospecha de complicaciones de hepatopatías agudas como encefalopatías, SDA, o peritonitis espontaneas enviar al servicio de urgencias

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Sospecha de Neoplasias	Referir todo paciente con sospecha o neoplasia confirmada.	Con urgencia a consulta externa	**No requiere**	
Sospecha de TB pulmonar o extrapulmonar	Referir a medicina interna de forma prioritaria HTFC Según guías nacionales de TB	No es caso de Medicina Familiar		Según Norma Nacional, los casos sospechosos o con certeza diagnóstica deben ser enviados Medicina Interna
Sospecha de osteoporosis, riesgo de osteopenia	Pacientes con riesgo para osteoporosis: Pacientes con uso crónico de esteroides a más 7,5mg por día Tabaquistas Uso de levotiroxina a dosis supra fisiológicas AHF en hermanas madres o tías de FX de cadera Problemas nutricionales	Cupo	**PFR**	1. No se puede enviar Densitometría Ósea a personas mayores de 100 kg. de peso. 2. Personas con reporte de Densitometría Ósea candidatas para el uso de Alendronato, deben ser valoradas primero por Odontología.
Endocrinología				
Hiper e Hipotiroidismo	Referir casos de difícil manejo. Con dudas en las pruebas de función tiroidea.	Cupo	**PFT**	Manejar deseablemente la patología básica a nivel de EBAIS
Nódulos tiroideos con sospecha de malignidad	Pacientes con nódulo/s de más de 2 cm o con crecimiento acelerados o en pacientes con AHF +, o historia de radiación en cuello, o sexo masculino. Pacientes únicamente con nódulos tiroides referir a cupo	1. Referir con prioridad las personas con factores de riesgo alto. 2. Referir a cupo sin factores de riesgo.	**PFT** **US deseable**	Enviar pacientes con hallazgos clínicos y factores de riesgo. De forma prioritaria sin US como requisito. Enviar los pacientes sin factores de riesgo con US

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Oncología				
Enfermedades Hematológicas	Pacientes con alteraciones de las líneas celulares con dudas en el manejo y en dos o más hemogramas, o con síntomas B	Con prioridad	**Hemograma completo** **Reticulocitos y frotis de sangre**	
Cirugía Menor				
Lesiones benignas	Lipomas, acrocordomas, verrugas vulgares, espolón calcáneo, paroniquias, infiltración de cicatrices hipertróficas y queloides, bursitis, fascitis plantar, alopecia areata, entre otros. Personas de cualquier edad con padecimientos en los cuales se considere que requieren una intervención quirúrgica menor y que no existen las condiciones de tiempo, infraestructura o posibilidad de procedimiento en el momento o lugar actual para realizarlas	A cupo		En niños valorar si existe un beneficio real al realizar un procedimiento. Si el paciente toma algún anticoagulante o antiagregante plaquetario se debe anotar en la Referencia; en caso de uso de Ácido Acetil Salicílico se recomienda su descontinuación 5 días previos a la cirugía y su restablecimiento 5 días después de la misma. Warfarina se recomienda tener un reporte de INR el mismo día o máximo 2 días previos al procedimiento en cuyo caso debe tener un valor de 2-3, de lo contrario se deberá cambiar la cita o se coordinará con el tercer nivel de atención Se debe enviar la referencia con el correcto llenado del Consentimiento Informado, en el cual se le explica al paciente el probable diagnóstico y tipo de procedimiento
Lesiones sospechosas malignas y biopsias de piel	1.Lesiones sospechas con alteraciones en la clasificación de lesiones ABCDE de lesiones pigmentadas, con una puntuación igual o mayor a 4 2.Necesidad de biopsias para diagnóstico de lesiones en piel. 3.Personas con condilomatosis	Prioridad		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
				probable a realizar. En caso de algún cambio en el momento de la valoración, se le hará la explicación pertinente al paciente; esto es por cuanto algunos pacientes han llegado para un procedimiento y al momento de valorarles indican que vienen con otro padecimiento que les interesa más resolver.
Familiar y Social				
Familias disfuncionales	Referir aquellos pacientes que se encuentran con afecciones familiares severas que se puedan beneficiar del apoyo de trabajo social y psicoterapia (terapia conductiva conductual) Síndrome cuidador cansado Problemas de pareja V.I.F.	Cupo	**No requiere**	**Enviar al núcleo familiar.** **Titular prioridad a criterio médico.** **Enviar a EISAM cuando se cuenta con este Servicio.**
Duelo patológico	Duelo que dura más de dos años o que interfiere con la calidad de vida de esa persona y su entorno.	Cupo	**No requiere**	**Enviar al núcleo familiar.** **Titular prioridad a criterio médico.** **Enviar a EISAM cuando se cuenta con este Servicio.**
Intervención en crisis	Pacientes que presentan una reacción emocional desmedida que afecta su calidad de vida y su entorno, con respecto a un evento estresante o una noticia impactante	Prioridad	**No requiere**	**Enviar al núcleo familiar.** **Titular prioridad a criterio médico.** **Enviar a EISAM cuando se cuenta con este Servicio.**
Toxicomanías	Pacientes con deseos de rehabilitación para terapia individual	Prioridad	**Hemograma** **PFR** **PFH** **VDRL** **HIV** **HEP B**	**Enviar al núcleo familiar.** **Titular prioridad a criterio médico.** **Enviar a EISAM cuando se cuenta con este Servicio.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
			Tóxicos en orina	
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Pacientes que han sido diagnosticados con una Infección de Transmisión Sexual, incluyendo a su(s) contacto(s), y que requieran una valoración integral que por diferentes razones no sea posible en su propia comunidad, seguimiento de casos control, contactos y otras alteraciones propias de su enfermedad. O fracaso terapéutico por parte del EBAIS	Cupo	**VDRL** **HIV** **HEP B** **PAP al día** **EGO** **Hemograma** **PFH** **PFR**	Debe haberse llenado las boletas de notificación obligatoria correspondiente por parte del primer nivel de atención.
Pacientes con VIH	Pacientes con síntomas sugerentes o diagnóstico de VIH que no hayan sido valorados por Medicina Interna	Prioridad a la Consulta Externa	**VDRL** **HIV + Carga viral** **HEP B** **PAP al día** **EGO** **Hemograma** **PFH** **PFR**	El abordaje inicial se realiza en las comisiones de hospitales. Todos los casos sospechosos y aquellos confirmados deben abordarse de manera integrada buscando la identificación de la red de apoyo y de los posibles contactos.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Necesidad de cambio o continuación de tratamiento que se encuentre dentro del perfil de lista oficial de medicamentos para medicina familiar	Pacientes con padecimientos que requieran tratamiento que puede ser prescrito por Medicina Familiar, siempre y cuando se haya agotado el orden y dosis adecuado de otros medicamentos y se cumpla con los requisitos para su prescripción (adjuntar copia del Especialista que primero indicó el medicamento, ya que, según el medicamento, puede ser que haya sido recetado sólo por cierto tiempo o por una situación específica). No se aceptan referencias para prescribir medicamentos o realizar procedimientos indicados por colegas a nivel privado.	CUPO	**Historia clínica y justificación del fármaco**	Una vez autorizado el fármaco y según el diagnóstico, puede ser contrarreferido al Primer Nivel de atención para continuar por un tiempo limitado.
Visita Domiciliar	Pacientes con dificultad de traslado Síndromes de inmovilización Patología avanzada no oncológica	Cupo	**Resumen clínico y exámenes generales previos de ser posible**	Incluir número telefónico y dirección clara para inclusión a visitas domiciliares. Algunos casos según la necesidad y/o diagnóstico pueden ser referidos o manejados concomitantemente con Cuidados Paliativos, según los recursos disponibles.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). Se debe **adjuntar EKG y Rx de Tórax** (NO es necesario el reporte).

4. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente**. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

5. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y <u>NO A LA CONSULTA EXTERNA.</u>**
6. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patologías consideradas como Emergencias **Deberán ser referidas al servicio de Urgencias**	✓ DM- HTA con sospecha de Angor de menos de 48-72 hrs de evolución ✓ DM con Descompensación hiperosmolar o cetoacidótica ✓ DM con hipoglicemia en coma o con alteración de la conciencia ✓ HTA con urgencia o emergencia hipertensiva ✓ ICC descompensada, EAP ✓ Evento cerebral aguda ✓ Crisis asmáticas y EPOC descompensado ✓ Trastorno del ritmo cardiaco ✓ Neumonías o bronconeumonía ✓ Cefaleas más crisis convulsiva, diplopía, papiledema, déficit focal, post trauma. ✓ Dolor Torácico con factores de riesgo cardiovascular ✓ Angina Inestables

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Criterios de Referencia a Consulta Externa a cita a Cupo

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
DM tipo 1	Todos los casos	**Glicemia (ayunas)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **Hb glicosilada** **Proteinuria 24 h** **AEC** **EKG**	Debe especificarse si ha tenido algún régimen dietético y ejercicios
DM tipo 2	1. DM con respuesta inadecuada a pesar de replanteamiento del tratamiento con insulina (HbA1C≥ 9 y/o glic≥240) más hipoglicemiantes orales (para aquellos casos que correspondan) 2. DM con complicaciones crónicas con: 2.1 Retinopatía no proliferativa severa 2.2 Nefropatía con insuficiencia renal crónica: aclaración creatinina ≤ 60/min. y/o Proteinuria ≥ 0.5 gr/24 horas y/o creatinina ≥ 1.5 en hombres y 1.3 en mujeres QUE PERSISTAN POR MAS DE 3 MESES (enviar dos controles como mínimo con diferencia de 3 meses) 2.3 Pie diabético rojo 3. DM con comorbilidad Cardiovascular 4. Hipoglicemia: Recurrente para valorar tratamiento	**Glicemia ayunas** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **Hb glicosilada** **Proteinuria 24 h** **AEC** **EKG** **RX Tórax**	Debe especificarse si ha tenido algún régimen dietético y ejercicios

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
Hipertensión arterial	Hipertensión arterial grado 2-3, riesgo B y C con respuesta inadecuada a PESAR DE REPLANTEAMIENTO DEL TRATAMIENTO (DEBE ANOTARSE EL TRATAMIENTO). El tratamiento replanteado debe tener mínimo 3 antihipertensivo de los siguientes grupos a dosis máxima, que incluya una tiazida. Calcio antagonista IECA ARA-II DIURETICOS TIAZIDA OJO: Ni los B-Bloqueadores ni la Furosemida se consideran antihipertensivos de primera línea.	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **AEC** **Proteinuria 24 h** **EKG** **Rx Tórax**	Debe anotarse las cifras de presión arterial seriadas y si ha tenido algún régimen dietético y ejercicios. *(*Muchos pacientes no se pueden realizar la toma de presión seriadas ya que pueden tener dificultad de acceso o bien no van por diferentes motivos*)
Cardiopatía Isquémica	Valoración previa por cardiología	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **EKG** **Rx Tórax**	
ICC	Todo paciente con diagnóstico de Insuficiencia cardiaca clínica, y patología con riesgo cardiovascular asociada. Pacientes descompensados deben tratarse en Servicio de Emergencias (ICAD). Valoración previa por cardiología	**Hemograma** **Glicemia (ayunas)** **Perfil lipídico** **EGO** **BUN-Creatinina** **TSH** **EKG** **Rx Tórax**	Incluir tratamientos de base dosis etc. Clínica de insuficiencia cardiaca: Ingurgitación yugular Edemas podálicos 3r ruido Estertores pulmonares Disnea
Evento cerebral	Pacientes descompensados deben tratarse en Servicio de Emergencias.	Según comorbilidad	Los eventos nuevos se evolucionarán por 2 años para control y estabilización de factores de riesgos

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
	Valoración previa por Clínica de Ictus o por neurología		
Obesidad	No amerita referir		Manejo es de 1er Nivel de atención
Dislipidemia	Solo Dislipidemias severas con respuesta inadecuada a PESAR DE TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO y Farmacológico adecuado	**Glicemia (ayunas)** **HBa1c** **Historial de perfil lipídico: 6 meses de tratamiento con mínimo de 2 perfil lipídico** **PFT**	Importante anotar el tratamiento y las dosis que ha recibido
PATOLOGIA TIROIDEA			
Bocio Difuso o BMN eutiroideo o con hipofunción leve	No amerita referir a Medicina Interna.		Se recomienda controlar PFT cada 6 meses
Reporte de US de Nódulos Coloides (son lesiones benignas	No amerita referir		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
Bocio con Hipofunción severa **Bocio Difuso o BMN con hiperfunción** **Bocio con nódulo NO coloide, único eutiroideo**	Todos los casos	**Prueba de función tiroidea** **US de tiroides (coordinar con Radiología y Dirección Médica)**	
Tiroiditis aguda y crónica	Todos los casos	**Prueba de función tiroidea** **US de tiroides**	
PATOLOGIAS ENDOCRINAS			
Observación por Síndrome de Sheehan	Todos los casos	**Glicemia, TSH, Perfil de lípidos y Orina, Na y K, FSH, LH, Estradiol**	
Galactorrea	Todos los casos	**Glicemia, Perfil de lípidos y Prolactina, FSH, LH** **Prueba función Tiroidea** **RX de cráneo lateral, Silla Turca**	
Observación Acromegalia	Todos los casos	**Glicemia, Perfil de lípidos y Orina** **FSH, LH y Prueba Función Tiroidea**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
Artralgias en estudio	Se refieren únicamente aquellos casos con: 1. Inflamación articular de más de 6 semanas con deformidad articular evidente al examen físico documentadas 2. Inflamación articular de más de 6 semanas asociadas a VES, PCR, FR elevadas	**Hemograma completo** **Glicemia en ayunas** **Perfil lipídico** **P.F. Renal** **Proteinuria 24h** **VES, PCR, Factor reumático, Ácido úrico.**	-Historia clínica y examen físico completo. -Indicar tratamiento suministrado
Neuropatía en estudio NO diabéticas	Con dificultad en el diagnóstico y abordaje.	**Hemograma completo** **HbA1C, TSH, Glicemia en ayunas** **Perfil lipídico** **P.F. Renal** **VES, PCR, Factor reumático, Ácido úrico**	**-Historia clínica y examen físico completo con examen neurológico básico.** **-tratamiento suministrado**
Crisis convulsivas	Crisis convulsiva debería enviarse al servicio de Emergencias Diagnóstico de Epilepsia: 1. De inicio tardío 2. Crisis convulsivas de edad temprana 3. Epilepsia de difícil control (refractaria a tratamiento) **(Nota: solicitar permiso a Dirección para envío de niveles de anticonvulsivantes)** **(En HTFC: valoración por Neurología)**	Para todas las crisis Historia clínica con descripción de crisis, evolución, examen neurológico, con FO Examen laboratorio de rutina: Hemograma completo. Glicemia en ayunas y según comorbilidades **Nivel sérico de anticonvulsivantes**	Se refieren a neurología HTFC Según guía criterios referencia neurología

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
Cefaleas	1.Tipo primario (migraña, tensional, cefalea en racimos) de difícil control 2. Otra cefalea 2.1 Cefalea que despierta a la persona 2.2 Trastornos sensitivos focales (no aura típica) 2.3 Cambio en el patrón de la cefalea 2.4 Exploración neurológica anormal (excluyendo las del punto 2)	**Examen neurológico con Fondo de ojo y agudeza visual** **Estudios previos realizados** **Lab.: Hemograma, VDRL, Orina,** **RX senos paranasales**	Especificar: Edad de inicio, frecuencia, características clínicas, Topografía, Irradiación, Síntomas acompañantes, Tratamientos empleados, Comorbilidades
Sincope **Lipotimia**	Se refieren a Medicina Interna y Cardiología. Se deben estudiar por Anemia Hipoglicemia Sd Vagal	**Examen físico Neurológico completo y test de ortostatismo.** **Laboratorio según enfermedades crónica (glicemia y hemograma)** **EKG**	Historia clínica con descripción del episodio, frecuencia, pérdida de conocimiento, Antecedentes de TCE, Tratamiento actual. Detallar el tratamiento completo con dosis que toma el paciente Test de ortostatismo: Aumento de FC 15 lxm y disminución de PAS 15 mm/hg en un periodo de 15 min entre posición de cubito dorsal a de pie
Anemia	Anemia hipocrómica con respuesta inadecuada a PESAR DE REPLANTEAMIENTO DEL TX Anemia Normo-Normo Anemia Macrocítica	**Haber cumplido con algoritmo de Gastroenterología.** **Laboratorios: hemograma, Retis, MGR, Pruebas de función Hepática y pruebas de función renal** **Guayaco #3**	**Clasificar tipo de anemia** Historia clara con antecedentes heredofamiliares, hábitos y antecedentes nutricionales; Historia Ginecobstetra.

		Niveles séricos de Fe **Niveles séricos de ácido fólico y Vitamina B12**	Indagar por cambios en el hábito defecatorio
Nefropatía	**Valoración por el Servicio de Emergencias: Insuficiencia Renal Aguda Severa** Insuficiencia Renal Crónica; si los siguientes resultados persisten por más de 3 meses (mínimo dos laboratorios con diferencia de 3 meses.) AEC ≤ 60 U/min y/o Creatinina ≥ 1.5 en hombres y 1.3 en mujeres y/o Proteinuria ≥ 0.5 gr/24 horas	**Proteinuria 24 horas y AEC** **Electrolitos** **P. F. Renal** **Hemograma** **EGO** **Ac. Úrico** **Glicemia (ayunas)** Agregar los necesarios según Enfermedades Crónicas	
Disnea inespecífica	Disnea con dificultad diagnóstica Neumopatía crónicas: fumadores, cocino con leña.	**Exámenes de laboratorios según Enfermedades Crónicas** **EKG** **Rx Tórax** **Espirometría** **Hemograma** **PFR y PFH**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
Osteoporosis	Referir solo si cumplen con al menos 3 criterios de los Factores de riesgo de Osteoporosis: *-Fractura Osteoporótica después de los 45 años* *-Uso de Glucocorticoides por >6 meses.* *-Hiperparatiroidismo diagnosticado.* *-Historia de fractura de cadera en la madre o hermana.* *-Menopausia antes de los 42 años sin TRH.* *-Menarquía después de los 16 años.* *IMC<19.5* *-Antecedentes de Hipogonadismo.* *-Diabetes Mellitas tipo 1, mal controlada.* *-Enfermedades crónicas debilitantes.* *-Tabaquismo (>10 paquetes al año).* *-Alcoholismo.* *-Inmovilización prolongada (>3 meses).*	**Dx de Osteoporosis, deseable con Densitometría ósea de Cadera y Columna: ADJUNTAR COPIA** En las referencias del EDUS deben anotarse todos los resultados de exámenes y requisitos solicitados **OSTEOPOROSIS EN ANTEBRAZO NO REFERIR**	No utilizar criterio de "Osteoporosis", en reportes de estudios de Imágenes. Debe ser diagnostico por Densitometría ósea. Diagnóstico es con -2.5 desviación estándar en el TSCORE. Indicar dieta rica en lácteos, Ejercicio físico (caminar) Asolearse
Osteopenia	No amerita referencia; EXCEPTO pacientes de alto riesgo para osteoporosis		
Valoración preoperatoria	Todos los casos	**Rx tórax** **EKG** **Hemograma** **PF Renal** **Pruebas de Coagulación** **PFT en caso de patología** **Electrolitos en pacientes con diuréticos e IECAS.**	Pacientes sin comorbilidades y con cx de moderada o alto riesgo a partir de los 50 años.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Exámenes previos	Observaciones
Osteoporosis	Referir solo si cumplen con al menos 3 criterios de los Factores de riesgo de Osteoporosis: *-Fractura Osteoporótica después de los 45 años* *-Uso de Glucocorticoides por >6 meses.* *-Hiperparatiroidismo diagnosticado.* *-Historia de fractura de cadera en la madre o hermana.* *-Menopausia antes de los 42 años sin TRH.* *-Menarquía después de los 16 años.* *IMC<19.5* *-Antecedentes de Hipogonadismo.* *-Diabetes Mellitas tipo 1, mal controlada.* *-Enfermedades crónicas debilitantes.* *-Tabaquismo (>10 paquetes al año).* *-Alcoholismo.* *-Inmovilización prolongada (>3 meses).*	**Dx de Osteoporosis, deseable con Densitometría ósea de Cadera y Columna: ADJUNTAR COPIA** En las referencias del EDUS deben anotarse todos los resultados de exámenes y requisitos solicitados **OSTEOPOROSIS EN ANTEBRAZO NO REFERIR**	No utilizar criterio de "Osteoporosis", en reportes de estudios de Imágenes. Debe ser diagnostico por Densitometría ósea. Diagnóstico es con -2.5 desviación estándar en el TSCORE. Indicar dieta rica en lácteos, Ejercicio físico (caminar) Asolearse
Osteopenia	No amerita referencia; EXCEPTO pacientes de alto riesgo para osteoporosis		
Hemopatías	Trombocitopenias crónicas Leucopenias crónicas	**Hemograma** **Ácido fólico** **B12** **HIV** **US abdomen**	Detalle exhaustivo de dosis de tratamiento crónico.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE MEDICINA PALIATIVA Y CONTROL DEL DOLOR

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

SERVICIO DE MEDICINA PALIATIVA Y CONTROL DEL DOLOR

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso).

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE MEDICINA PALIATIVA Y CONTROL DEL DOLOR

CRITERIOS DE REFERENCIA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Enfermedades crónicas progresivas **Criterios generales:** • El pronóstico clínico del paciente a criterio de su médico es limitado. Su médico no se sorprenderá si el paciente fallecería en los próximos 6 meses. • El paciente y la familia aceptan/están de acuerdo en un abordaje más paliativo que intensivo con respecto a su enfermedad fundamental. • El paciente presenta al menos uno de los siguientes dos criterios: ❖ Evidencia de progresión de enfermedad avanzada e incurable según los criterios específicos abajo detallados y/o múltiples ingresos/urgencias médicas en los últimos 6 meses y/o deterioro funcional evidente. ❖ Perdida no intencionada mayor al 10 % de su peso en los últimos 6 meses. ❖ 3 ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses por motivos de descompensación de su propia patología clínica o estancia hospitalaria reciente prolongada más de 15 días en los últimos 3 meses.				
Enfermedad cardiovascular terminal	• Disnea clase IV de la NYHA y/o angina intratable con IC secundaria • Fracción de eyección menor o igual al 20 % • Persistencia de síntomas a pesar de tratamiento adecuado	A consulta externa con prioridad.	**Ecocardiografía por cardiología menor de 6 meses**	Referir a consulta de anticoagulados en caso necesario de forma concomitante.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
	• IC refractaria y arritmias supra ventriculares o ventriculares resistentes al tratamiento.			
Enfermedad pulmonar terminal	• Enfermedad pulmonar documentada por disnea de reposo clase IV de la MRC con respuesta escasa o nula a broncodilatadores. • Progresión de la enfermedad evidenciada por incremento de las hospitalizaciones o visitas domiciliares debido a infecciones respiratorias y/o insuficiencias respiratorias. • Hipoxemia, Po2 55mmHg, en reposo a aire ambiente o SAT o2 88% con o2 suplementario, o hipercapnia, PCo2 50 mmHg o más. • Insuficiencia cardiaca derecha secundaria a patología pulmonar. • Taquicardia mayor a 100 L/m en reposo	A consulta externa con prioridad.	No requiere.	Prescripción de oxigeno domiciliar previamente coordinada con medicina interna o geriatría según criterio antes de referir
Enfermedad hepática terminal	• Albumina menor de 2.8 gr/dl • TP menor de 30% • Bilirrubina sérica de 3 mg /dl o mas • Presencia de al menos una de las siguientes comorbilidades: encefalopatía, ascitis, síndrome hepato-renal y sangrados digestivos.	Con prioridad a la consulta externa.	**PFH** **PFR** **US abdomen** **(Reciente menos de 6 meses)**	US abdominal deseable en pacientes con una puntuación de la clasificación ESCALA DE ACTIVIDAD –KARNOFSKY- superior a 65.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Enfermedad renal terminal	• Síntomas urémicos: confusión, náuseas, vómitos, prurito refractario. • Diuresis menor de 400 cc/día • Hiperkalemia mayor a 7 mEq/L que no responda a tratamiento • Pericarditis urémica, sobrecarga de fluidos intratable • Nivel de creatinina mayor a 8 mg/dl • Tasa de filtración glomerular menor o igual a 10 ml/min	Con prioridad a la consulta externa	**PFR**	
ELA	Evidencia clínica de compromiso de una de las siguientes funciones: • **Capacidad ventilatoria** • Estado funcional • Capacidad de deglución	Referir a centro nacional de control de dolor y cuidado paliativo	**Diagnostico por neurología**	Estos pacientes se manejan con un equipo especializado de ELA del CNCDYCP
Otras enfermedades de Neurona Motora	• Diagnóstico y clínica de enfermedad neurológica de neurona motora (determinadas mediante pruebas de gabinete que apoyen el diagnostico) • Progresión clínica de la enfermedad documentada.	Referir a cupo	Diagnóstico e historial clínico	
HIV terminal	• Diagnóstico clínico de SIDA • Antecedente de infección oportunista de fondo • Carga viral mayor de 100,000/ml • Conteo de CD4 menor de 25 células/ul	Prioridad a consulta externa.	**Conteo de CD4** **Historial de infectología o medicina interna**	Si el paciente llega a estabilizar su condición inmunológica egreso y cita abierta PRN.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Síndromes demenciales y enfermedad cerebro vascular terminal	• Edad mayor de 65 años • Estado funcional Barthel menos de 50 puntos • Deterioro cognitivo grave (mini-mental menor de 14) • Presencia de complicaciones tales como: enfermedades comórbidas, infecciones a repetición (urinarias, respiratorias), uso de oxigeno suplementario, pielonefritis, sepsis. • Desnutrición (perdida igual o mayor al 10 % del peso corporal no intencionada en los últimos 6 meses o IMC menor o igual a 18,5 y/o albumina menor de 2,5 g/dl) • Claudicación familiar • Presencia de ulceras por presión grado 3 o 4	Prioridad a consulta externa	**Control con geriatría previo** **Referir de forma oportuna para paleo oportuno.**	Si presenta ulceras por presión referir concomitante a clínica de ulceras para manejo conjunto. Si el paciente llega a estabilizar su condición de fondo egreso y cita abierta PRN.
DOLOR CRÓNICO DE DIFÍCIL MANEJO				
Dolor crónico de difícil manejo.	• Que exista un Diagnostico claro de la causa del dolor ya establecida en el paciente. • Fracaso terapéutico con: Poca respuesta al tratamiento específico que se esperaba respondiera de forma adecuada, o que no se pueda administrar por alguna causa.	Cupo	**PFR** **PFH** **Historial clínico, con sus respectivos exámenes de gabinete según patologías**.	El diagnostico etiológico es responsabilidad del médico referente. La CCDCP debe ser comprendida como un colaborador del especialista o médico general en el control del dolor de difícil manejo. No es una instancia para establecer diagnósticos o dar seguimientos.

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
				Una vez controlado el dolor el paciente será contra referido al médico tratante original. Lumbalgias: referir casos con patologías definidas con una clara causa de dolor crónico, los otros casos manejar con fisiatría, escuela de espalda, ortopedia y nutrición
ENFERMEDAD ONCOLÓGICA TERMINAL				
Paciente con enfermedad oncológica terminal	• Paciente con Diagnostico ya establecido de enfermedad oncológica terminal por el segundo nivel de atención. • Con cumplimiento de alguno de los criterios generales para envió a CCDCP • Referir de forma temprana para abordaje multidisciplinario efectivo.	Prioridad a la consulta externa	**Diagnostico oncológico definido.**	Referir para tratamiento paliativo de forma temprana con diagnósticos de fase terminal franca.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE NEUROLOGIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE NEUROLOGIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
    - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
    - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
    - Antecedentes Heredofamiliares
    - Antecedentes Quirúrgicos
    - Examen físico completo enfatizando en examen neurológico

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso)

4. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente.** Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.
5. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**

6. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE NEUROLOGIA

Patología	Criterio de referencia	Prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Cefalea	Referir pacientes con los siguientes diagnósticos. Cefalea tensional Cefalea refractaria Migraña no complicada Migraña complicada Cefalea Nuevo en mayores de 50 años	Cefalea matinal referir a URGENCIAS Cefalea de debut reciente referir a URGENCIAS Todos los demás a cupo		Tratamiento sugerido para manejo en el primer nivel para las demás cefaleas crónicas: Epival 2 TAB HS por 4 meses Amitriptilina 10mg HS (Si hay somnolencia al día siguiente continuar el tratamiento ya que este desaparece posteriormente.) Pacientes ya estudias con TAC se continúan en primer nivel de atención con el tratamiento anterior. CONTRAINDICADO en cefaleas crónicas el uso de AINES y analgésicos Indicar si hay TAC previo y especificar fecha del mismo.
Epilepsia	Referir pacientes con: Debut reciente Pacientes crónicos con difícil manejo	Los debuts recientes a emergencias Los crónicos a la consulta externa a cupo		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Evento cerebrovascular o isquemia cerebral transitoria	Eventos agudos todos al servicio de urgencias en el menor tiempo posible	Referir urgente servicio urgencias Y de ahí se valora por neurología		Control de PA, GLICEMIA Y DILIPIDEMIA en pacientes del 1 nivel posterior a un ICTUS, control enfatizado en control de enfermedades crónicas.
	Eventos crónicos seguimiento en los EBAIS controlando PA, GLICEMIA y lípidos.	No referir		
Neuropatía	Diabética no dolorosa Diabética dolorosa	No referir		Manejo en el primer nivel de atención Con tratamiento Carbamazepina 1 TAB BID Amitriptilina 10mg HS Vitaminas b12 y b1 Control de estricto de glicemia.
Demencia	Referir todas a psiquiatría las de causa no orgánica Y a geriatría según criterio clínico.		Niveles de B12 y Ácido fólico VDRL HIV PFT PFH PFR Perfil lipídico Electrolitos TORCH TEST Cisticercosis	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Vértigo	Referir a ORL para valoración previa Y hacer distinción de vértigos central y periféricos.	Cupo		
Esclerosis múltiple	Todos los casos; seguir criterios de la patología o sospecha de la misma.	Cupo		
Enfermedad de Parkinson, tremor, coreas, otros trastornos del movimiento	Todos los casos	Cita cupo		
Lumbalgia	Referir a Ortopedia			Se realizará manejo en conjunto de ser necesario por neurología
Síncope o lipotimia	Referir a Medicina Interna o Cardiología			Primero descartar con especialidades antes mencionadas por frecuencia de etiología de los sincopes o lipotimias

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA

Conducción:

- **Msc. Carlomagno Santiesteban Ávila – Supervisor Regional de Odontología**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Elaborado por:

- **CAIS Siquirres**
- **Hospital Tony Facio Castro**
- **Áreas de Salud de la RHA**
- **RISSHA**

GUIAS DE REFERENCIA – ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA – RISSHA AÑO 2017

Indicaciones generales:

1. Las Referencias deberán cumplir con los lineamientos para la Asignación de Citas a pacientes que se refieren para la Atención de Odontología Especializada indicados por la Gerencia Médica.

2- Toda referencia debe incluir; Nombre del Centro de procedencia, Nombre del Odontólogo General que refiere y fecha. Edad del usuario, Antecedentes Patológicos y no Patológicos, Sintomatología, Tiempo de Evolución y Tratamiento recibido; así como Examen Físico y Estudios de Gabinete solicitados según Patología.

3- Justificación clara del Motivo de Referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una Impresión Diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un Segundo Nivel de Atención, y porqué se agotó la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel.

4- Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

GUIAS DE REFERENCIA – ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA –ODONTOLOGÍA GENERAL AVANZADA (OGA)

Simbología:

Rojo: Requisito Obligatorio

Verde: Requisito Deseable

Morado: Requisito Consenso entre OGAS

Azul: Protocolo No Validado por Nivel Central

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Dientes incluídos(K010) e impactados (K011) **Dientes Supernumerarios (K001)** **Raíz Dental retenida (K083)**	• **Grado II, III y IV Asintomático** • **Grado II, III y IV Sintomático** • **Restos Radiculares** • **Intentos Fallidos de exodoncias**	• **3 (Cita a Cupo)** • **1 (Cita Urgente)**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Fase higiénica** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS** • **Exámenes (15 días previo a cita preoperatoria, (Hemograma, TP-TPT-INR, VDRL, PFR, Glucosa)**	**Tratar todos los pacientes en el I nivel con AINES y antibióticos (PRN) previo envío a II nivel.**
Periodontitis Aguda (K052) **Periodontitis Crónica (K053)**	• **Bolsas Periodontales mayores 5-6 mm** • **Movilidad Tipo Grado II** • **Hemorragia Gingival**	• **3 (Cita a Cupo)**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017).** • **Fase higiénica** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS** • **Exámenes (15 días previo a cita preoperatoria, (Hemograma, TP-TPT-INR, VDRL, PFR, Glucosa)** • **Raspado general 1-2 semanas previo a cita valoración 1 era vez**	**Indicar en Observaciones el Grado de Bolsa**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Otras Enfermedades Periodontales (K055) **GUNA Y PUNA** **Abscesos Gingivales/ Periodontales** **Periodontitis agresiva localizada / generalizada**	• **Necrosis Periodonto**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)** • **Definir claramente la Patología del paciente en el Código K055 Al OGA**	**Control del dolor AINES IM o VO** **Iniciar Terapia Antibiótica de inmediato** **Amoxicilina 500mg + Metronidazol 500mg**
Anomalías Dentofaciales **Anomalías de la Relación MaxiloBasilar (K071)**	• **Clase II Dental** • **Clase III** • **Mordida Cruzada anterior y posterior** • **Desviación de la Línea media** • **Diastemas** • **Aumento overjet y overbite** • **Apiñamiento** • **Hábitos**	• **3(Cita a cupo)** • **2 Cita con Prioridad (edades 10-11 años)**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red ortopedia Funcional Correctiva, Interceptiva y Preventiva, 2016)** • **Fase higiénica completa**	**Rango de Edades Captación de Pacientes por Segundo Nivel según Centro Referencia** **HTFC Limón (5 – 14 años)** **CAIS Siquirres (5 -11 años)**

Anomalías de relación de los Arcos Dentarios(K072) **Anomalías de la posición del diente (K073)** **Maloclusión de tipo no especificado (K074)** **Anomalías Dentofaciales funcionales (K075)**			• **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS** • **Radiografía del dedo MP3** • **Adolescentes y niños con Potencial de Crecimiento óseo (deseado)** 	
Trastornos Temporomandibulares **(K076)**	• **Subluxación ATM** • **Desplazamiento disco con** • **reducción / sin reducción** • **Ruidos Articulares** • **Neuralgias Trigémino**	• **3 (Cita a Cupo)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Fase higiénica** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS**	**Sintomatología (Tratar todos los pacientes en el I nivel con AINES)**

	• Parálisis Facial posterior AVC • Mialgias . • Bruxismo Céntrico . • Bruxismo Excentrico			
Trastornos Temporomandibulares (K076) **(Referencia Urgente** **Atendida mismo día)**	• **Luxación**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central .** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a Odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención** • **Coordinar traslado institucional IDA Y VUELTA**	**Control del dolor AINES IM** **Diazepam 5mg VO previo a traslado.**
(S024 - FRACTURA DEL MALAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR) **Fractura Maxilar**	• **Fractura Lefort I, II, III** • **Fractura Mandíbula** ○ **Sínfisis** ○ **Para sínfisis** ○ **Cuerpo** ○ **Angulo** ○ **Subcondilea**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA**	**Control del dolor AINES IM**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

(S026 - FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR) Fractura Mandibular **(Referencia Urgente** **Atendida mismo día)**			• **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención** • **Coordinar traslado institucional IDA Y VUELTA**	
S025(Fractura de los Dientes) **Fractura Dentoalveolar** **(Referencia Urgente** **Atendida mismo día)**	• **Avulsión Dental** • **Intrusión Dental** • **Fractura Proceso Alveolar** • **Fractura tuberosidad Maxilar**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención** • **Coordinar traslado institucional IDA Y VUELTA**	**Control del dolor AINES IM**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Enfermedades de los Maxilares no Especificada (K109) **Comunicación Oro-antral/Oro-sinusal**	• **Comunicación Seno Maxilar** • **Sinusitis Maxilar** • **Desplazamiento piezas dentales a otros espacios**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención** • **Coordinar traslado institucional IDA Y VUELTA**	**Control del dolor AINES y Antibióticos posterior a procedimiento**
Alveolitis (K103)	• **Alveolitis Seca** • **Alveolitis Húmeda**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención**	**Control del dolor AINES y Antibióticos posterior a procedimiento**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Abscesos faciales (Celulitis y Absceso de Boca) (K122)	• **Origen Odontogénico** • **Origen No odontogénico**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención** • **Coordinar traslado institucional IDA Y VUELTA**	**Control del dolor AINES** **De origen Odontogénico iniciar terapia antibiótica**
Pacientes con Compromiso Sistémico que requieren Tratamientos Invasivos Odontológicos (Exodoncias, Periodoncia, Cirugía Oral Menor)	**Cardiopatías, reemplazos válvula cardiaca** **• Previo, Durante y Post Trasplante órganos** **•Previo, Durante y Post Quimioterapia**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)** • **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía**	**Adjuntar referencia de médico especialista solicitando la eliminación de focos de infección a nivel oral** **Recordarle al paciente presentarse con Epicrisis**

	• Previo, Durante y Post Radioterapia • IAM / AVC • VIH+ •Todos los Anticoagulados • Previo y durante Terapia Bifosfonatos orales e IV		oral menor, mayor y maxilofacial, 2016) • Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA • Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención	para respaldo en cita 1 era vez OGA
(K089 - TRASTORNO DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOSTEN, NO ESPECIFICADO)	• Rebordes Irregulares y Espículas Óseas	• 3 (Cita a Cupo)	• (Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016) • Fase higiénica • Odontograma Digital en los Servicios con EDUS • Exámenes (15 días previo a cita preoperatoria, (Hemograma, TP-TPT-INR, VDRL, PFR, Glucosa)	
(K090 - QUISTES ORIGINADOS POR EL	Quistes odontogénicos Queratoquiste	• (3) Cita a Cupo	• (Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

DESARROLLO DE LOS DIENTES) **(K098) Otros Quistes de la Región Bucal No Clasificados en otra parte**	**Quiste Dentígero** **Quiste Erupción Dentaria** **Quiste Folicular** **Quiste Gingival** **Quiste Lateral** **Quiste Primordial**		• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Fase higiénica** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS** • **Exámenes (15 días previo a cita preoperatoria, (Hemograma, TP-TPT-INR, VDRL, PFR, Glucosa)**	
(K116) Mucocele de la Glándula salival	**Ránula** **Mucocele**	• **(3) Cita a Cupo**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)** • **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

			• **Fase higiénica** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS** • **Exámenes (15 días previo a cita preoperatoria, (Hemograma, TP-TPT-INR, VDRL, PFR, Glucosa)**	
Patología Pre-maligna **(K132 - LEUCOPLASIA Y OTRAS ALTERACIONES DEL EPITELIO BUCAL, INCLUYENDO LA LENGUA)**	• **Leucoplasia** • **Eritroplasia** • **Eritroleucoplasia** • **Paladar del Fumador** • **Ulceras**	• **1 (Cita Urgente,)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente a odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención**	**Si es posible con visto bueno por parte del paciente registrar imagen de lesión, y descripción clara de la patología en referencia incluyendo, síntomas, tiempo de evolución, tamaño, cambios de coloración**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

(K134) Granuloma y Lesiones semejantes de la mucosa	**Granulomas**	• **(3) Cita a Cupo**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)** • **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS**	
(K135) Fibrosis de la Submucosa Bucal	• **Fibroma**	• **(3) Cita a Cupo**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de Periodoncia, 2017)** • **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Odontograma Digital en los Servicios con EDUS**	
Patología Maligna	• **Todo tipo Carcinoma ORAL**	• **1 (Cita Urgente)** • **Abordado en el momento que ingresa a la Nosocomio**	• **(Manejo paciente según protocolo atención clínica en red de cirugía oral menor, mayor y maxilofacial, 2016)** • **Coordinar con II nivel, y explicar claramente condición actual del paciente**	**Si es posible con visto bueno por parte del paciente registrar imagen de lesión, y descripción clara de la patología en referencia incluyendo, síntomas, tiempo de evolución, tamaño, cambios de coloración**

(Z031 - OBSERVACION POR SOSPECHA DE TUMOR MALIGNO) **(C029 - TUMOR MALIGNO DE LA LENGUA, PARTE NO ESPECIFICADA)** **(C419 - TUMOR MALIGNO DEL HUESO Y DEL CARTILAGO ARTICULAR NO ESPECIFICADO)** **(Z080 - EXAMEN DE SEGUIMIENTO CONSECUTIVO A CIRUGIA POR TUMOR MALIGNO)** **(C01X - TUMOR MALIGNO BASE DE LA LENGUA)**			**a odontólogo OGA** • **Tomar en cuenta recomendaciones por parte del II nivel Atención** • **Coordinar cita valoración OGA en el momento se sospechar malignidad**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

(C069 - TUMOR MALIGNO DE LA BOCA, PARTE NO ESPECIFICADA) **(C030 - TUMOR MALIGNO DE LA ENCIA SUPERIOR)** **(C031 - TUMOR MALIGNO DE LA ENCIA INFERIOR)** **(C080 - TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA SUBMAXILAR)** **(C081 - TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA SUBLINGUAL)** **(C089 - TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA SALIVAL**				

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

MAYOR, NO ESPECIFICADA) **(C039 - TUMOR MALIGNO DE LA ENCIA, PARTE NO ESPECIFICADA)** **(C060 - TUMOR MALIGNO DE LA MUCOSA DE LA MEJILLA)** **(C040 - TUMOR MALIGNO DE LA PARTE ANTERIOR DEL PISO DE LA BOCA)** **(C80X - TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO ESPECIFICADOS)** **(C411 - TUMOR MALIGNO DEL HUESO DEL MAXILAR INFERIOR)**				

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

(C009 - TUMOR MALIGNO DEL LABIO, PARTE NO ESPECIFICADA) **(C059 - TUMOR MALIGNO DEL PALADAR, PARTE NO ESPECIFICADA)** **(C051 - TUMOR MALIGNO DEL PALADAR BLANDO)** **(C310 - TUMOR MALIGNO DEL SENO MAXILAR)** **(C798 - TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS)**				

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA – ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA: ENDODONCIA

Simbología:

Rojo: Requisito Obligatorio

Verde: Requisito Deseable

Morado: Requisito Consenso entre OGAS

Azul: Protocolo No Validado por Nivel Central

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Pulpitis Sintomática (K040)	**DOLOR AGUDO, ESPONTANEO, EXPOSICION PULPAR**	**1 (Cita Urgente)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo** • **Extirpación inmediatamente, irrigación NaOCl (Hipoclorito Sodio)**	**Tratar los pacientes con AINES en caso de ser necesario**
Pulpitis Asintomática (K040)	**LESION CARIOSA O TRAUMATICA, NO SIGNOS CLINICOS**	**3 (No Urgente)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo**	
Periodontitis Apical Sintomática (K045)	**DOLOR AGUDO AL MORDER ,PALPACION ,PERCUSION CON O SIN ZONA RADIOLUCIDA**	**1 (Cita Urgente)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo** • **Extirpación inmediatamente, irrigación NaOCl (Hipoclorito Sodio)**	**Tratar los pacientes con AINES en caso de ser necesario**
Periodontitis Apical Asintomática (K045)	**ZONA RADIOLUCIDA ASINTOMATICA**	**3 (No Urgente)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo** • **Extirpación inmediatamente, irrigación NaOCl (Hipoclorito Sodio)**	**Tratar los pacientes con AINES en caso de ser necesario**
Absceso apical agudo (K047)	**DOLOR A PRESION,INFLAMACION DE RAPIDA APARICION,DOLOR ESPONTANEO**	**1 (Cita Urgente)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo.** • **Drenaje intra-conducto (extirpación) o vestibular.**	**Tratar los pacientes con AINES y antibióticos en caso de ser necesario**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Absceso apical crónico (K046)	**TRACTO FISTULOSO ACTIVO O NO(FISTULA)MOLESTIA LEVE O NINGUNA**	**3 (A Cupo)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo**	**Tratar los pacientes con AINES y antibióticos en caso de ser necesario**
Lesiones de Encía y de la Zona Edéntula asociadas con Traumatismo (K062)	**Todo tipo de TRAUMA DENTO-ALVEOLAR** • **Avulsión Dental** • **Intrusión Dental**	**1 (Cita Urgente)**	• **Protocolo No Validado por Nivel Central** • **Diagnóstico Presuntivo** • **Limpieza ,reposición y ferulizacion si es necesario .**	**Tratar los pacientes con AINES y antibióticos en caso de ser necesario**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

- Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
- Antecedentes Heredofamiliares
- Antecedentes Quirúrgicos
- Examen físico completo

3. **Justificación clara del motivo de referir a este paciente.** Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

4. **Los casos considerados como urgentes deben referirse directamente al Servicio de Urgencias y NO A LA CONSULTA EXTERNA.**

5. Los pacientes que lleguen al Servicio de Emergencias durante el tiempo extraordinario (De lunes a jueves de 4pm a 7am y viernes desde las 3pm hasta lunes 7 am); debido a alguna patología ocular aguda, deben ser enviados al hospital que cuente con oftalmólogo de disponibilidad durante este tiempo para su valoración. Durante este tiempo el paciente es responsabilidad del médico tratante y del Servicio de Emergencias.

Patologías que debe ser Referida al Servicio de Emergencias

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Deberán ser referidas al servicio de Urgencias	✓ **Sospecha de Glaucoma Agudo** o Dolor ocular intenso unilateral o Midriasis media no reactiva a la luz (anisocoria) o No responden a ningún analgésico o Junto con alguno de los siguientes síntomas o Cefalea inicialmente en hemicara, la cual se puede hacer universal o Visión borrosa o Náuseas y/o vómitos o Disminución de la agudeza visual o Halos de luces o Congestión conjuntival severa ✓ **Estrabismo Traumático** (realizar TAC de órbita con cortes finos y macizo facial con reconstrucción 3D) ✓ **Estrabismo súbito** ✓ **Pérdida de la visión súbita de CUALQUIER índole** ✓ **Quemaduras oculares con ácidos o base** o Realizar lavado ocular previo a envío o Referir el paciente a emergencias para que sea enviado para valoración por oftalmólogo ya que se debe evaluar la profundidad de la lesión. o Si es de compromiso superficial, parchar por 24hrs y enviar a la consulta externa ✓ **Traumas oculares con cortadoras de zacate, piedras, proyectiles, explosivos, botellas, alambre de púas, punzones, entre otros** ✓ **Heridas penetrantes de ojo**

	✓ **Herpes Zoster con compromiso de rama del trigémino. Referir a emergencias** ✓ **Celulitis post septal.** o Para sospechar el diagnóstico se tiene que considerar el dolor a la movilización ocular tan importante que tendrá el paciente. Se confirma el diagnóstico mediante un TAC. o Edema, eritema y datos inflamatorios peri-orbitarios. ✓ **Diplopía** o Definir si es mono o binocular, en cual posición de la mirada se presenta y tiempo de evolución, función pupilar o Hacer examen neurológico completo o Considerar en el diagnóstico diferencial las causas vasculares, neurológicas y musculares. o Realizar exámenes de laboratorio, química o TAC cráneo con y sin medio de contraste

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA CRITERIOS DE REFERENCIA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Tumores malignos de cualquier parte del globo o anexos	Presencia de lesión pigmentada o no de bordes elevados e irregulares acompañada de vascularización y de crecimiento rápido.	Urgente a la consulta externa	No requiere	
Uveítis agudas o crónicas agudizadas	Dolor ocular intenso acompañado de ojo rojo y diminución de la agudeza visual	Urgente a la consulta externa	No requiere	
Cuerpo extraño por cortadura de metal o por soldadura	Presencia de cuerpo extraño en ojo.	Urgente a la consulta externa	No requiere	• Si se logra extraer el cuerpo extraño se coloca un parche ocular con terramicina por 24 horas y luego iniciar Meticel 1 gota cada 2 horas por 5 días. • Si no se logra extraer el cuerpo extraño, se coloca un parche con terramicina por 24 horas, y referir urgente para la valoración por Oftalmología al día siguiente.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Neuritis ópticas y papiledemas	Disminución de la agudeza visual acompañado de cefaleas, náuseas o vómitos y Dolor ocular a los movimientos oculares	Urgente a la consulta externa	No requiere	
Queratitis infecciosas (ulceras corneales)	• Sensación de cuerpo extraño con ojo rojo, puede ser después de un episodio de conjuntivitis de más 10 días de evolución. • Vesículas costrosas en hemicara con dolor que toman ramas del 5to par craneal. • Uso de lente de contacto comienzan con ojo rojo y dolor.	Urgente a la consulta externa	No requiere	Retirar lente de contacto urgente.
Perdidas Súbitas de la agudeza visual	Referir ante perdida súbita de la agudeza visual	Urgente a la consulta externa	Valoración de agudeza visual con test de Snellen	• Realizar una buena historia clínica en relación con la perdida de la agudeza visual • Pacientes miopes o no miopes con fotopsias (visión de relámpago o moscas volantes) pensar en desgarro retinianos.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Trauma ocular importante de cualquier origen	• Referir ante cualquier trauma ocular importante. • Heridas del Angulo interno que lleven al compromiso de una sección del canalículo lacrimal.	Urgente a la consulta externa	No requiere	• Enviar parchado y con urgencia. No aplicar ningún colirio ni pomada ni ungüento a la lesión. • Pacientes miopes o no miopes con fotopsias (visión de relámpago o moscas volantes) pensar en desgarro retinianos. • Referir urgente a emergencias si presenta pérdidas de contenido ocular.
Escleritis y epiescleritis	Dolor ocular y ojo rojo	Urgente a la consulta externa		• Generalmente muchos presentan antecedentes de enfermedad reumática de fondo.
Orzuelo	Referir después de 7 días de tratamiento, sin respuesta adecuada.	Cupo	Debe recibir Tratamiento previo con Terramicina en ungüento HS y Fluorometalona 1 gota QID.	Se refieren a la consulta externa, valorar idealmente antes de que pase 1 mes

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Conjuntivitis	Después de 5 días de tratamiento, sin respuesta adecuada	Prioridad a la consulta externa	Debe recibir tratamiento previo con Terramicina en ungüento HS, (mas Fluorometalona Hipromelosa y Gentamicina)	Recomendar lavado de manos constante y no usar paños para limpiarse los ojos. Incapacidad según Normativa.
Cataratas	Disminución de agudeza visual de forma lenta y progresiva con opacidad del cristalino.	Cupo O con prioridad si presenta Opacidad total.	No requiere	Valorar agudeza visual con test de Snellen
Pterigion	Sintomáticos se deben de referir a la consulta externa Pterigiones que sobrepasen el limbo cornoescreral	cita a cupo		Asintomáticos no referir Tratar con Hipromelosa PRN

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Obstrucciones de la vía lagrimal	Epifora de lagrimeo constante con aumento de volumen a nivel saco lacrimal acompañado de dolor.	Prioridad a la consulta externa	No requiere	
Estrabismo	Referir preferiblemente niños menores de 2 años	Prioridad a la consulta externa	No requiere	
Queratocono y otras ectasias o degeneraciones corneales	Disminución de la agudeza visual, en ocasiones con opacidad corneal	Cupo	Optometría	Antecedente de queratocono en familia

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Perdida crónica de la agudeza visual	Referir pacientes con historia y test de Snellen alterado.	Cupo	**Optometría**	Si nos posible la atención previa de Optometría, se debe anotar muy claramente en la referencia los hallazgos del fondo de ojo que justifiquen la referencia a especialidad
Blefaritis e irritaciones conjuntivales crónicas	Escamas en la raíz de las pestañas acompañada de ojo rojo.	Prioridad a la consulta externa		Realizar lavados oculares, con champú de niño a nivel de pestañas, terramicina BID y HS y gentamicina una gota c / 2 horas -
Triquiasis y otras anormalidades de la posición de los párpados	Pestañas invertidas, que contactan la córnea.	Con prioridad si hay sospecha de lesión corneal.		Referir ante la sospecha de posible lesión corneal o junto con la presencia de ojo rojo. Educar pacientes y familiares en cuanto a manejo.
Ectropión, entropión y otras anormalidades de la posición de los parpados	Eversión o inversión de los parpados, con más frecuencia el inferior	Prioridad 1 o Cita a cupo (según clínica)		• En caso de des epitelización corneal o úlcera referir con prioridad para su valoración • Si no hay ulcera Cita a cupo en consulta externa

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Pingueculas y otras anomalías de la conjuntiva no tumorales	Engrosamiento conjuntival que no sobrepasa el limbo esclerocorneal	No referir		Tratar con hipromelosa 1 gota cada hora y protección del sol Tratamiento de primer nivel.
Glaucoma Crónico	Antecedente familiar de glaucoma, o ceguera. Disminución de la visión con disminución de la agudeza visual.	Prioridad a la consulta externa	**Optometría**	Realizar test de agudeza visual y campimetría por confrontación.
Chalazión	Aumento de volumen circunscrito a nivel espesor de parpado superior o inferior	Cupo		Tratar con terramicina BID y HS, dexametasona con neomicina 1 gota TID y si no resuelve a la semana referir a oftalmología.
Retinopatía diabética, retinopatías asociadas a la edad	Todo paciente DM tipo 2 requiere FO al diagnóstico	Cupo		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Proptosis de globo ocular	Proptosis significativa unilateral del globo ocular (exoftalmos)	Urgente a la consulta externa	**TSH**	Se debe de estudiar el paciente con TAC

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE ONCOLOGIA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ONCOLOGIA HCG

SERVICIO DE ONCOLOGIA QUIRURGICA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Indicaciones generales

1. Todas las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas de pacientes que se refieren a la atención de medicina especializada indicados por la Gerencia Medica.

2. Datos indispensables que debe contener la referencia

   - ✓ Datos de identificación del usuario completos, incluyendo edad, sexo, estado civil, escolaridad y condición laboral.
   - ✓ Centro de procedencia y fecha, nombre y código del médico que refiere.
   - ✓ Antecedentes Personales Patológicos (APP), síntomas y signos, tiempo de evolución y tratamiento utilizado.
   - ✓ Antecedentes Personales NO Patológicos (APnP), uso de alcohol, tabaco u otras drogas, transfusiones sanguíneas anteriores, alergia a medicamentos.
   - ✓ Antecedentes Heredofamiliares (AHF), relevantes, particularmente oncológicos
   - ✓ Antecedentes Quirúrgicos
   - ✓ Examen físico completo y claro

3. Documentos o exámenes a adjuntar o cualquier otro requisito necesario
   Estudios previos realizados donde se determinó el diagnostico o impresión diagnostica, importante incluir copias de reporte de resultados y originales de láminas, fotos, placas de RX, US u otros, así como reporte de Biopsias (recordar que algunos tipos de cáncer requieren inmunohistoquímica por lo cual es indispensable contar con los bloques de biopsia para completar estudios).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

4. Justificación o motivo de referencia

   Diagnóstico claro o bien impresión diagnostica por lo que se refiere al paciente, para atención del caso en un centro especializado según corresponda al nivel de atención (Tercer Nivel).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ONCOLOGIA / CRITERIOS DE REFERENCIA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
TUMORES DE CABEZA Y CUELLO **Revisar con especialista de cabeza y cuello**	Lesiones o Tumoraciones (Nódulos) de más de 2-3 cm o con crecimiento acelerado localizadas en cabeza o cuello, solidas o semisólidas, con bordes irregulares, adheridas o no a planos profundos, sospechosas o con diagnóstico de malignidad. • Factores de Riesgo ➢ Antecedentes heredofamiliares positivos ➢ Historia de radiación en cuello ➢ Sexo masculino TUMORES DE GLANDULA TIROIDES TUMORES DE CAVIDAD ORAL TUMORES DE FARINGE Y LARINGE	Prioridad	RX Correspondiente US Correspondiente Biopsia (Si es posible) Tac (Si es posible)	Enviar reportes de resultados (Copia) y fotografías, láminas o placas de los diferentes estudios. Reporte de Biopsia Examen Físico
TUMORES DE MAMA	Lesiones en una o ambas mamas con diagnósticos o sospecha fehaciente de malignidad • **Edad: cualquiera**	Prioridad	MAMOGRAFIA US MAMAS En ***mujeres asintomáticas*** la solicitud de ultrasonido de mama debe basarse en un	Enviar reportes de resultados (Copia) y fotografías, láminas o placas de los diferentes estudios. Prioridad: BIRADS 4 Y 5 Reporte de Biopsia

	➢ Masa dominante: masa palpable, con bordes irregulares, adherida a planos profundos. ➢ Secreción del pezón sin masa dominante: Persistente y reproducible al examen físico, espontáneo y/o unilateral. ➢ Sospecha clínica de cáncer de mama inflamatorio: senos enrojecidos, inflamados y calientes, la piel del seno también puede tener un color rosa, rojizo amoratado o magullado, rebordes o parecer como si estuviera picada, así como la piel de una naranja. Otros síntomas son pesadez, ardor, dolor, aumento del tamaño del seno, sensibilidad o pezones invertidos (sumidos hacia adentro). ➢ d) Sospecha clínica de Enfermedad de Piaget. • **Riesgo aumentado** ➢ Radioterapia torácica previa. ➢ Antecedente de Hiperplasia atípica/cáncer lobulillar in situ. ➢ Historia Previa de Cáncer de Mama ➢ Antecedente Heredofamiliar de Cáncer de Mama en Primer o Segundo grado de consanguinidad		resultado previo de mamografía. En ***mujeres sintomáticas*** la solicitud de ultrasonido de mama debe contener información sobre las características de la paciente, su condición clínica, y la razón por la que se solicita el estudio. BIOPSIA (Si es posible)	Examen Físico de Mamas
TUMORES DE TUBO DISGESTIVO E HIGADO	Lesiones en Tubo Digestivo o Hígado sospechosas o con diagnóstico de malignidad. Masas abdominales palpables, dolorosas o no, móviles o no, o bien con sintomatología o factores de riesgo asociado.	Prioridad	Gastroscopia US Abdomen Biopsia (Si es posible) Tac (Si es posible)	Enviar reportes de resultados (Copia) y fotografías, láminas o placas de los diferentes estudios. Reporte de Biopsia Examen Físico

	• Sintomatología asociada ➢ Pérdida de peso ➢ Hematemesis ➢ Melena ➢ Dolor abdominal o no ➢ Masa abdominal palpable ➢ Anemia Crónica • Factores de Riesgo ➢ 1er y/o 2do grado consanguinidad Ca. Gástrico, Hígado o Páncreas ➢ Hepatopatía Crónica ➢ Ulcera gástrica crónica ➢ Otros			
TUMORES DE COLON, RECTO Y/O ANO	Lesiones en Colon, Recto o Ano sospechosas o con diagnóstico de malignidad • Sintomatología asociada ➢ Pérdida de peso sin razón aparente ➢ Guayaco positivo ➢ Presencia o no de Dolor abdominal, Pélvico o Rectal ➢ Estreñimiento Agudo o Crónico ➢ Masa abdominal, pélvica o rectal palpable ➢ Melena o Rectorragia ➢ Anemia crónica • Factores de Riesgo ➢ Antecedentes heredofamiliares de pólipos adenomatosos.	Prioridad	Laboratorios (Guayaco #3 seriados, y otros) Colonoscopia Rectoscopia US Abdomen Biopsia (Si es posible) Tac (Si es posible)	Enviar reportes de resultados (Copia) y fotografías, láminas o placas de los diferentes estudios. Reporte de Biopsia Examen Físico y Tacto Rectal

	➢ Antecedentes personales de pólipos o Ca. colon/recto. ➢ Antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn y/o Cuci) ➢ Antecedentes heredofamiliares de Cáncer de Colon o Recto en primer grado de consanguinidad.			
TUMORES DE LA PIEL (MELANOMA)	Lesiones en la piel sospechosas o con diagnóstico de malignidad (ABCDE) • Características de Malignidad ➢ Asimetría ➢ Bordes irregulares ➢ Diferentes tonos de color en la mancha ➢ Tamaño mayor de 6 mm. ➢ Observación de cambios: en tamaño, color, forma, elevación, sangrado, picazón o costra.	Prioridad	Biopsia de lesión sospechosa (Ideal, no retrasar atención del paciente)	Reporte de Biopsia Examen Físico Claro
TUMOR DE PULMON	Pacientes con Sospecha de Cáncer de Pulmón • Sintomáticos con Factores de Riesgo <u>Al menos dos Factores de Riesgo y un síntoma</u> ➢ Edad: igual o mayor de 50 años. ➢ Tabaquismo de alto consumo: 20 o más paquetes/año activo o menos de 15 años de haberlo dejado.	Prioridad NEUMOLOGIA CIRUGIA TORAX	Rx Torax Postero-anterior y Lateral. Si tiene Rx Torax anteriores anexarlas. Esputos por BK Otros laboratorios (adjuntar copia)	Rx Torax (AP y Lat) enviar las radiografías (si no se puede contar con Rx al momento de la referencia, anotarlo en la misma). Reporte de resultado de laboratorio por BK y otros laboratorios (adjuntar copia).

	➢ Antecedentes de: EPOC, exposición ocupacional o ambiental a tóxicos, ➢ Antecedentes de Cáncer de pulmón previo. ➢ Radioterapia de tórax hace más de 10 años. **Signos y síntomas** (>3 semanas sin causa): tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis, pérdida de peso, hipocratismo, disfonía, linfadenopatía cervical o supraclavicular, estridor, síndrome vena cava, signos sugestivos de metástasis. • Sospecha Radiológica ➢ Nódulo pulmonar sospechoso de malignidad según criterio de radiólogo. ➢ Hallazgos radiológicos con o sin reporte: nódulo mayor o igual a 1 cm., masa pulmonar mayor de 3 cm., ensanchamiento mediastinal de origen no vascular (aorta y vasos pulmonares), derrame pleural, consolidaciones de lenta resolución (8 semanas o más).			
TUMOR DE CERVIX Y VAGINA (Carcinoma Invasor)	Lesiones en Cérvix o Vagina sospechosas o con diagnóstico de malignidad. En Pacientes sintomáticas o asintomáticas. PAP Alterado – Colposcopia Y/O Biopsia de Lesión = Carcinoma Invasor • Factores de Riesgo	Prioridad GINECOLOGÍA - ONCOLOGÍA	Citología Vaginal US Pélvico Biopsia de lesión	Reporte de PAP (citología)(Copia) US pélvico (reporte y fotografías) Reporte de Biopsia (copia) Examen físico ginecológico

	➢ ETS previas ➢ Infección virus Papiloma Humano (VPH) ➢ Relaciones coitales antes de 16 años ➢ Tres o más compañeros sexuales.			
TUMOR DE PROSTATA	Alteraciones prostáticas sospechosas o con diagnóstico de malignidad. En Pacientes sintomáticos o asintomáticos. • Factores de riesgo asociado ➢ Padre y/o hermano con Ca de próstata ➢ Afroamericano ➢ Edad > 50 años • Alto riesgo ➢ Tacto rectal sospechoso con cualquier valor de Antígeno prostático. ➢ Tacto rectal normal pero: ✓ Antígeno prostático mayor a 3 ng/ ml sin patología benigna. ✓ Antígeno prostático mayor a 3 ng/ ml y patología benigna tratada con control a las 6 semanas y sigue alterado. ✓ Aumento de Antígeno prostático mayor de 0.4 ng/ml/ año.	Prioridad UROLOGIA	APE / PSA US Próstata Biopsia (si es posible)	Resultado de Laboratorio (adjuntar copia) Reporte de US (copia y adjuntar fotografías) Reporte de Biopsia Examen Físico y Tacto Rectal

Agregar cualquier otro aspecto que se considere pertinente

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ORL

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico dirigido, incluyendo según sea el caso valoración de oídos, nariz, cavidad oral, orofaringe y cuello.

3. Si es posible dependiendo de la patología; Rx de Cavum Faríngeo, audiometría reciente, y Rx de Watters.

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente; si es para tratamiento médico o quirúrgico. Indicando los nombres de los tratamientos ya suministrados.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Absceso peri-amigdalino	Todos	Referir servicio urgencias	No requiere	Diferenciar de amigdalitis aguda o amigdalitis flegmonosa. El absceso peri amigdalino produce abombamiento del paladar y desplaza la úvula y tiene trismus
Amigdalitis crónica	• Referir todos los casos que tienen más de 6 cuadros por año. • Todos los casos que presentan obstrucción nasal.	Cupo	No requiere	Diferenciar de IVRS de francas amigdalitis agudas
Cefaleas	Se refieren al servicio de Neurología o Medicina Interna		No requiere	A menos de sospecha por cefaleas secundarias a sinusitis crónica. (Obstrucción nasal y rinorrea.)
Cerumen impactado	Fracaso de lavado en cirugía menor	Cupo	No requiere	No lavar oídos con perforación de membrana timpánica
Cuerpo extraño en nariz	Ante fracaso al intento	Servicio de urgencias	No requiere	
Cuerpo extraño en oído	Ante fracaso al intento	Servicio de urgencias	No requiere	No introducir instrumentos a ciegas. No hacer lavados en caso de vegetales, espuma o papel,

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
				porque se expanden y dificultan extracción.
Desviaciones septales	Referir todos los casos que se asocian obstrucción nasal o deformidad rinoseptal	Cupo	No requiere	
Epistaxis	• Casos agudos: activo recurrente persistente mayor a 1 semana • Caso crónico: inactivo, recurrente	Agudo: servicio de urgencias Crónico a cupo	Hemograma Pruebas de coagulación	Controlar presión arterial, valorar ingesta de aspirina y otros anticoagulantes.
Hemotímpano traumático	Se refieren al Servicio de Emergencias	Urgencias	No requiere	Sospechar fractura base de cráneo, hematoma epidural.
Hipertrofia de adenoides	Se refieren todos los casos	Cupo	**Rx lateral cavum faríngeo**	
Hipoacusia	Deben referirse todos los casos. No realizarse lavado de oído si existe antecedente de supuración ótica o perforación timpánica.	Cupo	**Audiometría y timpanometría** **Recambio de audífono nueva audiometría.**	Si se encuentran tapones de cera, se recomienda prescribir 10 gotas de glicerina BID o TID en cada oído por 15 días y luego realizar lavado de oído por el médico tratante.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
				Pacientes referidos para cambio de audífonos deben traer una nueva **audiometría**
Hipoacusia Súbita	Se refieren al Servicio de Emergencias	Urgencias	No requiere	Se considera una urgencia médica por cuanto más precoz es la terapéutica, mayor es la posibilidad de recuperación. El tratamiento debe instalarse en las primeras 24 a 48 horas idealmente.
Laringitis y disfonía crónica	• Referir a todos los casos. • Más de 2 semanas sin respuesta al tratamiento	Cupo	No requiere	Indicar reposo vocal (incapacidad y referencia al INS en educadores) Pacientes con factores de riesgo para CA laríngeo • Sexo masculino • Mayor 50 años • Etilismo • Tabaquismo • Pérdida de peso • Masa en cuello

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
				referir a CONSULTA EXTERNA CON PRIORIDAD
Masa en cuello	Referir todos Más de 3 semanas, crecimiento progresivo, más de 2cm, fumadores, localizada por detrás del ECM	Prioridad a consulta externa	**US Cuello dirigido según sospecha (deseable)**	Inmunología (CMV, EBV, Toxoplasma) en caso de adenomegalias
Molestia faríngea crónica	Fracaso al tratamiento dirigido	Fumadores con prioridad No fumadores a cupo		Descartar RGE, uso de enalapril, obstrucción nasal.
Otalgia	Si se ha descartado patología oral y cervical; además, de Neuralgia del Trigémino	Aguda al servicio de urgencias (otoscopia anormal) Crónica cupo	Valoración por odontología en caso de sospechar disfunción temporomandibular	Las únicas causas de otalgia de origen ótico con una otoscopia normal son: • Disfunción tubaria • Baro trauma. Si hay problemas de mal oclusión dentaria referir a consulta de Maxilofacial
Otitis Externa Severa	Se refieren todos los casos severos. Fracaso con el tratamiento inicial.	Aguda (Maligna): al servicio de urgencias Crónica: a cupo	No requiere	Debe recordarse la Otitis Externa Maligna (otitis externa causada por pseudomonas en pacientes diabéticos y causa destrucción importante en los tejidos). Recomendar proteger el oído del agua

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Otitis media aguda	• Fracaso de segundo antibiótico dado por 7 días. • Sospecha de complicaciones como mastoiditis agudas o complicaciones intracraneales	Complicaciones referir al servicio de urgencias.	No requiere	Siempre dar descongestivos.
Otitis Media Crónica (supurativa o no)	Deben referirse todos los casos de otitis a repetición	Cupo	Frotis con PSA si tiene supuración **Audiometría**	No hacer lavado de oídos en caso de supuración crónica. Indicar cubrir oído afectado con algodón y vaselina en pasta al bañarse.
Otitis media crónica complicada	Todos	Se refieren al Servicio de Emergencias	No requiere	Dolor agudo intenso. Vértigo Parálisis facial Inmunocompromiso
Parálisis facial periférica	Se refieren al Servicio de Fisiatría	Con prioridad	No requiere	Tratar con ciclo corto de prednisona por 10 días, lágrimas artificiales diurnas y terramicina oftálmica HS.
Perforación timpánica	• Aguda: Se refieren al Servicio de Emergencias • Crónica: Consulta externa de ORL	Crónica a cupo	**Audiometría**	Indicar protección contra el agua
Pericondritis	Todos	Referir al servicio de urgencias	No requiere	Peligro de necrosis de cartílago con secuela: deformidad del pabellón.
Rinitis crónica	Referir los casos crónicos que no responden a los antialérgicos disponibles en medicina general	Cupo	No requiere	Se contraindica uso crónico de descongestionantes tópico (no utilizar oximetazolina /Iliadin)

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Síndrome de obstrucción nasal crónico	Referir todos los casos crónicos. Falta de respuesta al tratamiento incluido control ambiental	Cupo	**Rx cavum faríngeo en niños.** **Rx Senos paranasales en adultos.**	
Sinusitis aguda complicada	Se refieren al Servicio de Emergencias	Servicio urgencias	No requiere	Complicaciones orbitarias e intracraneales
Sinusitis crónica	Referir todos los casos crónicos a cupo.	Cupo	No requiere	
Tinnitus	Todos	Cupo	**Audiometría**	
Trauma nasal / facial	Se refieren al Servicio de Emergencias	Urgencias	No requiere	En caso de fractura nasal con menos de 8 días se debe referir urgente a la consulta externa de ORL. Si son traumas antiguos con más de 8 días debe referirse a cupo a la consulta externa de ORL.
Tumor glándulas salivales	Todos	Con prioridad a la consulta externa.	**US Cuello**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Vértigo central	Referir a especialista indicado: Neurología, Medicina Interna, Cardiología		Dirigido según caso: Hemograma, Glicemia, PFR. PFH, PFT EKG	Sospechar en: Ausencia de hallazgos Sugestivos de vértigo periférico Precedido de palpitaciones Síncope o Lipotimia Visión borrosa Fosfenos Cefalea vascular Disartria Lento y progresivo por meses
Vértigo periférico	Refractarios a tratamiento	Agudos al servicio de urgencias Crónica a cupo	**Audiometría**	Nada es patognomónico, sospechar con: vértigo rotatorio intenso, náuseas y vómitos, con latencia, agotable, se provoca al mover la cabeza, acufenos, hipoacusia, nistagmo horizontal. Hacer diagnóstico diferencial con mareos. Anotar al examen físico si hay nistagmos y examen neurológico completo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Indicaciones generales

5. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

6. Toda referencia debe incluir;
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral, escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas, alergia a medicamentos.
   - Antecedentes Heredo familiares
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo enfatizar exploración articular con descripción adecuada.

7. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). Traer las RX al momento de la cita. **NO ES NECESARIO EL REPORTE ESCRITO.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

8. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y porqué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Lumbalgias	Referir a Fisiatría en caso de dolores lumbares mecánicos por esfuerzo o de origen musculares y que no presenten síntomas de compresión radicular. Referir a ortopedia en caso de sintomatología de compresión radicular. Se debe de haber descartado patología urológica y/o ginecológica.	Dolor agudo neuropático referir servicio urgencias.	Rx AP y lateral de columna con apoyo de la carga.	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.
Hallux valgus	Referir si la patología es sintomática; por ende, interviene con labores de la actividad de la vida diaria.	A cupo	Rx AP, lateral y oblicua de ambos pies, con apoyo de la carga	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Talalgia	Referir posterior a: ➢ Pérdida de peso ➢ Haber utilizado calzado con tacón de 3 a 5 cm ➢ Haber realizado ejercicios de estiramiento de la planta del pie Referir en caso de que tratamiento conservador fracase (medidas anteriores.)	A cupo	Rx AP y lateral de pie, con apoyo de la carga	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.
Síndrome Hombro doloroso.	• Referir en casos de dolor crónico más de 3 meses y limitación funcional. • luxaciones recidivantes	A cupo	RX AP comparativa de HOMBROS y RX lateral del HOMBRO afectado. RX columna cervical AP y lateral	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías. **Los US de hombro serán de prioridad para el servicio de ortopedia por parte de radiología.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Gonalgia	Haber cumplido periodo de reposo del miembro, el paciente debe ser referido cuando: ▪ El dolor se vuelva incapacitante para Actividades de la vida diaria. ▪ No responda a tratamiento antiinflamatoria. ▪ Derrames articulares a repetición.	A cupo	RX AP con apoyo y Rx lateral	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.
Quiste Sinovial	Referir cuando exista limitación de rangos articulares de la art afectada Referir cuando exista dolor que no responde con aines	A cupo		
Dedo en Gatillo	Referir si la patología interviene con labores de la actividad de la vida diaria.	A cupo		
Síndrome de Túnel Carpal	Valorar primero por Fisiatría para realizar la electromiografía y que confirme la necesidad de manejo quirúrgico.	A cupo	Electromiografía por fisiatría.	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
	Paciente es referido al Servicio de Ortopedia solo en caso de necesitar cirugía, por el Servicio de Fisiatría.			
Coxalgias	• Niños y adolescentes con dolor de cadera con o sin trauma. • Adultos por artrosis de cadera	Niños con prioridad Adultos a cupo.	AP pelvis y posición rana (loweinstein) Niños Ap pelvis en adultos.	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.
Epicondilitis	Referir pacientes que no presenten mejoras ya valorados por fisiatría	Cupo	Rx codo AP y lateral	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.
Pie plano y torsión tibial interna	Referir paciente cuando exista persistencia de pie plano en mayores 4 años.	Cupo	RX AP lateral de pies con apoyo RX AP y lateral de tobillos con apoyo RX AP y lateral de rodillas con apoyo.	No se requiere el reporte de la Rx, debe traer físicamente las radiografías.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE PEDIATRIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
    - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

- Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
- Antecedentes Heredofamiliares
- Antecedentes Quirúrgicos
- Examen físico completo
- Estado nutricional

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso).

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE PEDIATRIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Convulsión febril **1 Simple** **2 Complejas** **3 Recurrentes** **Convulsión sin fiebre**	No amerita. Referir al diagnóstico. Referir todo paciente Referir todo paciente	Cupo	**Hemograma** **EGO** **HECES** **PFH**	Iniciar tratamiento con: ▪ Valproato de sodio a 15 mg/kg/d divido en 2 dosis ▪ Fenobarbital a 5 mg/kg/día al acostarse (revisar posibilidad de envío en primer nivel)
Anemias	• Valores de Hemoglobina por debajo de las -2DS o el 3 percentil según los grupos por sexo y edad criterio contrario a norma que indica referir hb menor de 11 los especialistas no están de acuerdo. Se debe cumplir lo anotado en ficha tecnica • Ha recibido más de 3 meses de tratamiento a dosis adecuadas de 5-6 mg/kg y no hay respuesta	Cupo	**Hemograma** **Morfología de GR** **Reticulocitos** **HECES** **PFR**	Revisa dieta del paciente, principalmente si hay alta ingesta de leche de vaca y dar educación sobre alimentación adecuada. Evaluar las cifras de hemoglobina de acuerdo con la edad del paciente Evaluar apega al tratamiento.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Drepanocitosis	• Homocigota referir todo paciente • Heterocigoto No amerita. (referir a pediatría HTFC)	Cupo	**Hemograma** **Morfología GR**	Dar consejería genética a los padres.
Desnutrición	• La que se documente organicidad • Falla para progresar referir todas	Cupo	**Hemograma** **EGO** **HECES** **Urocultivo** **Adjuntar curvas de crecimiento**	
Dermatitis atópica	Referir casos que no mejoran con las recomendaciones y al tratamiento tópico. Referir a cupo.	Recomendaciones generales al paciente • Uso de jabón neutro • Baño corto con agua tibia • Uso de emolientes (crema de rosas, aceite mineral) • Evitar factores desencadenantes • Picaduras de insectos, exposición al sol, perfumes • Productos detergentes, alfombras, peluches, polvo, polen • Ingesta de alimentos como cítricos y tomate • Contacto con animales domésticos • Antihistamínicos: Clorfeniramina 0.1 MG/Kg/día, se puede usar en una dosis HS o Hidroxicina .si ha sido aprobado por pediatría • Esteroides tópicos en exacerbación del eccema • Hidrocortisona crema 1% BID 5-10 días, cara y genitales • Betametasona crema BID por 8-10 días, resto del cuerpo		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
		• No usar esteroides sistémicos.		
Obesidad	Que asocie trastorno metabólico. Manejar concomitante con nutrición.	Cupo	**Hemograma** **Glicemia** **Perfil lipídico** **PF Renal** **PF Tiroidea**	
Sepsis Urinarias	Hombre: • Referir todo paciente a cualquiera edad. Diagnosticado por Urocultivo Mujer • ≤ 3 años: referir todo paciente, diagnosticados solo por Urocultivo • >3 años: niñas con ITU recurrentes, documentadas por Urocultivo	Cupo	**Urocultivo** **Hemograma** **PFR** **EGO**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Asma Bronquial	• No respuesta al tratamiento • Aumento de frecuencia de crisis o severidad • Crisis de Asma referir a Urgencias	Cupo Servicio de urgencias exacerbaciones		Prioridad Anotar en historia tratamiento con dosis y frecuencia
Adenopatías	• 1 Agudas Referir a Urgencias • 2 Previo fallo de tratamiento ATB • 3 Crónicas Que se documente: ♦ Toxoplasmosis aguda IgM (+) ♦ Serologías negativas asociando viceromegalias ♦ Adenopatías > 1cm de diámetro.	1 urgencias 2 y 3 Cupo	**Hemograma** **Serología por:** • **Toxoplasmosis** • **EBV** • **CMV**	IgG (+) No amerita ser referido porque es un proceso inflamatorio
Dolor Abdominal Crónico recurrente	Dolor por más de 3 meses y localizado a nivel peri umbilical sin causa etiológica evidente (dolor debe interferir con actividades diarias del niño) mínimo 3 episodios en 3 meses.	Cupo	**Hemograma** **PFH** **Orina- Urocultivo** **Heces**	Debe descartarse y tratarse previamente estreñimiento

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
	Haber descartado estreñimiento		**Guayaco** **VES**	
Reflujo Gastroesofágico	Paciente que asocien: - Neumopatía - Poca ganancia de peso - Síntomas y signos de esofagitis (irritabilidad)	Cupo		Dar educación sobre medidas anti reflujo Prioridad
Trastorno del Lenguaje	Asociados al desarrollo psicomotor y/o neurodesarrollo	Cupo		
Hiperactividad y Déficit atencional	A partir de los 6 años referir a psiquiatría Menores de 6 años referir a pediatría	Cupo		Seguir criterios de guías de psiquiatría para envió a su especialidad

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Enuresis y Encopresis	Paciente con incontinencia de esfínteres a partir de los 5 años.	Cupo	**Hemograma** **EGO – Urocultivo** **Glicemia (ayunas)** **Heces**	
Ictericia neonatal	Definición: Todo niño con presencia de ictericia antes de los 28 días referir a urgencias. • Todo paciente con criterio de fototerapia enviar al hospital • Todo paciente con criterio de exsanguino transfusión. Si el paciente tiene una BT muy altas y cae en esta categoría, debe referirse de urgencia. • Pacientes con elevación de más de 2 MG/Dl. de Bilirrubina directa debe ser referido de emergencias al hospital.	Urgencias.		
Estreñimiento crónico	Estreñimiento por más de 3 meses y que no haya mejorado con dieta rica en fibra y laxantes convencionales (aceite mineral, leche magnesia).	A cupo	**Frotis de heces** **Guayaco** **Hemograma**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Enfermedad diarreica, recurrente o crónica.	Diarrea más de 3 episodios en 6 meses con duración > a 15 días.	A cupo	**Frotis de heces #3, Hemograma, coprocultivo.** **Guayaco**	
Vómitos Recurrentes	En lactantes que cursen con inadecuada ganancia de peso.	Prioridad		
Hipertrofia Adenoamigdalina	Referir al Servicio de ORL (HTFC referir a pediatría)	Cupo		Al menos 6 IVRS al año
Otitis Media Recurrente	Más de 1 episodio en 3 meses mínimo	Cupo	**Hemograma**	
Ictericia	Ictericias en pacientes en edad pediátrica se deben referir al Servicio de Emergencias	Urgencias	**Bilirrubinas totales y fraccionadas** **Hemograma** **Grupo ABO RH**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Sepsis Neonatal	• Temprana = menos de 5 días de nacido • Tardía=mayor de 5 días de nacido Rechazo de alimentos, hipoactivo, vómito repentino, diarrea repentina, irritabilidad, insuficiencia respiratoria de causa no precisada, distensión abdominal repentina con timpanismo, fiebre o hipotermia, leucograma alterado, plaquetas < 100.000	Referir al servicio Urgencias	Laboratorios realizados	
Bronconeumonía	• Neumonía en menores de 4 meses • neumonía complicada: derrame pleural, fugas de aire, atelectasias o paciente con comorbilidades importantes.	Urgencias	**Enviar RX tórax si se tiene**	
Bronquiolitis	• Hallazgos de síndrome de dificultad respiratoria moderada a severa • hallazgos de síndrome de insuficiencia respiratoria • Signos de bronconeumonía asociados	Urgencias		
Diarrea aguda	• Alta tasa o DTH moderada - severa con intolerancia a la VO. • Diarrea de más de 15 días. • Diarrea disentérica abundante.	Urgencias		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Sibilancias Recurrentes	Mayor a 3 episodios de sibilancias en menores 2 años.	A cupo		
Infecciones Vías Respiratorias Recurrentes	• Más de 1 episodio al mes en menores de 2 años • Más de 6 episodios al mes en mayores de 2 años.	Cupo	**Hemograma**	
Rinitis Persistentes	No respuesta al tratamiento según nivel de atención.	Cupo		
Soplos	Referir todos los casos	Urgencias menores de 1 mes con síntomas Y a cupo mayores de 1 mes asintomáticos	**EKG** **RX TORAX**	
Sincope o Lipotimia	Mayor a un episodio.	Consulta externa con prioridad	**Hemograma** **Glicemia** **EKG si es posible pronto**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Arritmias	Referir todos los casos al Servicio de Pediatría para posterior valoración en conjunto con cardiología	Servicio de urgencias, o con prioridad/ urgente a la consulta externa	**EKG**	
Dolor Torácico	Todo episodio recurrente en un periodo de 3 meses	Cupo	**Hemograma,** **Glicemia** **EKG** **RX Tórax**	
Prematuros **Neonatología**	Prematuros y PEG con ganancia insuficiente de peso según tablas CLAP	Prioridad a Consulta externa		
Leucopenia	Más de 3 hemogramas en 2 meses	Cupo	**Hemograma** **Serologías** **Toxoplasma** **CMV** **EBV**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grado de prioridad	Exámenes previos	Observaciones
Infección recurrente	Más de 6 infecciones al año en diferentes sistemas	Cupo	**Hemograma** **Serologías por** **Toxoplasma** **CMV** **EBV** **RX tórax**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - **SERVICIO DE PSIQUIATRIA**

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y de qué forma agudo o crónico que pueda explicar la sintomatología, de ser así referir al IAFA primero, si fuera de forma crónica, evidenciar patología psiquiátrica asociada. (patología Dual), alergias a medicamentos.
   - Antecedentes Heredofamiliares con énfasis en patología psiquiátrica
   - Antecedentes Quirúrgicos
   - Examen físico completo.
   - Enfoque en historial psiquiátricos. Descripción de los síntomas; averiguar desde cuando los siente, como han evolucionado. cómo influyen en su desempeño cotidiano Tiempo de evolución, Desencadenante de los síntomas, Examen físico completo. Tratamiento utilizado de primera línea por medicina general, tiempo de uso, razones del fracaso terapéutico, Si tiene o no redes de apoyo.
   - Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

3. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

4. Trastorno mental relacionado con el trabajo referir al INS

5. **Antes de referir:**
   - **Se investiga previamente que la causa de su sintomatología psiquiátrica no se explique por una causa orgánica.**
   - **Problemas de pareja, familiares, escolares, laborales referir a EISAM o Psicología primero**
   - **En caso de que presente sintomatología afectiva y no cumple criterios de depresión o manía, referir a EISAM. Previa investigación de la problemática.**
   - **Se cita a familiares para explorar dinámica familiar y redes de apoyo, en caso de que se encontrara alguna dificultad en cuanto a su dinámica familiar, se enviara a trabajo social.**
   - **Si es un trastorno psicótico primera vez debe descartar causa orgánica con TAC y laboratorios y si es necesario apoyarse en otras especialidades.**

6. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE PSIQUIATRIA Criterios de Referencia

Patología	Criterio de referencia	Grados de prioridad	Observaciones
Depresión moderada y grave	• Referir pacientes con sintomatología que persiste o no hay una respuesta adecuada por más 12 semanas, pese a medidas terapéuticas adecuadas, farmacológicas como no farmacológicas (TCC o TIP) • Depresión con características psicóticas (ideas delirantes, alucinaciones, estupor) • Condiciones concomitantes (riesgo de suicidio/Autolesión, patología dual) • Fracaso a la tolerancia de antidepresivos y persistencia de los síntomas depresivos.	Cupo	Tener en cuenta el periodo de definición de depresión. Tener en cuenta el periodo de acción de los ISRS, ATC

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grados de prioridad	Observaciones
Psicosis	Referir pacientes que se ha descartado causa secundaria (DROGAS, OH) u organicidad demostrable por otras patologías. (Delirio)	Urgencias eventos agudos Crónicos a la consulta externa	Descartar síntomas psicóticos por causas secundarias ya mencionadas. Hacer diagnostico diferencia con trastorno bipolar. Estudiar condiciones concomitantes.
Trastorno bipolar	• Referir todo paciente en estado maniaco • Referir todo paciente en estado depresivo • Adolescentes • Embarazo o lactancia • Edad avanzada. • Fracaso terapéutico y persistencia de síntomas por más de 6 semanas	Fase maniaca urgencias. Las demás con prioridad a consulta externa.	Hacer diagnóstico diferencial con condiciones concomitantes: • Consumo Drogas, OH • Demencia • Suicidio autoeliminación • Enfermedad medica concurrente; en especial enfermedad tiroidea cardiovascular o renal.
Trastornos conductuales	• Trastorno déficit atencional con hiperactividad (mayores de 6 años) • Trastorno de déficit atencional • Otros trastornos conductuales; oposicionista desafiante, espectro	Cupo	Inicio de síntomas antes de los 6 años(TDAH)

Patología	Criterio de referencia	Grados de prioridad	Observaciones
	autista, alimentación, humor inespecífico.		Persistencia de síntomas por más de 6 meses DESCARTAR ORGANICIDAD Adjuntar notas del centro educativo
Demencia	Referir pacientes en los que ha DESCARTADO organicidad y estados agudos de delirio. • Síntomas persistentes por más de 6 meses. • Síntomas progresivos deterioro cognitivo y memoria que intervienen en el funcionamiento social	Cupo	Descartar organicidad No referir casos de delirium Estudiar paciente con apoyo de especialidades pertinentes
Trastornos por el uso del Alcohol o Drogas	Referir al IAFA para valoración Referir concomitantemente al grupo EISAM Referir casos de sospecha de patología dual.	Intoxicaciones agudas por OH/drogas con o sin lesiones traumáticas, síndromes de abstinencia deben ser referidas a urgencias para observación y valoración.	Valorar protocolos referencia a EISAM

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grados de prioridad	Observaciones
Autolesiones/suicidio	Referir pacientes con ideaciones suicidas o con datos o historia de autolesiones.	Urgencias si es un evento agudo de intento de autoeliminación.	Seguir recomendaciones MhGAP sobre prevención del suicidio
Otros síntomas emocionales significativos o padecimientos no justificables médicamente	Estas patologías deben de manejarse en el primer nivel o en su defecto con el grupo EISAM si corresponde a los criterios de referencia. El grupo EISAM trabaja conjuntamente con psiquiatría de ser necesaria valoración. O referir ante el fracaso terapéutico o empeoramiento de síntomas. • Trastornos somatomorfos • Depresiones leves • Distimias • Trastornos de pánico • Trastornos de ansiedad generalizado • Trastorno de estrés post trauma • Reacción a estrés agudo	Cupo Cupo EISAM	Valorar protocolos de referencia EISAM. Valorar recomendaciones por MhGAP.
Enuresis	Edad cronológica y/o mental, mayor de 5 años	Cupo	No medicar al paciente Según el CIE-10 los niños menores de 5 años no se catalogan como

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de referencia	Grados de prioridad	Observaciones
	Examen físico con énfasis en área genital dentro de lo normal. Examen general de orina, dentro de lo normal CUMS solo lo envían los especialistas		enuréticos y por ende no debe considerarse patología psiquiátrica.
Encopresis	Edad cronológica y/o mental, mayor de 5 años. Examen físico con énfasis en área perianal, dentro de límites normales. Colon por enema sin preparación	Cupo	No medicar al paciente

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA

SERVICIO DE RADIOLOGIA e IMÁGENES MÉDICAS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Indicaciones generales

En términos generales todos los estudios deben de cumplir con los principios de protección radiológica de: justificación y menor cantidad posible de radiación requerida para hacer un estudio y lograr la máxima información.

1. Todas las boletas deben de cumplir los siguientes criterios:

- Una boleta por cada estudio solicitado. No se aceptarán solicitudes que son exageradas y sin sentido; ejemplo: Ultrasonido de abdomen general, vías urinarias, ginecológico, mamas y tiroides. En estos casos se hará únicamente el primer estudio que se anote.
- Letra clara y legible.
- Sexo y edad del paciente.
- Resumen de historia clínica.
- Resumen de exámenes de laboratorio que aporten información para el estudio, ejemplo en caso de litiasis renal si hay o no hematuria macro o microscópica, el tacto rectal en el caso de prostatismo, etc. (según sospecha clínica)
- Indicar si ha habido tratamiento previo y la respuesta obtenida.
- Proponer un diagnóstico clínico acorde con lo solicitado. Ejemplo: colelitiasis, y no, dolor abdominal.
- Solicitar el estudio ideal para el diagnóstico si se desea descartar nefrolitiasis, para ello se solicita US de vías urinarias y no un US general de abdomen.

Es sumamente importante que puntualicen datos claves como pérdida de peso, palpación de masas, no respuesta a tratamiento. Recordemos que se va a priorizar la atención para ser más eficaces y eficientes, no es lo mismo atender a un paciente que se refiere por dolor abdominal sin ninguna información a uno que se le anota pérdida de peso, anemia, astenia, guayaco positivo o presencia de masa al examen físico.

2. Consideraciones especiales

La patología AGUDA EMERGENTE Y URGENTE DEBE DE SER TRAMITADA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS, ejemplo: torsiones testiculares, sospechas de embarazos ectópicos, apendicitis, colecistitis, entre otras.

Las patologías de probable origen crónica pero de reciente diagnóstico, como las claras sospechas de neoplasias, deben de ser bien referidas y con un adecuado resumen en la solicitud, o bien comunicarse directamente al servicio de rayos equis para dar atención prioritaria.

Las boletas que aporten poca o mínima información, así como aquellas que el diagnóstico propuesto no sea acorde con el estudio solicitado, no serán de orden prioritario; serán vistas con cita a cupo según la agenda. Que conste que al usuario NO se le rechazará el estudio, solo que se le dará cita a cupo.

3. Consideraciones finales

- ✓ Velen porque las boletas de solicitud tengan el sello del EBAIS o del área de adscripción bien colocado y visible con el fin de poder contactar al médico que refiere en caso necesario y para el envío de los resultados. Así como número para contactar paciente en caso necesario.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

- ✓ En adelante se aceptará una boleta por cada estudio solicitado. Los estudios que no cumplan con esta norma se hará el estudio que primero se anote. Sin excepción.

- ✓ Dirijan el área de interés por estudiar o explorar, NO se justifica hacer un abdomen general en un paciente que solo se quiere estudiar un prostatismo o nefrolitiasis, para ello se hará un ultrasonido de vías urinarias.

- ✓ Sugiramos diagnósticos probables, se debe de evitar usar síntomas como diagnósticos. Ejemplo dolor: dolor abdominal, cefalea, homalgia, artralgia, etc.

- ✓ Evitemos ser médicos complacientes.

- ✓ Las solicitudes con letras ilegibles o poco claras – después de hacer un esfuerzo por entender – si no queda claro lo que se escribe y desea el médico tratante serán rechazadas sin excepción. Deben de recordarles a los compañeros de REMES que deben de escribir claro y legible, hay solicitudes que son una verdadera competición en fea caligrafía entre el médico y el personal de REMES.

- ✓ Las boletas que no JUSTIFIQUEN el estudio se rechazaran al igual que aquellas donde no haya congruencia diagnóstica con el estudio sugerido. En estos casos se le indicará al usuario que debe de consultar nuevamente con su médico tratante, para que este comente el estudio con el medico radiólogo y explique la necesidad del mismo.

- ✓ Para comentar casos de forma directa por favor sírvanse llamar al Hospital de Guápiles central telefónica: 2710-6801, extensiones: 2058, 2060 (recepción de rayos equis) ó 2161 (ultrasonido). O Hospital Tony Facio Castro.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
US abdomen superior y completo	• Sospecha de apendicitis • Sospecha de colecistitis • Sospecha de diverticulitis • Dolor abdominal agudo de causa no clara • Sospecha de invaginación intestinal • Sospecha de pancreatitis • Trauma abdominal cerrado • Trauma abdominal abierto • Sospecha de aneurisma de la aorta abdominal	• Sospecha clínica de neoplasia • Pérdida de peso de causa no clara • Sospecha de enfermedades metabólicas graves: ejemplo enfermedad de Wilson. • Sospecha de hepatopatía crónica evolucionada • Masas palpables • Paciente completando	• Dolor abdominal crónico de causa no clara más nula o muy baja sospecha de neoplasia • Observación por colelitiasis • Control por esteatosis • Organomegalias sin asociación de sospecha de neoplasia • Control de quistes simples • Control en salud • Control de Hepatopatía crónica conocida	**Ser claro y preciso en que es la duda diagnostica.**

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia • Paciente difícil de explorar (PCI, RM, adulto mayor demente, etc.)	• Controles postquirúrgicos • Estudios con poca información clínica o no acordes con el diagnósticos propuesto	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
US pelvis y vía urinaria	• Sospecha de embarazo ectópico • Sospecha de torsión ovárica • Sospecha de EPI • Dolor pélvico agudo de causa no clara • Sospecha de cólico renal agudo • Hematuria macroscópica • RAO (retención aguda de orina) • Sospecha de Pielonefritis • Prostatitis aguda	• Sospecha clínica de neoplasia • Masas palpables • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia • Metrorragias que no responden a tratamiento • Observación por nefrolitiasis, micro	• Dolor pélvico crónico de causa no clara más nula o muy baja sospecha de neoplasia • Control de quistes simples o angiomiolipomas • Control en salud • Organomegalias sin asociación de sospecha de neoplasia • Controles postquirúrgicos • Observación por ovarios poli quísticos • Pacientes HTA o DM sin deterioro de función renal • Estudios con poca información clínica o no	**Ser claro y preciso en que es la duda diagnostica.** **Trastornos vesicales tipo cistocele no se valoran por US en primera instancia.**

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		hematurias, ITUs a repetición • HTA o DM con deterioro de función renal, IRA de causa no clara • Quistes BOSNIAK 2f o más	acordes con el diagnósticos propuesto • Dismenorreas, prostatismo, incontinencia urinaria	
	• Sospecha de mastitis • Trauma mamario	• Sospecha clínica de neoplasia	• Mastalgia crónica • Control de quistes simples	Mastodineas cíclicas dar tratamiento médico y evolucionar.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
US Mamas		• Masas palpables • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia • BIRADS 0 con nódulos o asimetrías • BIRADS 3 o más • Secreción por pezón sospechosa	• Control en salud • Controles postquirúrgicos no neoplásicos • Asimetría tamaño de mamas • Secreción por pezón no sospechosa de malignidad • Pezón retraído crónico o congénito • Estudios con poca información clínica o no acordes con el diagnósticos propuesto • T.R.Hormonal de bajo riesgo	Las Mastodineas no cíclica solicitar US a cupo. **El usuario debe venir personalmente a sacar su cita.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		• Pezón retraído agudo		
US Cuello y tiroides	• Sospecha de Tiroiditis • Traumas cervicales cerrados y punzantes • Masas dolorosas en pacientes febriles.	• Estudios referidos por ORL, Oncología, Cirugía y Medicina Interna. • Masas palpables • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia	• Referidos del primer nivel que no sean sospechas de neoplasias • Control de quistes simples, sospechas de bocio, pruebas de función tiroidea alteradas • Control en salud • Controles postquirúrgicos no neoplásicos	**Odinofagia y disfagia solicitar primero esofagograma.**
US tejidos Blandos focalizado	• Sospecha de abscesos, hernias inguinales encanceradas, estranguladas o no reducibles.	• Sospecha clínica de neoplasia • Masas palpables sólidas	• Masas blandas, hernias inguinales no complicadas • Control de quistes simples	Hernia clínicamente evidentes **no requieren US.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		• Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia	• Control en salud • Controles postquirúrgicos no neoplásicos • Asimetría tamaño de partes anatómicas sin diagnóstico claro	
US hombro y Rodilla	• Sospecha de abscesos, artritis séptica, trauma agudo, desgarros colecciones etc.	• Referidos por ortopedia • Estudios indicados o sugeridos por radiología • Sospecha de manguito rotador roto, masas	• Referidos de primer nivel deben de ser valorados primeramente por ortopedia. Que no sean catalogados como prioridad	US osteomuscular se restringe exclusivamente al servicio de ortopedia a excepción del sugerido o solicitado por radiología en estudios previos.
US trans-vaginal o trans-rectal	No aplica	• Referidos por ginecología • Referidos por urología	• Referidos del primer nivel	En términos generales es el medico radiólogo el que determina la forma del abordaje, ya sea trans-vaginal o trans-abdominal.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		• Referidos por cirugía o medicina interna		En cuanto al abordaje Trans-rectal en mujeres o varones es decisión del radiólogo este abordaje, una vejiga bien distendida permite valorar adecuadamente la próstata.
US biométrico y morfológico en embarazo	No aplica	• Referidas por el Servicio de Ginecología y Obstetricia	Las que no tienen embarazos de alto riesgo y desean un ultrasonido morfológico o biométrico que sean referidas del primer nivel serán vistas a cupo.	TODA mujer con embarazo de alto riesgo debe de ser valorada por ginecología primeramente
US de cerebro	No aplica	Referidas por el Servicio de Neonatología y Pediatría	NO se aceptaran referencias del primer nivel	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
Ultrasonido tipo Doppler de: Carótidas, venoso o arterial de miembros superiores o inferiores	• Heridas que comprometan la integridad vascular. • Trombosis venosas o arteriales agudas. Crónicas reagudizadas (retrombosadas).	Sólo se verán los pacientes referidos por especialista. Tendrán prioridad los referidos por vascular periférico	NO se aceptaran referencias del primer nivel, antes deben de ser vistos por médico especialista	
Esofagograma baritado o con medio hidrosoluble no baritado	• Ingesta de cáusticos • Cuerpos extraños • Trauma cervicales según corresponda	• Sospecha clínica de neoplasia • Masas palpables en cuello con disfagia • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia	• Disfagias lógicas • Bocios no compresivos • Control en salud • Controles postquirúrgicos no neoplásicos • Pirosis conocidas • Diagnósticos que no sean congruentes con estudio solicitado	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		• Bocio compresivo • Disfagia ilógica • Sospecha de RGE en niños • Según hallazgos de gastroscopía		
Serie gastro duodenal	• Ingesta de cáusticos • Sangrado digestivo alto	• Sospecha clínica de neoplasia • Sospecha de úlcera gástrica o duodenal • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control	• Gastritis conocidas • Dispepsias sin sospecha de enfermedad ulcerosa • Control en salud TODO paciente mayor o igual a 40 años • Controles postquirúrgicos no neoplásicos • Dolor abdominal crónico	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		• Paciente recibiendo quimioterapia	• Pirosis conocidas • Diagnósticos que no sean congruentes con estudio solicitado	
Colon por enema	• Sangrado digestivo bajo agudo y profuso • Enfermedad diverticular aguda	• Sospecha clínica de neoplasia, pérdida de peso no clara • Sospecha de Crohn o CUCI • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control • Paciente recibiendo quimioterapia	• Intestino irritable • Enfermedad diverticular conocida • Control en salud TODO paciente mayor o igual a 40 años • Controles postquirúrgicos no neoplásicos • Dolor abdominal crónico • Sangrado digestivo bajo ya diagnosticado (ej. Por enfermedad diverticular)	Toda solicitud debe incluir el reporte del Tacto rectal Pacientes con hipotonía del esfínter rectal no son candidatos para el estudio. (usualmente paciente Geriátrico) Considerar otro estudio de abordaje. Como colonoscopia.

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
			• Diagnósticos que no sean congruentes con estudio solicitado	
Cistografía y uretrografía	• Sospecha de ruptura vesical • Sospecha de ruptura uretral	• Sospecha clínica de neoplasia • Macro hematuria, micro hematuria en varones, ITUs a repetición, sospecha de reflujo vesicoureteral • Paciente completando estudios por neoplasia • Paciente con neoplasia conocida, estudio control	• Micro hematurias en mujeres o varones sin sospecha de neoplasia • Disurias agudas o crónicas • Control en salud TODO paciente mayor o igual a 40 años • Controles postquirúrgicos no neoplásicos • Dolor pélvico crónica no ginecológico • Control post enfermedades de transmisión sexual	

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		• Paciente recibiendo quimioterapia	• Diagnósticos que no sean congruentes con estudio solicitado	
Pielograma intravenoso	No aplica	Se hará PIV SOLAMENTE en pacientes que vengan con solicitud de parte de urología, SIN EXCEPCIÓN.	No aplica para primer nivel de atención. Excepto que tenga referencia de solicitud por parte de médico especialista.	Se hará PIV a aquellos pacientes que el radiólogo así lo considere necesario y lo sugiera en el reporte escrito.
Mamografía	• Masas sugestivas de abscesos mamarios que no han resuelto a tratamiento antibiótico en un plazo de 8 días	La mayoría de los casos en mamas son de prioridad, sin embargo, los que serán valorados de forma apremiante serán los casos referidos por la clínica de mama con alta sospecha de malignidad o aquellos que presenten alta sospecha clínica según lo establecido en la circular 38.524-5	Casos con bajo riesgo de cáncer de mama, mayores de 45 años.	Paciente con AHF positivos por CA mama iniciaran estudios de tamizaje 10 años antes de la edad diagnostica del familiar.

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
		previamente valorados por unidad pertinente (45 años		
Biopsia guiada por Ultrasonido o Tru Cut	No aplica	• Los casos prioritarios serán los catalogados como BIRADS 4c y 5, los cuales la sospechas de malignidad es alta – muy alta. • Los TRU CUT serán referidos por la clínica de mama.	Casos catalogados como BIRADS 4a y 4b.	Estos pacientes deberán traer el estudio que indique dicha clasificación para poder otorgarles la cita. La mayoría serán generados al realizar el estudio MMG y el US complementario.
BAAF	No aplica	• Biopsias por punción tiene cupo prioritario.		Adjuntar copia de estudio donde se solicita BAAF por médico especialista. Recordar que los resultados de las biopsias y BAAF demoran entre 1.5 y 3

Tipo de Estudio	Estudios de Servicio de emergencias	Estudio con prioridad	Estudio a cupo	Observaciones
				meses según capacidad resolutiva de los centros de patología.

Rayos X Convencionales de primer nivel de atención / RECOMENDACIONES

- **Rx cráneo:** este estudio se debe omitir en los casos de cefaleas y sinusitis, ya que los diagnósticos son más precisos con tomografías para el caso de las cefaleas y clínico en caso de la sinusitis.
- **Cavun Faríngeo**: este estudio se debe solicitar únicamente cuando el tratamiento médico ha fallado y debe de evitarse en menores de 6 años.
- **Rx senos paranasales:** las sinusitis es un diagnostico clínico y no radiológico.
- **Rx Atm:** siempre solicitar bilateral
- **Rx cervicales:** cervicalgia crónica con nivel sensitivo debe ser valorada con TAC o Resonancia
- **Rx Tórax:** Paciente EPOC se justifica Rx tórax si se sospecha de alguna condición sobreañadida.
- **Rx Tórax Óseo:** La osteocondritis no es diagnosticable con radiografía simple.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

- **Rx Columna Dorsal y CLS:** dorsalgias y lumbalgias con nivel sensitivo requieren ser estudiadas con TAC o Resonancia, las hernias discales no son visibles con radiografías simples.

- **Rx Pelvis:** coxalgias crónicas deben de venir especificados los arcos de movilidad.

- **Medición de miembros inferiores:** indicado ante acortamiento clínico y escoliosis evidente.

- **Pie plano:** evitar este estudio en menores de 6 años.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD TRABAJO SOCIAL

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

INDICACIONES GENERALES

Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a personas usuarias que se refieren para la atención de Trabajo Social indicados por la gerencia médica.

1. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del profesional que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad.
    - Antecedentes psicosociales, detallar abordaje brindado.

2. Justificación clara del motivo de referir a este usuario. Diagnóstico claro por el cual se refiere a la persona, o en su defecto una impresión diagnóstica, que explique textualmente la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

3. Descripción técnica de los factores de riesgo y de los factores protectores.

4. El motivo de referencia debe estar asociado a los factores de riesgo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patologías	Criterio de referencia	Prioridad	Requisitos	Observaciones
Supervisión del embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales (Z357).	**Factores de riesgo físico:** **Antecedentes de violencia ejercidos en su contra por parte de novio, pareja o familiar.** **Discapacidad física y/o cognitiva, enfermedad grave o crónica.** **Factores de riesgo sexual y reproductivo:** **Segundo o más embarazos durante la adolescencia.**	**Prioridad.**	**Boleta VE - 01 registrada en EDUS (en caso de abuso sexual, relación impropia, VIF, sospecha de explotación sexual comercial).** **Denuncia enviada al Ministerio Público (cuando corresponda).** **Referencia enviada al PANI.** **Referencia para Trabajo Social del II Nivel elaborada en EDUS.**	**Estos usuarios se atienden en el Servicio de Trabajo Social del hospital por referencia.**

	Se niega a utilizar un método anticonceptivo de larga duración. **Abuso sexual, relación impropia.** **Conducta sexual de riesgo.** **Indicadores que sugieren explotación sexual comercial.** **Baja adherencia a tratamientos por ITS.** **Factores de riesgo psicológico:** **Minimización y/o justificación del abuso.**			

	Factores de riesgo asociados al control y/o abuso prenatal: **Inasistencia al control prenatal.** **Consumo de sustancias psicoadictivas.** **Factores de riesgo asociados con el grupo familiar de origen:** **Violencia intrafamiliar.** **Niegan apoyo económico, asistencial y/o afectivo.** **Toda adolescente menor de 15 años embarazada que haya cumplido con el plan de abordaje social**			

	establecido por el I nivel de atención.			
Mujeres adultas con diagnósticos de: **Abuso físico (T741)** **Abuso sexual (T742)** **Abuso psicológico (T743)**	**Incorporación a grupo socioterapéutico (consulta social grupal).**	**Cupo.**	**Consulta social individual en el primer nivel de atención, en la que se registre consentimiento de la usuaria para incorporarse a la consulta social grupal.**	**Las referencias deben elaborarse en EDUS, para ser validadas por Trabajo Social del II nivel, posteriormente Redes genera y gestiona la cita al usuario para la consulta social individual en el hospital, donde se valoran los criterios de inclusión a la consulta social grupal.**

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA
TRABAJO SOCIAL
II NIVEL DE ATENCIÓN AL I NIVEL DE ATENCIÓN

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

INDICACIONES GENERALES

Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a usuarios que se refieren para la atención de Trabajo Social indicados por la gerencia médica.

1. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del profesional que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad.
    - Antecedentes psicosociales, detallar abordaje brindado.

2. Justificación clara del motivo de referir a este usuario. Diagnóstico claro por el cual se refiere a la persona, o en su defecto una impresión diagnóstica, que explique textualmente la necesidad de resolver el caso en un primer nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del segundo nivel.

3. Descripción técnica de los factores de riesgo y de los factores protectores.

4. El motivo de referencia debe estar asociado a los factores de riesgo.

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL

II NIVEL DE ATENCIÓN AL I NIVEL DE ATENCIÓN

Patologías	Criterio de referencia	Prioridad	Requisitos	Observaciones
En personas menores de edad: **Abuso por negligencia o abandono (T740).** **Abuso físico (T741).** **Abuso sexual (T742).** **Abuso psicológico (T743).**	**Factores de riesgo físico:** **Discapacidad física y/o cognitiva, enfermedad grave o crónica con débil red de apoyo familiar.** **Heridas de vacilación o conductas autolesivas.** **Síndrome de niño(a) sacudido (SNS).** **Dependencia parcial o total para realizar sus actividades básicas, instrumentales y/o avanzadas de la vida diaria.** **Factores de riesgo sexual:**	**A cupo.**	**Boleta VE - 01 registrada en EDUS.** **Denuncia enviada al Ministerio Público.** **Referencia enviada al PANI.** **Referencia para Trabajo Social del I Nivel elaborada en EDUS.**	**Las referencias deben elaborarse en EDUS, para ser validadas por Trabajo Social del I nivel, posteriormente Redes genera y gestiona la cita al usuario.**

	Indicadores que sugieren explotación sexual comercial. **Factores de riesgo psicológico:** **Abuso emocional en el ámbito familiar (intimidación, denigración, ridiculización, culpabilización, testigos de violencia).** **Minimización y/o justificación del abuso.** **Factores de riesgo asociados con los cuidadores:** **Violencia intrafamiliar.** **Conocimiento y expectativas erróneos sobre el desarrollo infantil.**			

	Familia con escasa o nulas redes de apoyo familiar y/o comunal.			
Personas adultas mayores con diagnóstico: **Abuso por negligencia o abandono (T740).** **Abuso físico (T741).** **Abuso sexual (T742).** **Abuso psicológico (T743).**	**Factores de riesgo físico:** **Discapacidad física, cognitiva, enfermedad grave o crónica con débil red de apoyo familiar.** **Dependencia parcial o total para realizar sus actividades básicas, instrumentales y/o avanzadas de la vida diaria** **Factores de riesgo psicológico:** **Abuso emocional en el ámbito familiar: intimidación, denigración, ridiculización, culpabilización.** **Minimización y/o justificación del abuso.**		**Boleta VE - 01 registrada en EDUS.** **Denuncia enviada al Ministerio Público.** **Referencia para Trabajo Social del I Nivel elaborada en EDUS.** **Consentimiento firmado (no aceptando reubicación institucionalizada permanente).**	**Las referencias deben elaborarse en EDUS, para ser validadas por Trabajo Social del I nivel y posteriormente trasladarlas a Redes para que genere y gestione la cita al usuario.**

	Factores de riesgo asociados con el grupo familiar: **Con escasas o nulas redes de apoyo familiar.** **Adulto mayor sin redes de apoyo familiar y/o comunal que cuenta con recomendación técnica de reubicación institucionalizada permanente pero que no emite su consentimiento.** **Familia con síndrome burnout.**			
Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares (Z63). **Problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a discapacidad (Z736).**	**Personas dependientes parcial o total para realizar sus actividades básicas, instrumentales y/o avanzadas de la vida diaria.** **Requirentes de cuidado en la casa y de supervisión continua, con los siguientes factores de riesgo:** **Antecedentes de violencia intrafamiliar ejercido en su contra.**	**Cupo.**	**Referencia para Trabajo Social del I Nivel elaborada en EDUS.**	**Las referencias deben elaborarse en EDUS, para ser validadas por Trabajo Social del I nivel, posteriormente Redes genera y gestiona la cita al usuario.**

Problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios (Z74).	**Escasas o nulas redes de apoyo familiar y/o comunal.**			
Problemas relacionados con la conducta sexual de alto riesgo (Z725).	**Factores de riesgo en adolescentes femeninas y mujeres:** **Multiparidad (y se documenta en expediente: paridad satisfecha).** **Dos o más embarazados durante la adolescencia.** **Se niega a utilizar métodos anticonceptivos de larga duración.** **Se niega a utilizar métodos de barrera.** **Adolescentes varones:** **Se niega a utilizar métodos de barrera.**			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE UROLOGIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE UROLOGIA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.
2. Toda referencia debe incluir:
    - Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
    - Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
    - Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
    - Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
    - Antecedentes Heredofamiliares
    - Antecedentes Quirúrgicos
    - Examen físico completo enfatizando en exploración urológica

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US). Tacto rectal indispensable y descripción para referencia.

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Cáncer de Próstata	Referir aquellos que: ▪ Presenten un tacto rectal anormal y antígeno APE MAYOR DE 3 y que se verifique que cumplió con requisitos para hacer este examen ▪ Todos los pacientes con tacto rectal normal y APE mayor 3 Que se ha descartado factores médicos que alteren el APE.	Referencia	**TR** **APE y razón de PSA libre** **PFR** **EGO**	Todo paciente debe tamizarse con tacto rectal y antígeno prostático Mayor riesgo: Raza negra Mayores de 50 años AHF + 1er línea
Circuncisión	Pacientes con riesgo aumentado de cáncer de pene: ▪ Fimosis, Parafimosis ▪ Mala higiene con formación de esmegma ▪ Papilomatosis peneana ▪ Balanitis a repetición	Cupo	No requiere	Observar pacientes DM y factores de riesgo
Litiasis Renal Y Cólico renouretral	Paciente ya con el diagnostico de LITIASIS URINARIA que: Valorado en emergencias y persiste con dolor No ha expulsado la piedra en 2 semanas,	Referencia con prioridad a la consulta externa CRU agudo Servicio Emergencias	**Hemograma,** **EGO,** **Urocultivo** **PFR** **Ultrasonido de vías urinarias** RX simple abdomen	Si el paciente se encuentra con un episodio de cólico reno uretral se debe enviar a Urgencias para tratamiento analgésico.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
	Ha consultado 3 o más ocasiones al servicio de emergencias. Micro o macro hematuria			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Disfunción eréctil	Todo paciente que desee tratamiento por no poder obtener y mantener una erección sostenida con rigidez suficiente para permitir relaciones sexuales satisfactorias y que afecte su autoestima y relación de pareja. Se deben corregir o controlar factores causantes antes de enviar a valoración: ▪ SOBREPESO ▪ SEDENTARISMO ▪ FUMADO ▪ OH ▪ DROGAS ▪ DISLIPIDEMIA ▪ HTA ▪ DM -Haber corregido el sedentarismo. -Suspendido el tabaco -No abusar de las bebidas alcohólicas -Haber corregido cualquier farmacodependencia. Antecedentes personales patológicos: ▪ Dislipidemia: haberle dado tratamiento y logrado un perfil de lípidos normal ▪ HTA: compensada, ▪ Diabetes Mellitus: cifras de glicemia menores a 140 mg/dl y Hb glicosilada menos del 7%. Historia medicamentosa: haber suspendido todo tratamiento medicamentoso que interfiera con el mecanismo de erección.	Cupo	**Control de PA** **HBA1C** **Controles de Glicemia** **Perfil lipídico** **Testosterona sérica y libre**	Medicamentos que interfieren con el mecanismo de erección: Antihipertensivos Atenolol Propanolol Antipsicóticos tioridazina. Antidepresivos Imipramina Fluoxetina Simpaticolíticos de acción central Clonidina Metildopa Diuréticos Hidroclorotiazida Espirinolactona Otros Cimetidina Famotidina Ketoconazol Digoxina Glucocorticoides. Enfermedad de Peyronie, Curvatura anormal del pene. Síntomas de vías urinarias bajas resolver antes de referir al paciente.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Infertilidad	Pareja con fracaso de conseguir un embarazo pese a mantener relaciones sexuales frecuentes por 1 año sin utilización de métodos anticonceptivos.	Cupo	**Espermograma** **US testículo**	Se debe evaluar la infertilidad de origen femenino concomitantemente
Epididimitis y orquitis aguda	Referencia al servicio de urgencias.	Urgencias	No requiere	
Hiperplasia prostática benigna	Todo paciente con síntomas del tracto urinario inferior. (LUTS) Score de la asociación americana de urología Referir score entre 8 a 35.	Cupo	**EGO** **APE** **TR** **Urocultivo, Hemograma,** **PFR** **US de vías urinarias (no imprescindible) que especifique: grosor de la pared vesical, volumen de orina residual mayor a 50cm cúbicos**	Deberá anotarse en la referencia: escala de síntomas IPSS y tiempo de evolución, Antecedente de gonorrea o trauma uretral por caída a horcajadas. Esta entidad diagnosticada por ultrasonido o tacto rectal en un paciente que carece de síntomas prostáticos no amerita ser referida a un especialista en urología.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Incontinencia urinaria femenina	Referir toda paciente con fuga urinaria de esfuerzo importante. (3 o más protectores diarios) Alteración actividades básicas de vida diaria. Referir incontinencia de urgencia para valoración con urodinamia.	Cupo	**Cistografía retrograda aunque no esta obligatorio este criterio lo rechazan si no se aporta**	Anotar repercusión sobre calidad de vida. Examen físico ginecológico Prolapsos de órgano pélvico sin asociación de incontinencia urinaria referir a ginecología.
Orquialgia	Referir a la consulta externa dolores testiculares de más de 1 mes de evolución.	Cupo	**US escrotal**	anotar examen físico de la bolsa escrotal orquialgias agudas referir SERVICIO DE URGENCIAS.
Sepsis urinaria a repetición	Pacientes con infección recurrente confirmada por urocultivo que persista a pesar de las siguientes indicaciones: ▪ Micción cada 3 horas ▪ Uso ropa íntima de algodón ▪ Evitar ropa ajustada y de tela gruesa ▪ Micción postcoital, ▪ Ingesta al menos 2 litros de agua/día ▪ Estrógenos vaginales en la postmenopáusica ▪ Corrección de estreñimiento, ▪ Tratar focos infecciones de origen vaginal ▪ Tratar al sobrepeso, ▪ En DM normalizar glicemias	Cupo	**Hemograma,** **Glicemia** **BUN** **Creatinina** **Urocultivo** **Ultrasonido de vías urinarias**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
Prostatitis	En caso de que paciente no mejore a tratamiento por el 1 nivel de atención o presente afectación al estado general es recomendable enviar a Urgencias para iniciar tratamiento antibiótico intravenoso	REFERIR servicio urgencias		Se debe realizar un examen general de orina, urocultivo, hemoleucograma e iniciar tratamiento empírico con Trimetroprim-sulfametoxazol 21 días.
Patología escrotal	Para valorar en consulta Urológica a cupo, se envían con examen físico y ultrasonido escrotal (si está disponible) a la consulta		Para valoración de emergencia (se refieren a servicio de emergencias)	
	Hidrocele Quiste de epidídimo Varicocele: si es un paciente menor de 30 años enviar con espermograma.		Torsión testicular o trauma escrotal Orquiepididimitis Sospecha de Cáncer testicular: a cualquier edad se debe enviar para realizar Ultrasonido de emergencia. Absceso escrotal	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

PATOLOGÍA	CRITERIO DE REFERENCIA	GRADO DE PRIORIDAD	EXÁMENES PREVIOS	OBSERVACIONES
HEMATURIA	Macroscópica: Se envía a servicio de emergencias para valoración urológica de emergencia		Microscópica: Se refieren cuando se considera que la causa de la hematuria es por una anomalía en la vía urinaria (usualmente un proceso obstructivo). **Se refiere con:** ▪ **Historia clínica** ▪ **(importante valorar si paciente es hipertenso o diabético)** ▪ **Examen físico** ▪ **Pruebas de función renal** ▪ **Examen general de orina** ▪ **(hematuria se considera cuando hay más de 5 eritrocitos por campo)** ▪ **Urocultivo** ▪ **Ultrasonido de vías urinarias radiología no realizas mientras persista hematuria**	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

CRITERIOS DE REFERENCIA

ESPECIALIDAD DE VASCULAR PERIFERICO

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE VASCULAR PERIFERICO

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Indicaciones generales

1. Las referencias deberán cumplir con los lineamientos para la asignación de citas a pacientes se refieren para la atención de medicina especializada indicados por la gerencia médica.

2. Toda referencia debe incluir:
   Nombre del centro de procedencia, nombre del médico que refiere y fecha.
   Ficha de identificación del usuario, edad, estado civil, condición laboral y escolaridad
   Antecedentes patológicos, sintomatología tiempo de evolución y tratamiento recibido
   Antecedentes personales no patológicos, transfusiones realizadas, uso de drogas ilícitas y alergia a medicamentos.
   Antecedentes Heredofamiliares
   Antecedentes Quirúrgicos
   Examen físico completo

3. Adjuntar examen de laboratorios (**fotocopia**) y gabinete efectuados (según sea el caso). En caso de US dejar la copia en el expediente clínico del EBAIS y el paciente lleve el original al especialista (visualizando las fotografías del US).

4. Justificación clara del motivo de referir a este paciente. Diagnóstico claro por el cual se refiere al paciente, o en su defecto una impresión diagnóstica, que deje entrever la necesidad de resolver el caso en un segundo nivel de atención, y por qué se agotó la capacidad resolutiva del primer nivel.

5. Los casos considerados como cita prioritaria deben ser comentados a especialistas, de no localizarlo deben referir a la Jefatura de Consulta Externa para su canalización respectiva e indicar que no fue se logró ubicar al médico.

GUIAS DE REFERENCIA - SERVICIO DE VASCULAR PERIFERICO CRITERIOS DE REFERENCIA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Pie diabético	• Referir todo paciente que presente una lesión aguda en pie. (Toda erida punzo cortante) • Lesiones abiertas crónicas complejas en pie con signos de infección o ante la duda del médico general. • Grado 1 en delante de la clasificación de Wagner. • Paciente con cirugía o Lesión previa sin datos de sepsis o lesión aguda.	• Servicio de urgencias según criterio medico • A consulta externa con prioridad	**En paciente con posibilidad de ser operados, referir con valoración pre operatorio. En los centros de salud donde cuenten con Médico Internista y/o Emergenciólogo.** **La valoración preoperatoria es definitivamente del nivel hospitalario**	No iniciar tratamientos en pacientes con lesiones en pies diabéticos, referir prioritariamente.
Ulceras venosas o atípicas	Ulcera venosa complicada.	Referir pacientes a consulta externa con prioridad	**No requiere**	
Isquemias agudas	Pacientes con dolor intenso del miembro inferior, asociado a palidez, diminución de llenado capilar y frialdad de inicio reciente. Con pérdida o disminución importante de los pulsos distales	Servicio de urgencias	No requiere	Referir con la mayor prioridad posible para ser atendido cuanto antes.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Isquemias crónicas o insuficiencias arteriales crónicas	Claudicación intermitente en sus diferentes grados	• A consulta externa con prioridad • Servicio de urgencias si es discapacitante	No requiere	Referir ante la sospecha diagnostica.
Trombosis venosa profunda	Sospecha clínica de la patología	Referir al servicio de urgencias	**US dúplex si es posible venoso del miembro afectado**	Referir al servicio de urgencias si cumple con dos o más criterios de Wells.
Varicorragia	Ante la presencia de sangrado agudo tras la ruptura de una varice, referir	Referir al servicio de urgencias	No requiere	Realizar hemostasia con vendaje elástico y enviar al servicio de emergencias
Post operatorios complicados	Referir todos al servicio de urgencias	Referir al servicio de urgencias	**Hemograma** **PCR**	Curación simple y referir con vendaje oclusivo.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA

Patología	Criterio de Referencia	Grado de prioridad	Requisitos y exámenes previos	Observaciones
Trauma vascular	Ante la sospecha de trauma vascular mayor referir de inmediato a urgencias con vendaje compresivo	Referir al servicio de urgencias	No requiere	Vendaje compresivo
Enfermedad varicosa	Referir todos los casos de enfermedad varicosa sin complicaciones agudas Referir todos los casos de enfermedad varicosa sin complicaciones agudas	Referir a la consulta externa Referir a emergencias	No requiere	Recomendar el uso de vendaje elástico, al menos hasta la rodilla.
Artropatía de Charcot	***Este diagnóstico corresponde a Ortopedia	***Este diagnóstico corresponde a Ortopedia	***Este diagnóstico corresponde a Ortopedia	***Este diagnóstico corresponde a Ortopedia.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICA
Tel. 2758-1803, Fax. 2758-3853, Apdo. 502-7300
Correo electrónico: corr_2699@ccss.sa.cr // drsmha@ccss.sa.cr
PUERTO LIMON, COSTA RICA